AULA CLÍNICA — SEMIOLOGÍA I

Manual de sistema digestivo

La unidad que el profesor define como una de las más preguntadas en parciales y finales: motivos de consulta, examen físico, síndromes del tubo digestivo, hígado, páncreas, vías biliares y emergencias.

- Vómitos, disfagia y dispepsia
- Dolor abdominal y abdomen agudo
- Diarrea, constipación y trastornos anorrectales
- Ictericia
- Examen físico del aparato digestivo
- Síndrome esofágico
- Síndrome ulceroso y gastritis
- Síndrome pilórico e íleo
- Malabsorción e intestino irritable
- Peritonitis
- Síndromes vesiculares
- Hemorragias digestivas
- Cirrosis e hipertensión portal
- Insuficiencia hepática
- Pancreatitis aguda

Versión del 9 de noviembre de 2026 · 15 capítulos publicados · Material original elaborado a partir de las clases del Dr. Ortega y su libro de Clínica Médica I.

CAPÍTULO 1

Vómitos, disfagia y dispepsia

Lo que pregunta el profe en los motivos de consulta del tubo digestivo alto, con el porqué para defenderlo.

NECESITÁS SABER

- Hemoptisis (1.er parcial)
- Agua, potasio y ácido-base

Motivos de consulta del tubo digestivo alto

Según el profe, digestivo es **una de las unidades más preguntadas** en parciales y finales. De este bloque se toman sobre todo **tipos de vómito**, **hematemesis vs hemoptisis**, **Mallory-Weiss** y la **acalasia**.

Vómito
Definiciones · Tipos y horario ★ · Hematemesis vs hemoptisis ★

Complicaciones
Alcalosis + hipopotasemia · Mallory-Weiss (tríada) ★ · Boerhaave

Disfagia
Alta vs baja · Mecánica vs motora · Acalasia ★

Dispepsia
Roma · 2 D + P · Signos de alarma

AL TERMINAR VAS A PODER

- Clasificar un vómito por contenido y horario.
- Dibujar el cuadro hematemesis vs hemoptisis.
- Decir la tríada de Mallory-Weiss y las complicaciones del vómito con su porqué.
- Reconocer la acalasia y los signos de alarma de una dispepsia.

Vómito, náusea y lo que no es vómito

MUY IMPORTANTE

> Primero confirmar que es un vómito: si sube sin esfuerzo, no lo es.

TÉRMINO	QUÉ ES
Vómito (emesis)	Expulsión **activa** por la boca del contenido gástrico o duodenal.
Náusea	Deseo de vomitar; casi siempre precede al vómito.
Arcadas	Contracciones del abdomen que preceden al vómito.
Regurgitación	El contenido vuelve a la boca **sin esfuerzo**.
Rumiación	Vuelve a la boca y el paciente **lo traga de nuevo**.
Hematemesis	Vómito de sangre: siempre sangrado **alto** (esófago, estómago, duodeno).

ÉNFASIS DEL PROFESOR

Lo habitual es que consulten por náuseas y vómitos juntos; un vómito **sin náuseas previas** es llamativo.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 13:51

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 14:31 Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 389

Tipos de vómito y horario

IMPRESCINDIBLE

> El contenido dice de dónde viene; el horario orienta la causa.

SE PREGUNTA

Cómo era el vómito y en qué momento apareció: «...les pueden preguntar».

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 16:21



Vómito alimenticio

Aspecto: Alimentos casi enteros, sin digerir y con poco ácido.

De dónde viene: Esófago (nunca llegó al estómago).

Pensar en: Acalasia, estenosis, divertículo; suele acompañarse de opresión retroesternal.

Elegí un tipo para ver de qué tramo viene.

Tipos de vómito por contenido

	Aspecto	Origen / pensar en
ALIMENTICIO	Comida casi entera, poco ácido	Esófago
PARCIALMENTE DIGERIDO	Ácido, con restos	Estómago: gastroparesia, obstrucción pilórica

BILIOSO	Amarillo-verdoso, **amargo**	Causas pancreáticas, hepáticas y biliares
HEMÁTICO	**Rojo** = sangrado activo · **borra de café** = sangre digerida	Primero descartar **úlcera**; várices, Mallory-Weiss, cáncer
FECALOIDE	Marrón, olor fecal	Obstrucción intestinal baja · fístula gastrocólica

AL DESPERTAR, EN AYUNAS

Embarazo · Alcohol · HTE

Las tres causas más frecuentes que remarca el profesor: embarazo, haber tomado alcohol la noche anterior, hipertensión endocraneana.

≈ 1 HORA DESPUÉS DE COMER

Estómago

Gastritis, úlcera, distensión gástrica.

VARIAS HORAS DESPUÉS

Píloro

Vómito de retención con alimentos de comidas previas: síndrome pilórico.

POR LA NOCHE

Organicidad

El vómito nocturno casi siempre obedece a una causa orgánica.

Horario del vómito.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

Por la mañana en ayunas: pensar siempre en **embarazo, alcohol la noche anterior o hipertensión endocraneana**. Una hora después de comer → estómago; varias horas después → píloro. **En chorro sin náuseas** con cefalea → **HTE**. Si al vomitar **calma el dolor** → úlcera.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 19:13 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 21:54 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 22:35

¿Por qué? Fisiopatología (libro)

CAUSA
Obstrucción del tubo digestivo

→

MECANISMO
El contenido no avanza y refluye desde el nivel de la obstrucción

→

MANIFESTACIÓN
Vómitos **alimentarios → biliosos → fecaloides** según el nivel (p. 377)

En el **síndrome pilórico** el estómago no se vacía: el vómito aparece **4 a 6 horas después de comer**, con alimentos retenidos (p. 375). Por eso “varias horas después → píloro”.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 15:51 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 17:13 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 18:33 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 19:13 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 375 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 377

Hematemesis vs hemoptisis

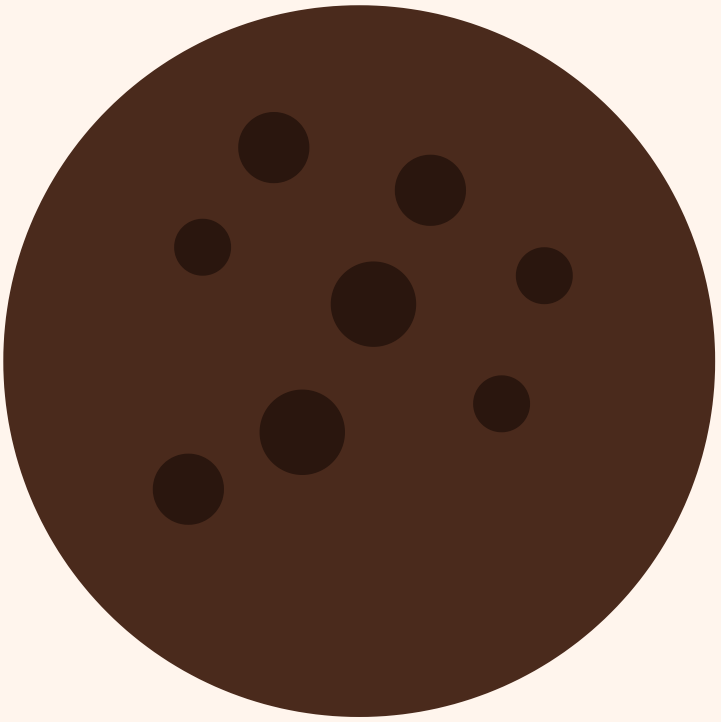
IMPRESCINDIBLE

> El cuadro que el profe pide de memoria.

PREGUNTA DE PARCIAL

«Diagnóstico diferencial con hemoptisis, pregunta de parcial... por favor ese cuadrito tienen que sabérselo.»

FUENTE Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 08:08 · Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 08:24

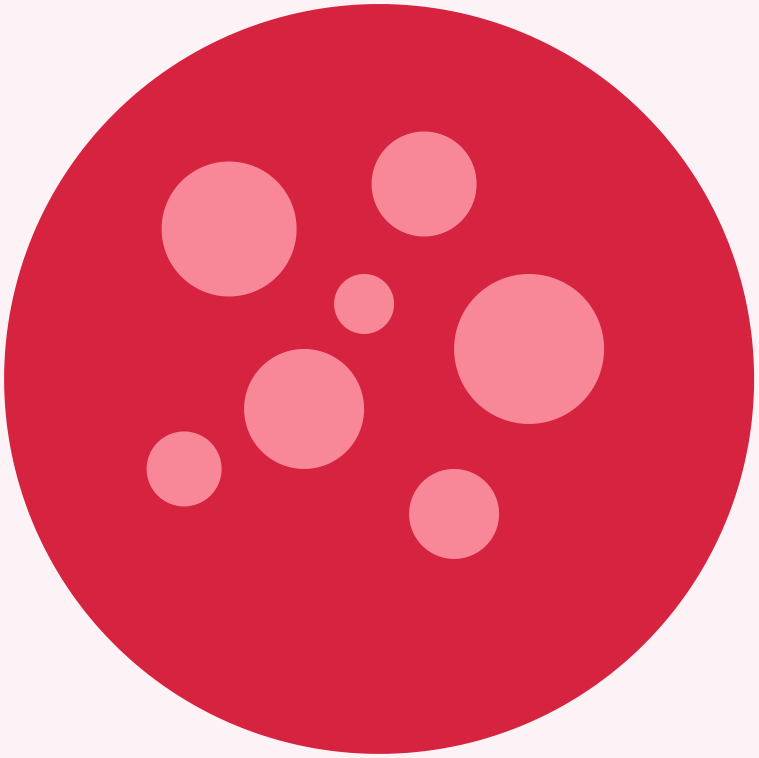


Hematemesis

tubo digestivo alto

SALE CON	el vómito (antes, náuseas)
ASPECTO	oscura, borra de café, coágulos, restos de comida
REACCIÓN	ácida
DESPUÉS	melena
ANTECEDENTES	digestivos

VS



Hemoptisis

vía aérea inferior / pulmón

SALE CON	la tos (antes, cosquilleo laríngeo)
ASPECTO	roja rutilante, espumosa
REACCIÓN	alcalina
DESPUÉS	esputo hemoptoico, sin melena
ANTECEDENTES	respiratorios

El cuadro, para memorizar visualmente.

¿Por qué? Fisiopatología (libro p. 75)

- **Oscura en la hematemesis:** el ácido del estómago transforma la hemoglobina en **hematina ácida** (borra de café).
- **Espumosa en la hemoptisis:** la sangre viene mezclada con **aire** de la vía aérea; reacción **alcalina**.
- **Melena después de una hematemesis:** la sangre que pasa al intestino se digiere y sale con la materia fecal.

NOTA

La reacción **alcalina** corresponde a la **hemoptisis** (sangre del pulmón, sin contacto con el ácido); la hematemesis es **ácida**. Respondé con el cuadro del libro (p. 75).

FUENTE Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 75

FUENTE Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 08:08

Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 75

Complicaciones del vómito y Mallory-Weiss

IMPRESCINDIBLE

> Se pierden ácido, agua y potasio; el esfuerzo puede romper el esófago.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

Las complicaciones del vómito se preguntan en la cátedra: se pierde ácido y potasio — **hipopotasemia** y **alcalosis metabólica**— además de líquido.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 23:15

METABÓLICAS

Alcalosis + hipopotasemia

Y **deshidratación** (taquicardia, hipotensión).

RESPIRATORIA

Neumonitis química

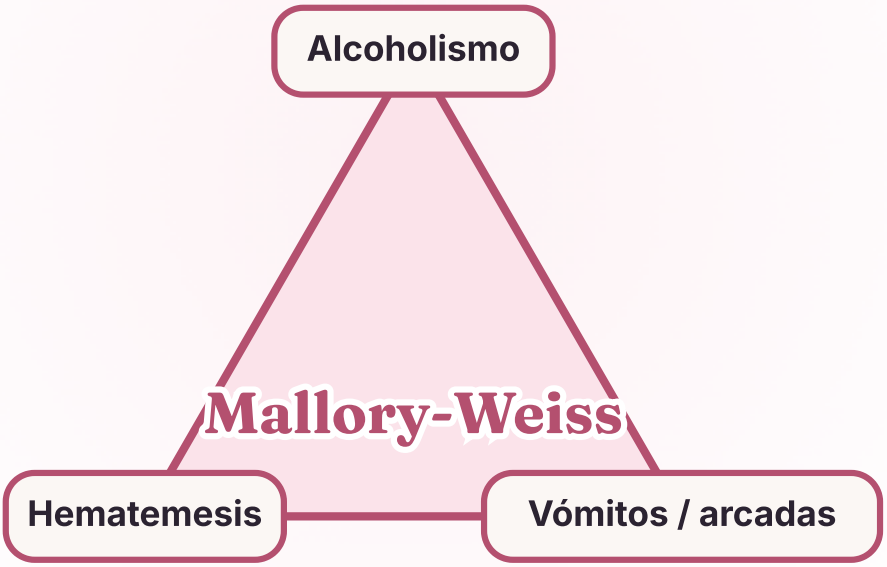
Aspira el vómito → **neumonía aspirativa** (puede matar).

ESÓFAGO

Mallory-Weiss · Boerhaave

Desgarro de la **mucosa** · rotura de **todo el espesor**.

Tríada de Mallory-Weiss



Desgarro **lineal de la mucosa de la unión esofagogástrica**. La tríada es también su **cronología**: toma alcohol → vomita → vomita sangre.

FUENTE Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 16:48 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 24:37 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 390

Se pierde por la boca

- **Ácido clorhídrico** (H^+ y Cl^-)
- **Agua y sodio**
- Algo de potasio

↓

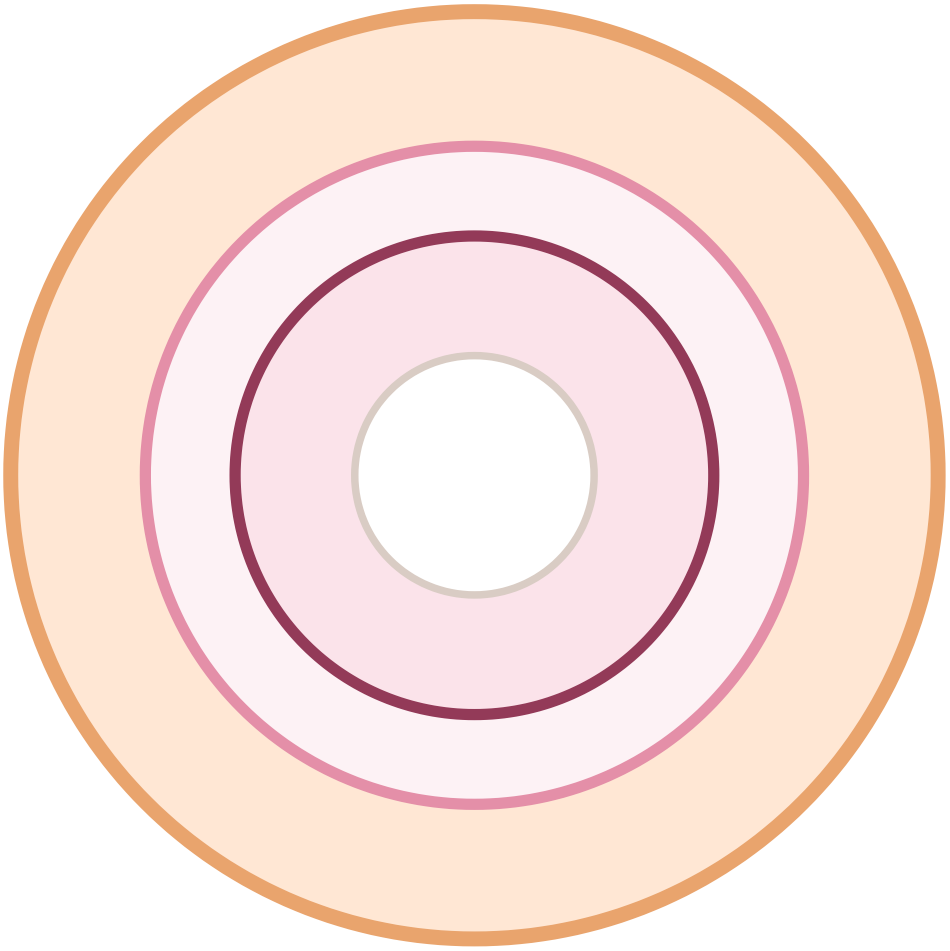
El organismo responde

- Sin H^+ que neutralizar, sube el bicarbonato.
- La hipovolemia activa la aldosterona: el riñón retiene sodio y elimina potasio.

↓

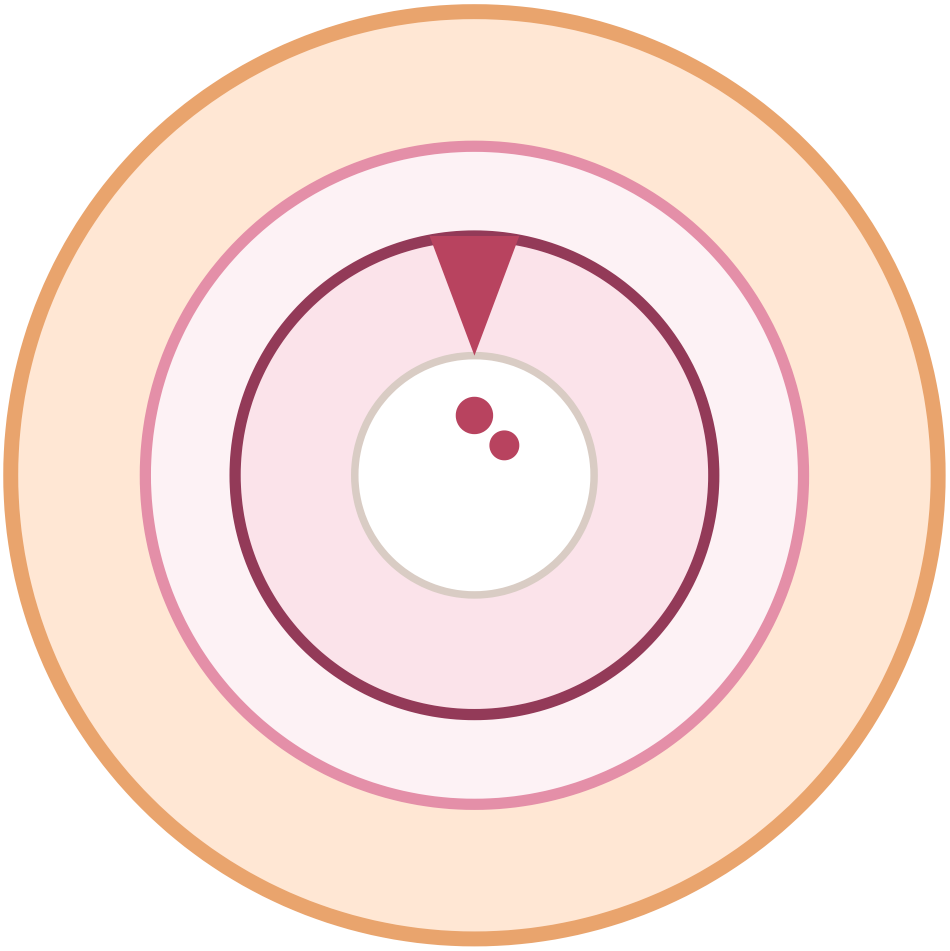
Resultado

- **Alcalosis metabólica**
- **Hipopotasemia** (la mayor pérdida es renal)
- **Deshidratación**: taquicardia, hipotensión



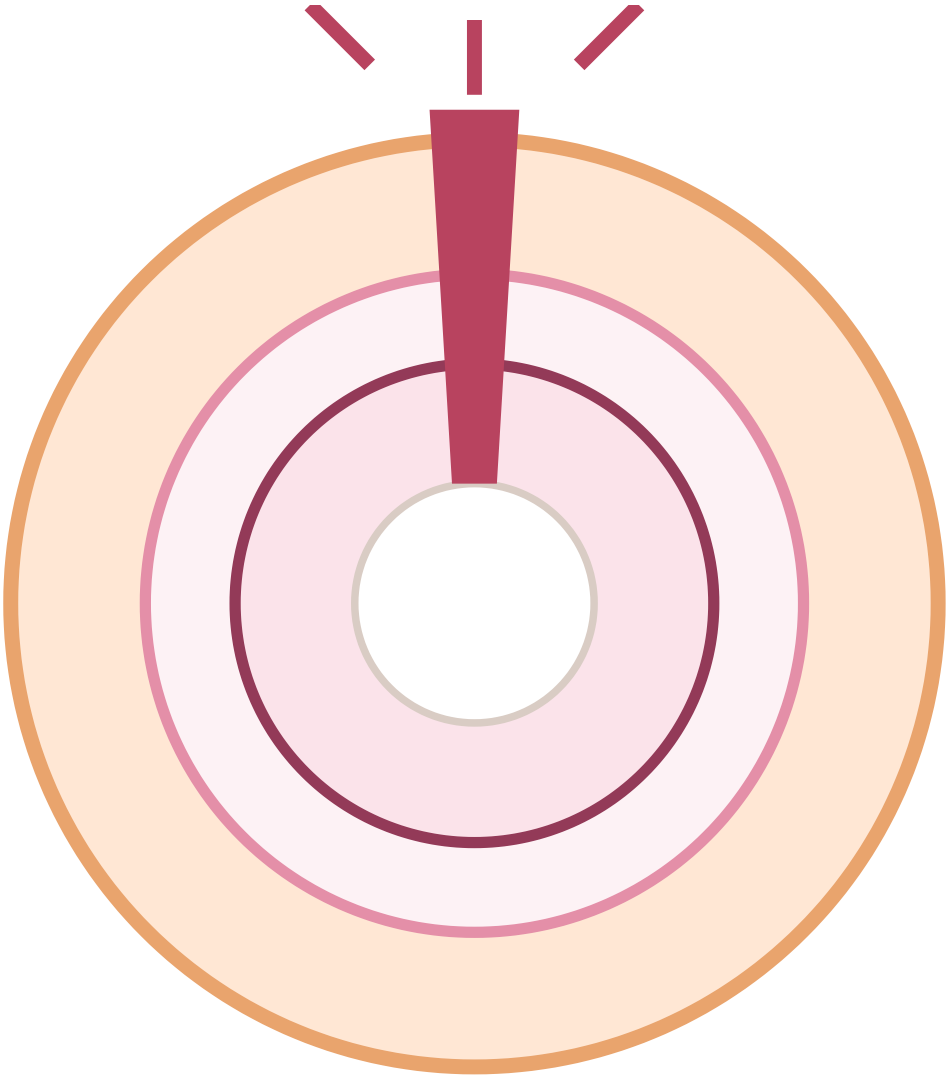
mucosa · submucosa · muscular

Pared esofágica normal



mucosa · submucosa · muscular

Mallory-Weiss: desgarro de la *mucosa* de la unión gastroesofágica por arcadas o vómitos intensos (típico del alcohólico) → hematemesis.



mucosa · submucosa · muscular

Boerhaave: rotura de *todo el espesor* del esófago → el contenido pasa al mediastino (mediastinitis). Emergencia.

Arriba lo metabólico; abajo, mucosa (Mallory-Weiss) vs todo el espesor (Boerhaave).

¿Por qué? Fisiopatología (libro p. 377)

CAUSA
Vómitos repetidos

→

MECANISMO
Pérdida de agua, cloro (HCl) y potasio

→

MANIFESTACIÓN
Deshidratación, hipopotasemia y alcalosis
(si predomina la pérdida de cloro)

Si se pierden sobre todo líquidos alcalinos (intestinales), puede haber acidosis; en el vómito gástrico predomina la pérdida de cloro: **alcalosis**.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 23:15 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 24:37 · Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 16:48 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 377 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 390

El paciente que vomita: examen y laboratorio

COMPLEMENTARIO

C E U C G O

Tocá para desplegar

«...pero no hay que olvidar nunca el **ionograma**» (hipopotasemia, alcalosis). En mujeres, **test de embarazo**.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 30:28 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 30:48

- Signos vitales y de **deshidratación**.
- **Chapoteo gástrico** a la palpación → síndrome pilórico.
- Examen neurológico y **fondo de ojo** → hipertensión endocraneana.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 28:39 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 29:19 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 30:00

Disfagia: alta o baja, mecánica o motora

MUY IMPORTANTE

> Dificultad para pasar el alimento de la boca al estómago. Primero: ¿dónde se traba? Después: ¿con qué alimento?

ÉNFASIS DEL PROFESOR

"Estas características no pueden olvidarse" (orofaríngea): no puede **iniciar** la deglución, **regurgita** por boca o nariz, **tos** y ahogo por aspiración, disfonía.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 03:42

Orofaríngea = alta = de transferencia

- No puede **iniciar**; señala la garganta
- Tos, ahogo, regurgitación nasal
- Más difícil con **líquidos**
- ≈75 % neuromuscular: **ACV n.º 1**, Parkinson

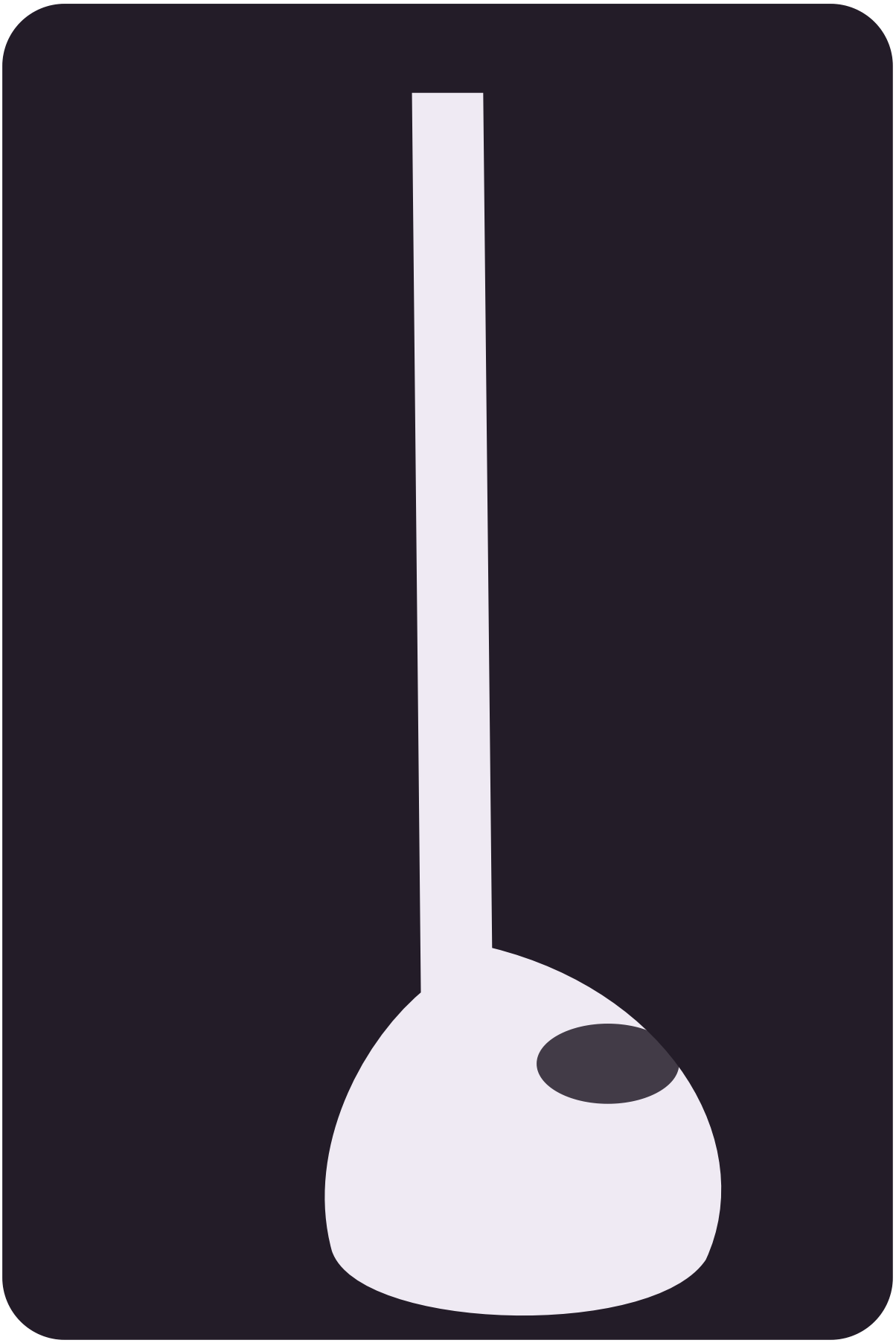
Esofágica = baja = de transporte

- Traga bien y **después** se traba
- Atascamiento **retroesternal**
- **Mecánica**: solo sólidos, progresiva (estenosis péptica n.º 1, cáncer)
- **Motora**: sólidos y líquidos, intermitente (acalasia, espasmo, esclerodermia)

LA QUE SIEMPRE SUELEN PREGUNTAR

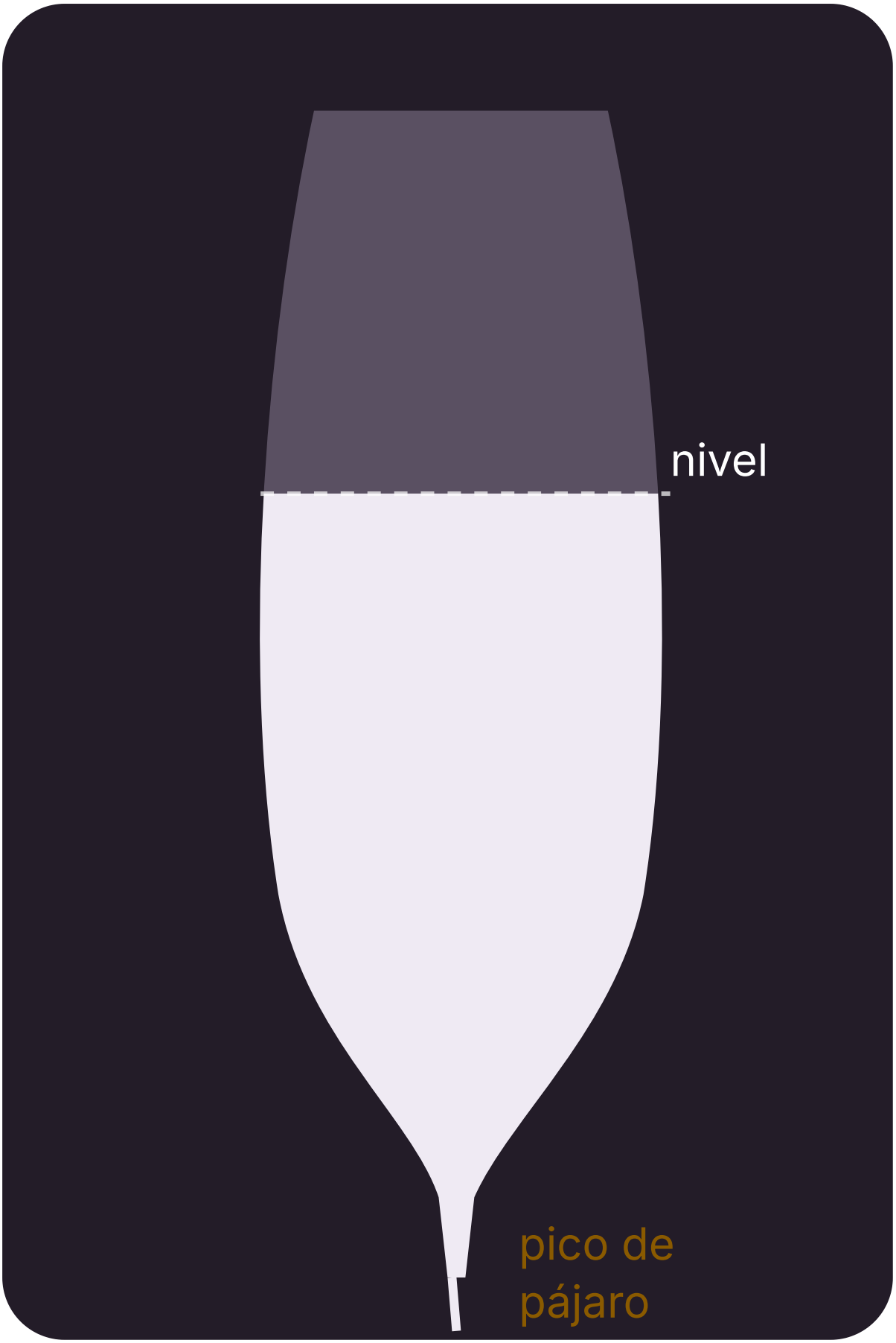
Disfagia **intermitente y lentamente progresiva para sólidos y líquidos**, con regurgitación → **acalasia**. Esofagograma: **pico de pájaro**; cáncer: **manzana mordida**.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 21:30 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 24:50 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 25:31



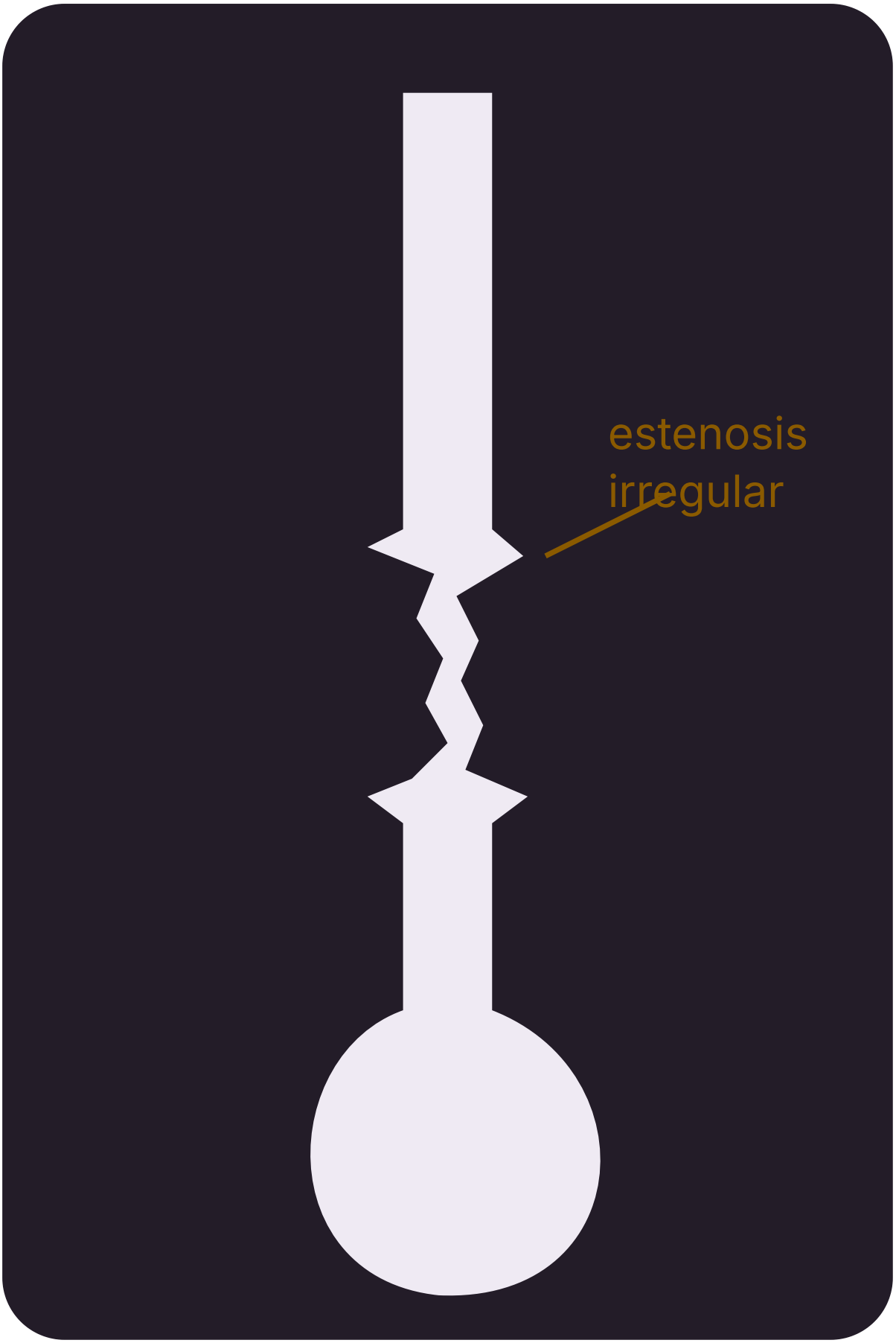
Normal

Calibre uniforme; burbuja de aire gástrico.



Acalasia

Dolicomegaesófago con nivel hidroaéreo y afinamiento liso “en pico de pájaro” (o cola de ratón).



Cáncer de esófago

Estrechez irregular y abrupta, con bordes en “manzana mordida”; se confirma con endoscopía y biopsia.

Esofagograma con bario (esquemas propios).

¿Por qué? Fisiopatología de la acalasia (libro p. 369)

CAUSA
Alteración del **plexo mientérico de Auerbach** (idiopática o **Chagas**)

→

MECANISMO
Aperistalsis + el EEI **no se relaja** y aumenta su tono

→

MANIFESTACIÓN
El esófago se dilata (**dolicomegaesófago**): disfagia **primero a líquidos y luego a sólidos**, regurgitación, dolor torácico

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 00:49 · Clase MC Digestivo · parte 1 · min 03:00 · Clase MC Digestivo · parte 1 · min 05:47 · Clase MC Digestivo · parte 1 · min 10:06 · Clase MC Digestivo · parte 1 · min 12:48 · Clase MC Digestivo · parte 1 · min 13:28 · Clase MC Digestivo · parte 1 · min 16:08 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 368 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 369

Dispepsia: Roma, 2 D + P y signos de alarma

MUY IMPORTANTE

> El “dolor de la boca del estómago”: siempre del ombligo para arriba.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

“Se van a topar con dispepsia toda su vida.” Funcional (esencial, no ulcerosa) **60 %**; orgánica **40 %**, con la **úlcera péptica** como n.º 1.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 26:51 · Clase MC Digestivo · parte 1 · min 30:52 · Clase MC Digestivo · parte 1 · min 31:34

Roma (4 síntomas)	Plenitud posprandial · saciedad precoz · dolor epigástrico · ardor epigástrico
Tiempo	Últimos **3 meses**, con inicio **≥ 6 meses** antes (en clase: “90 días en 6 meses”); sin lesión estructural
Clínica: “las 2 D y la P”	**D**olor epigástrico · **D**istensión · **P**irosis
Alarma → endoscopía	> 55 años, pérdida de peso, hematemesis, vómitos persistentes, disfagia progresiva, ictericia, anemia, AINEs, antecedentes de cáncer

D D P

Tocá para desplegar

“Siempre digo las dos D y la P.”

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 07:34

Dispepsia
Interrogatorio completo: fármacos (AINEs), antecedentes, síntomas biliares o pancreáticos

¿≥ 55 años o algún signo de alarma?

SÍ
Endoscopía digestiva alta + biopsias
Busca úlcera, cáncer y H. pylori

NO
Test no invasivo de H. pylori

POSITIVO
Erradicar
Triple terapia “OCA”

NEGATIVO
IBP 4–6 semanas

SIN RESPUESTA
Reevaluar → endoscopía

Conducta: alarma → endoscopía; joven sin alarma → H. pylori.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 27:32 · Clase MC Digestivo · parte 1 · min 34:10 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 07:34 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 08:14 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 10:54

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Hematemesis vs hemoptisis

Para qué sirve: El cuadro que el profe pide de memoria.

	HEMATEMESIS	HEMOPTISIS
Sale con	Vómito	Tos
Color	Oscura / borra de café	Roja, espumosa
pH	Ácido	Alcalino
Después	Melena	—

Cómo interpretarlo: Náuseas, restos de comida y después melena: digestivo. Tos y espuma: respiratorio.

Mnemotecnia: Hemat-EMESIS = vómito · Hemop-TISIS = pulmón. — El nombre te dice de dónde viene: emesis es vómito; tisis remite al pulmón.

Tríada de Mallory-Weiss

Para qué sirve: Responder la pregunta del preguntero en una línea.

- **A**lcoholismo
- **V**ómitos
- **H**ematemesis
- Lesión: desgarro lineal de la mucosa esofagogástrica

Cómo interpretarlo: Es también la cronología: primero el alcohol, después los vómitos, al final la sangre.

Mnemotecnia: A-V-H: Alcohol → Vómito → Hemorragia. — En ese orden ocurren los hechos.

Tipos y horario del vómito

Para qué sirve: Clasificar un vómito como lo pide el profe.

- Contenido: **Entero** → **Ácido** → **Amargo** → **Fecal** (esófago → estómago → bilis → intestino bajo).
- Rojo = ahora; borra de café = antes.
- Matinal: **E**mbarazo, **A**lcohol, **H**TE · varias horas: píloro · chorro sin náuseas: HTE.

Cómo interpretarlo: Cuanto más "procesado" llega el contenido, más lejos se originó.

Mnemotecnia: "¡EAH, qué mañana!" — Vómito matinal = Embarazo, Alcohol, HTE.

Disfagia: dónde y con qué

Para qué sirve: Las dos preguntas que ordenan la disfagia.

- **Alta (transferencia):** se atraganta — tos, ahogo, nariz.
- **Baja (transporte):** se atasca detrás del esternón.
- **Solo sólidos** = mecánica · **sólidos + líquidos** = motora (acalasia).

Cómo interpretarlo: Primero el tramo, después el mecanismo.

Mnemotecnia: Arriba se ATRAGANTA, abajo se ATASCA · MURO o MOTOR. — Un muro deja pasar el agua pero no la piedra; un motor roto no empuja nada.

Dispepsia: 2 D + P y alarma

Para qué sirve: Clínica y conducta en dos reglas.

- **D**olor · **D**istensión · **P**irosis (regla del profe).
- Alarma: **VIDA que PESA** → **VEDA**: Vómitos, Ictericia, Disfagia, Anemia · Pérdida de peso, Edad > 55, Sangrado, AINEs/Antecedentes → endoscopía.

Cómo interpretarlo: Con cualquier signo de alarma, endoscopía digestiva alta.

Mnemotecnia: Una VIDA que PESA → VEDA — Mnemotecnia propia para los signos de alarma.

Integración: lo imprescindible

- **Hematemesis vs hemoptisis**: vómito/tos · borra de café/roja espumosa · ácida/alcalina · melena (cuadro del profe).
- **Tipos de vómito**: alimenticio, parcialmente digerido, bilioso, hemático, fecaloide; **horario**: matinal (embarazo, alcohol, HTE), varias horas (píloro).
- **Mallory-Weiss**: alcoholismo + vómitos + hematemesis; desgarro de la mucosa esofagogástrica.

- **Complicaciones del vómito**: alcalosis metabólica, hipopotasemia, deshidratación, aspiración, Mallory-Weiss, Boerhaave.
- **Acalasia**: sólidos y líquidos, lenta y progresiva, regurgitación; pico de pájaro.
- **Dispepsia**: Roma (4 síntomas), 2 D + P, alarma → endoscopía.

Desarrollos modelo

1. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial entre hematemesis y hemoptisis?

	HEMATEMESIS	HEMOPTISIS
Sale con	El **vómito** (precedida de náuseas)	La **tos** (cosquilleo laríngeo)
Aspecto	Oscura, **borra de café**, coágulos, restos alimentarios	**Roja rutilante, espumosa**
Reacción	Ácida	**Alcalina**
Después	**Melena**	Esputo hemoptoico, sin melena
Antecedentes	Digestivos	Respiratorios

Porqué: el ácido gástrico convierte la hemoglobina en hematina ácida (oscura); la sangre de la vía aérea viene con aire (espuma).

2. ¿Qué es el vómito? ¿Qué es la náusea? ¿Cómo se clasifican los vómitos?

Vómito: expulsión activa por la boca del contenido gastroduodenal. **Náusea:** deseo de vomitar. No confundir con la **regurgitación** (sin esfuerzo).

- **Por contenido:** alimenticio (esófago) · parcialmente digerido/ácido (estómago) · bilioso (pancreático, hepático, biliar) · hemático (rojo = activo; borra de café = digerido) · fecaloide (obstrucción baja).
- **Por horario:** matinal en ayunas → embarazo, alcohol, HTE · 1 h después de comer → estómago · varias horas → píloro · nocturno → orgánico.
- En **chorro sin náuseas** → HTE.

3. ¿Qué es el síndrome de Mallory-Weiss? Mencione su tríada.

Desgarro **lineal de la mucosa de la unión esofagogástrica** por vómitos o arcadas intensas. **Tríada (y cronología): alcoholismo → vómitos → hematemesis.**

No confundir con **Boerhaave**: rotura de **todo el espesor** del esófago, con paso al mediastino.

4. ¿Cuáles son las complicaciones del vómito y por qué se producen?

- **Hipopotasemia y alcalosis metabólica:** se pierden potasio y ácido clorhídrico (predomina la pérdida de cloro).
- **Deshidratación:** taquicardia, hipotensión.
- **Neumonitis química → neumonía aspirativa** si aspira el vómito.
- **Mallory-Weiss** (desgarro mucoso, hematemesis) y **Boerhaave** (rotura transmural).

5. Disfagia intermitente y lentamente progresiva para sólidos y líquidos, con regurgitación: ¿qué sospecha y por qué?

Acalasia (disfagia esofágica **motora**). Sólidos y líquidos porque falla el peristaltismo, no hay un obstáculo.

Porqué: alteración del plexo de Auerbach (idiopática o Chagas) → aperistalsis y EEI que no se relaja → dolicomegaesófago. **Esofagograma:** pico de pájaro; **manometría** confirma.

6. Diferencie disfagia orofaríngea de esofágica.

Orofaríngea (alta, de transferencia): no puede iniciar la deglución, señala la garganta, regurgita por boca o nariz, tos y ahogo; más con líquidos; ACV n.º 1.

Esofágica (baja, de transporte): traga y luego se traba detrás del esternón. **Mecánica:** solo sólidos, progresiva (estenosis péptica n.º 1). **Motora:** sólidos y líquidos, intermitente.

7. Defina dispepsia y mencione sus signos de alarma.

Dolor o malestar del **abdomen superior** con plenitud posprandial, saciedad precoz, dolor o ardor epigástrico (Roma: 3 meses, inicio ≥ 6 meses). Funcional 60 %, orgánica 40 % (úlcera n.º 1). Clínica: **dolor, distensión, pirosis**.

Alarma (→ endoscopía): > 55 años, pérdida de peso, hematemesis, vómitos persistentes, disfagia progresiva, ictericia, anemia, AINEs, antecedentes de cáncer.

Preguntas de repaso (choice)

1. Sangre roja rutilante y espumosa expulsada con la tos, de reacción alcalina, corresponde a:
    A. Melena.
    B. Epistaxis.
    C. Hematemesis.
    D. Hemoptisis.

2. Un vómito en **borra de café** indica:
    A. Sangre ya digerida por el ácido gástrico.
    B. Siempre hemoptisis deglutida.
    C. Origen colónico.
    D. Sangrado activo arterial.

3. Vómito de alimentos ingeridos varias horas antes, con chapoteo gástrico:
    A. Gastroenteritis.
    B. Hipertensión endocraneana.
    C. Embarazo.
    D. Síndrome pilórico.

4. Vómito matinal en ayunas. Las tres causas que remarca el profe son:
    A. Embarazo, alcohol la noche anterior e hipertensión endocraneana.
    B. Úlcera, gastritis y pancreatitis.
    C. Síndrome pilórico, íleo y apendicitis.
    D. Ménière, migraña y cinetosis.

5. Vómito en chorro, sin náuseas, con cefalea intensa: hay que pensar en
    A. Úlcera péptica.
    B. Hipertensión endocraneana.
    C. Gastroenteritis.
    D. Síndrome pilórico.

6. La tríada de Mallory-Weiss es:
    A. Disfagia, pérdida de peso y anemia.
    B. Dolor torácico, enfisema subcutáneo y vómitos.
    C. Dolor, vómitos y fiebre.
    D. Alcoholismo, vómitos y hematemesis.

7. Alteración esperable en un paciente con vómitos profusos:
    A. Acidosis respiratoria.
    B. Hipernatremia aislada.
    C. Alcalosis metabólica con hipopotasemia.
    D. Acidosis metabólica con hiperpotasemia.

8. ¿Qué diferencia a Mallory-Weiss de Boerhaave?
    A. Boerhaave no ocurre por vómitos.
    B. Mallory-Weiss: desgarro de la mucosa; Boerhaave: rotura de todo el espesor.
    C. Mallory-Weiss es transmural.
    D. Mallory-Weiss nunca sangra.

9. La disfagia orofaríngea también se llama:
    A. Globo histérico.
    B. Odinofagia.
    C. Alta o de transferencia.
    D. Baja o de transporte.

10. Disfagia esofágica **solo para sólidos**, continua y progresiva: orienta a
    A. Disfagia orofaríngea.
    B. Causa mecánica (obstructiva).
    C. Trastorno motor.
    D. Globo histérico.

11. Disfagia lentamente progresiva para sólidos y líquidos con regurgitación, en un paciente con Chagas:
    A. Acalasia.
    B. Estenosis péptica.
    C. Cáncer de esófago.
    D. Disfagia orofaríngea.

12. ¿Cuál es un signo de alarma en dispepsia?
    A. Eructos.
    B. Tener 30 años.
    C. Anemia.
    D. Pirosis ocasional.

13. La **zona quimiorreceptora gatillo** detecta fármacos y toxinas en la sangre porque:
    A. Provoca el vómito por sí sola.
    B. Está en el área postrema, sin barrera hematoencefálica.
    C. Está en la corteza cerebral.
    D. Recibe fibras del vago desde el estómago.

14. Un paciente vomita **bilis** con el estómago vacío. ¿Qué lo explica?
    A. La relajación del píloro durante la arcada.
    B. La onda antiperistáltica que lleva el contenido duodenal al estómago antes del vómito.
    C. Una hemorragia digestiva alta.
    D. Una obstrucción pilórica.

15. En la acalasia, el esófago se dilata porque:
    A. El esfínter inferior queda abierto.
    B. Falla la fase oral de la deglución.
    C. Pierde el peristaltismo y el esfínter inferior no se relaja.
    D. Un tumor obstruye la luz.

16. En la dispepsia funcional, la **secreción de ácido** suele estar:
    A. Ausente.
    B. Normal, con mayor sensibilidad de la mucosa.
    C. Muy aumentada siempre.
    D. Aumentada por una úlcera.

Respuestas

1. **D** — Correcto: viene de la vía aérea, con aire (espuma) y reacción alcalina.
2. **A** — Correcto: la hemoglobina se convirtió en hematina ácida.
3. **D** — Correcto: el estómago no vacía (vómito 4–6 h después).
4. **A** — Correcto.
5. **B** — Correcto.
6. **D** — Correcto (y es su cronología).
7. **C** — Correcto: pérdida de cloro (HCl) y potasio.
8. **B** — Correcto.
9. **C** — Correcto.
10. **B** — Correcto: un obstáculo deja pasar líquidos pero no sólidos.
11. **A** — Correcto: “lo que siempre suelen preguntar”.
12. **C** — Correcto: puede indicar cáncer o sangrado.
13. **B** — Correcto: sus capilares dejan pasar sustancias de la sangre.
14. **B** — Correcto: por eso un estómago vacío no impide vomitar y el vómito trae bilis.
15. **C** — Correcto: alteración del plexo de Auerbach.
16. **B** — Correcto: es la hipersensibilidad visceral.

CAPÍTULO 2

Dolor abdominal y abdomen agudo

De dónde viene el dolor, cómo se clasifica y los cinco abdómenes agudos quirúrgicos que el profe pide «como el Padre Nuestro».

NECESITÁS SABER

- Semiología del dolor (ALICIA)
- Peritoneo visceral y parietal

Abdomen agudo

Es un motivo de consulta **muy frecuente** («en la guardia veo 4 o 5 por día»). Y los **cinco abdómenes agudos quirúrgicos** son, en palabras del profe, **pregunta de parcial** que hay que saber «como el Padre Nuestro».

Tipos de dolor
Visceral · somático · referido · Compresión vs descompresión · Rebote

Clasificación
Agudo < 7 días · Médico · quirúrgico · inespecífico · Supraumbilical → ECG

5 quirúrgicos ★
Inflamatorio · obstructivo · Perforativo · hemorrágico · Vascular (el más letal)

Signos clave ★
Murphy (cronología y tríada) · Blumberg · Gueneau de Mussy · Jobert · Cullen · Grey-Turner

AL TERMINAR VAS A PODER

- Explicar por qué un dolor es visceral, somático o referido y cómo lo distingue la palpación.
- Nombrar los 5 abdómenes agudos quirúrgicos con su causa, su dolor y su signo clave.
- Diferenciar cronología y tríada de Murphy.
- Saber qué significan Jobert, Cullen y Grey-Turner (y por qué no son de pancreatitis).

Visceral, somático y referido

MUY IMPORTANTE

> Todo depende de qué peritoneo está irritado: el visceral duele al comprimir; el parietal, al soltar.

Los tres dolores

	Visceral	Somático (parietal)	Referido
NACE EN	Peritoneo **visceral** (el órgano)	Peritoneo **parietal**	Un órgano, pero se siente **lejos**
FIBRAS	**C**, amielínicas, lentas	**Aδ**, mielínicas, rápidas	Viscerales
CÓMO ES	Sordo, vago, **mal localizado**	Punzante, **bien localizado**; empeora al moverse	Lejano al sitio de origen
EXAMEN	Duele a la **compresión**	Duele a la **descompresión** (rebote)	—
EJEMPLO	Inicio de la apendicitis	Apendicitis ya en FID	Apendicitis → epigastrio; IAM inferior → «úlcera»

EL SIGNO DEL REBOTE

Si al **descomprimir** le duele **más** que cuando apretabas, hay compromiso del **peritoneo parietal**: es el **signo del rebote**.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 3 · min 03:46

¿Por qué? Fibras y mecanismos (libro p. 2)

CAUSA
Distensión (cólico), **isquemia** o **inflamación** de la víscera

→

MECANISMO
Fibras **C**: lentas, pocas y difusas

→

MANIFESTACIÓN
Dolor **vago, tardío, mal localizado**

CAUSA
La inflamación llega al **peritoneo parietal**

→

MECANISMO
Fibras **Aδ**: rápidas, con límites precisos

→

MANIFESTACIÓN
Dolor **agudo, punzante y localizado**

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 33:25 · Clase MC Digestivo · parte 3 · min 00:40 · Clase MC Digestivo · parte 3 · min 02:15 · Clase MC Digestivo · parte 3 · min 04:27 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 2

Agudo o crónico · médico, quirúrgico o inespecífico

MUY IMPORTANTE

> Abdomen agudo = síndrome cuyo síntoma cardinal es el dolor abdominal. No es la reagudización de un dolor crónico.

Abdomen agudo
Síndrome: el dolor es el síntoma cardinal

Por duración

Agudo < 7 días
Interconsulta con cirugía

Crónico > 7 días
Dispepsia, SII, úlcera, cólico biliar, pancreatitis crónica

Por etiología

Médico
Gastroenteritis, pielonefritis, cetoacidosis, IAM

★ **Quirúrgico**

Los 5 grandes

Inespecífico
Por exclusión; mujeres jóvenes

Del ombligo para arriba, siempre pensá en una causa extraabdominal (cardíaca o pulmonar).

SIEMPRE

Todo paciente con **dolor abdominal agudo por arriba del ombligo** (epigastrio o hipocondrios) lleva **electrocardiograma**: hay que descartar que se esté infartando. Más si es hipertenso, diabético, tabaquista.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 3 · min 14:58 · Clase MC Digestivo · parte 3 · min 15:40

ÉNFASIS DEL PROFESOR

Todo abdomen **agudo** lleva **interconsulta con cirugía**, «porque a veces nos podemos estar comiendo un cuadro quirúrgico».

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 3 · min 07:22

ABDOMEN AGUDO INESPECÍFICO

Dolor generalizado sin signos que lo definan: es un **diagnóstico por exclusión**. Se escribe «abdomen agudo inespecífico» y entre paréntesis lo que sospechás, y se piden estudios y seguimiento.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 3 · min 08:52 · Clase MC Digestivo · parte 3 · min 10:56

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 32:03 · Clase MC Digestivo · parte 3 · min 05:55 · Clase MC Digestivo · parte 3 · min 08:52 · Clase MC Digestivo · parte 3 · min 14:58

Los cinco abdómenes agudos quirúrgicos

IMPRESCINDIBLE

Inflamatorio · obstructivo · perforativo · hemorrágico · vascular. Para cada uno: causa, dolor y el signo que lo delata.

PREGUNTA DE PARCIAL

«Esto es pregunta de parcial... hay **cinco grandes abdómenes agudos quirúrgicos** que se tienen que saber **como el Padre Nuestro** y no se tienen que olvidar nunca.»

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 3 · min 17:02

El cuadro para estudiar (tapalo y decilo en voz alta)

	Causas	Dolor	Examen clave
INFLAMATORIO	Todo lo que termina en **-itis**: apendicitis, colecistitis, pancreatitis, diverticulitis	Progresivo, se localiza; luego **fiebre**	**Blumberg** · asa centinela
OBSTRUCTIVO	**Bridas**, hernias, tumores, vólvulos, invaginación	**Cólico** + vómitos, sin gases ni heces	**RHA de lucha** · distensión · timpanismo
PERFORATIVO	**Úlcera** y **apendicitis** perforadas	**Súbito**, intenso, generalizado	**Tabla** · **Jobert** · RHA ausentes
HEMORRÁGICO	**Embarazo ectópico** (1.ª), aneurisma de aorta, trauma	Dolor + **hipovolemia**	**Matidez** · abdomen **blando** · Cullen / Grey-Turner
VASCULAR	Isquemia **mesentérica** (trombosis, embolia)	Progresivo, **no calma con analgésicos**	Lactato > 2 · **el más letal**

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 3 · min 17:42 · Clase MC Digestivo · parte 3 · min 28:40 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 00:01 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 06:41 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 13:04

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 3 · min 17:02 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 25:28

Inflamatorio: apendicitis y la tríada de Murphy

IMPRESCINDIBLE

El más frecuente. Cronología (recorrido del dolor) y tríada (secuencia de síntomas) son dos cosas distintas.

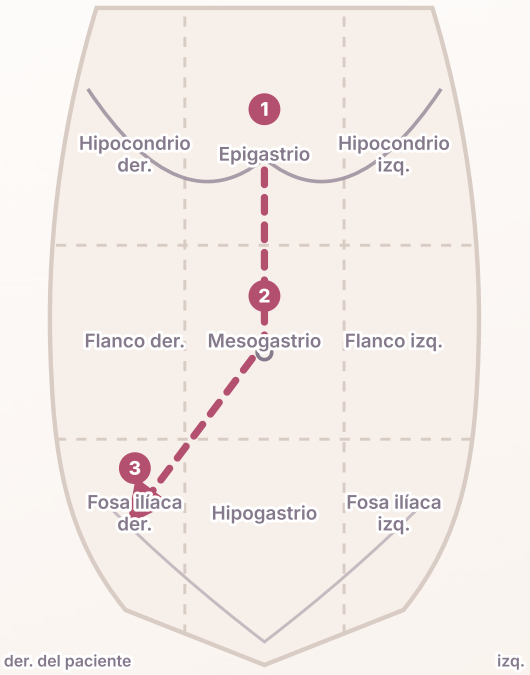
ÉNFASIS DEL PROFESOR

«Hay dos cosas importantes que quiero que diferencien: **cronología de Murphy** y **tríada de Murphy**.»

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 3 · min 20:25

Dónde mirar en el abdomen

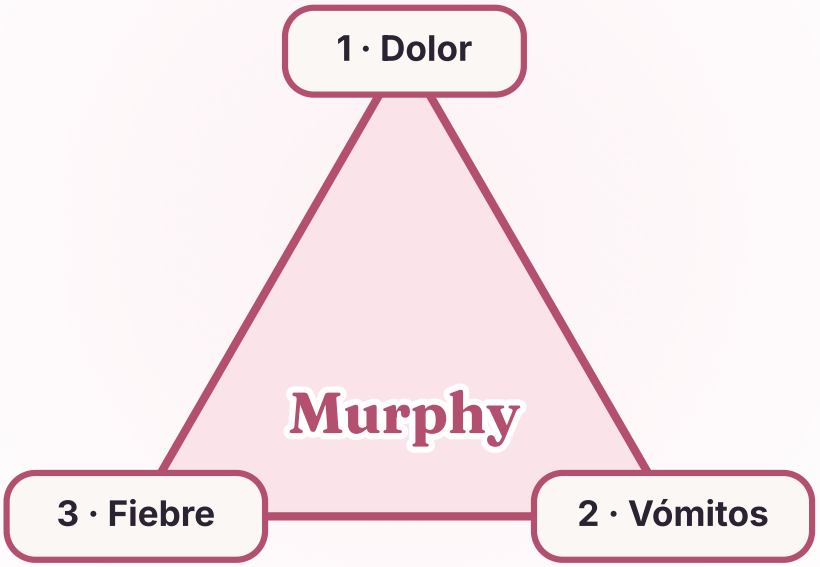
Cronología de Murphy | Punto de McBurney | Blumberg vs Gueneau de Mussy | Colecistitis aguda



Cronología de Murphy

El dolor empieza en el **epigastrio**, baja a la región **periumbilical** y termina en la **fosa ilíaca derecha**. Visceral (referido) → somático: cuando se localiza, ya está tomado el peritoneo parietal.

Tríada de Murphy (apendicitis)



El **orden** importa: si la fiebre aparece **antes** del dolor, pensá en una gastroenteritis; **después** del dolor, en un abdomen agudo **inflamatorio**.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 3 · min 21:10 Clase MC Digestivo · parte 4 · min 19:19

Evolución de la apendicitis

ESTADIO 1
Congestiva (catarral)
Puede empezar con tratamiento médico

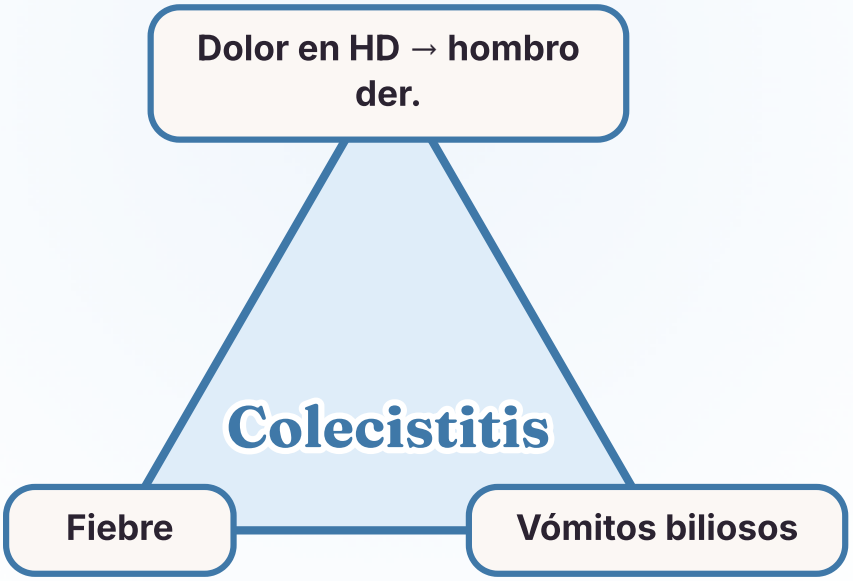
ESTADIO 2
Flegmonosa (supurada)

ESTADIO 3
Gangrenosa

ESTADIO 4
Perforada
Peritonitis → abdomen agudo **perforativo**

Causa más frecuente: obstrucción de la luz por un **fecalito**. La apendicitis y la colecistitis aguda se operan en el ~97 % de los casos.

Colecistitis aguda



La ictericia **puede o no** estar: aparece cuando un cálculo se escapa y obstruye la **vía biliar** (colédoco).

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 3 · min 23:56 · Clase MC Digestivo · parte 3 · min 24:36

ASA CENTINELA

El órgano inflamado paraliza el intestino vecino: **íleo paralítico localizado** = **asa centinela**. Si el íleo es generalizado, pensá en peritonitis o perforación.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 3 · min 26:38 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 27:30

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 3 · min 17:42 · Clase MC Digestivo · parte 3 · min 20:25 · Clase MC Digestivo · parte 3 · min 21:50 · Clase MC Digestivo · parte 3 · min 22:31 · Clase MC Digestivo · parte 3 · min 23:15 · Clase MC Digestivo · parte 3 · min 27:59

Obstructivo mecánico

IMPRESCINDIBLE

> Hay un obstáculo: por arriba, lucha; por abajo, silencio.

MÁS FRECUENTES

Bridas y hernias

Las **bridas** aparecen después de una cirugía abdominal: buscá **cicatrices**.

INTRALUMINAL / PARIETAL

Tumores

Una neoplasia que crece y no deja pasar el bolo fecal.

POR COMPROMISO VASCULAR

Vólvulo · invaginación

Invaginación: un segmento se mete dentro de otro; típica de **2 meses a 6 años**.

NO CONFUNDIR: MECÁNICO VS PARALÍTICO

Íleo mecánico (obstructivo)

- Hay **obstáculo**
- Dolor **cólico**
- RHA **de lucha** (por arriba)
- Bridas, hernias, tumores

Íleo paralítico

- **Sin** obstáculo: el intestino deja de moverse
- Abdomen distendido y **silencioso**
- Localizado = **asa centinela** (inflamatorio)
- Generalizado = peritonitis, perforación

¿Por qué vomita y se deshidrata? (libro p. 377)

CAUSA
Obstáculo en el intestino

→

MECANISMO
El contenido se acumula y **refluye** desde el nivel de la obstrucción

→

MANIFESTACIÓN
Vómitos **alimentarios → biliosos → fecaloides**; deshidratación, hipopotasemia

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 3 · min 28:40 · Clase MC Digestivo · parte 3 · min 29:21 · Clase MC Digestivo · parte 3 · min 30:02 · Clase MC Digestivo · parte 3 · min 32:43 · Clase MC Digestivo · parte 3 · min 33:24 · Clase MC Digestivo · parte 3 · min 34:46 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 377

Perforativo: tabla y signo de Jobert

IMPRESCINDIBLE

> Se perfora una víscera hueca: aire libre (Jobert, Popper) + peritonitis secundaria (tabla).

SIGNO DE JOBERT

«Si no saben este signo, los mandan a su casa.» **Jobert** = ausencia de la matidez hepática por **neumoperitoneo**, secundario a la perforación de una víscera hueca.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 4 · min 05:09 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 05:54 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 26:08

CONTRACTURA VS DEFENSA

Contractura muscular

- **Involuntaria**
- Por irritación del peritoneo parietal
- **Abdomen en tabla** (perforación, peritonitis)

Defensa muscular

- **Voluntaria**
- «No me toques»: el paciente se encoge
- Inflamatorios, isquémicos

EN LA CLÍNICA

Paciente **inmóvil** (todo le duele), dolor que no calma con analgésicos, **RHA ausentes** (íleo paralítico generalizado), vómitos, deshidratación, taquicardia. Es **quirúrgico de entrada**.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 4 · min 03:44 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 04:24

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 4 · min 00:01 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 00:45 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 02:13 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 02:57 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 30:12 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 86

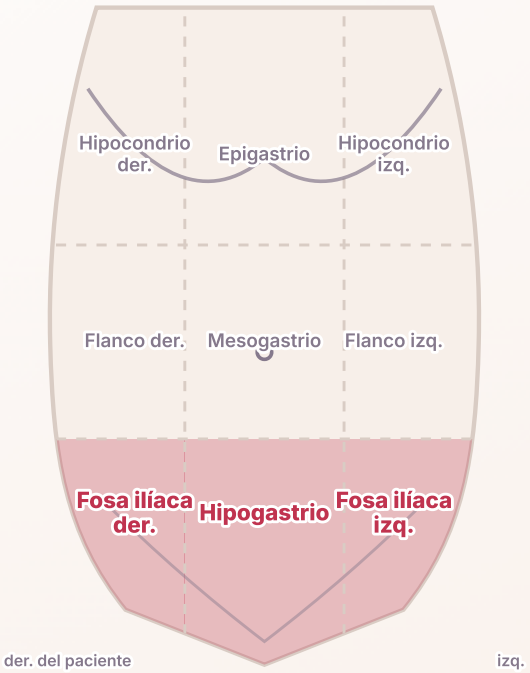
Hemorrágico: matidez, Cullen y Grey-Turner

IMPRESCINDIBLE

> Sangre en el abdomen: hipovolemia + matidez + abdomen blando. Cullen y Grey-Turner = sangrado retroperitoneal.

Los signos en el abdomen

Matidez · Signo de Cullen · Signo de Grey-Turner



Matidez

La sangre se acumula en las partes **declives** y reemplaza al aire: **matidez** a la percusión. «Eso te van a preguntar en el parcial.»

⚠ NO SON PATOGNOMÓNICOS

«Muchos dicen que es patognomónico de la pancreatitis necrohemorrágica: **no es así**.» Aparecen en **cualquier** sangrado retroperitoneal: ectópico roto, **aneurisma de aorta**, trauma, pancreatitis necrohemorrágica.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 4 · min 09:35 Clase MC Digestivo · parte 4 · min 10:18

«LO QUE NO QUIERO QUE SE OLVIDEN SON DOS»

Perforativo

- Aire libre → **timpanismo** en el área hepática
- **Jobert** (neumoperitoneo)
- Abdomen **en tabla**

Hemorrágico

- Sangre → **matidez**
- Abdomen doloroso pero **blando**
- ± Cullen / Grey-Turner

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 4 · min 06:41 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 07:25 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 08:53 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 11:43 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 12:24 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 25:28

Vascular o isquémico: el más letal

IMPRESCINDIBLE

> Poco frecuente, pero el más letal: el intestino se muere y las bacterias escapan.

LA HORA DE ORO

Paciente **mayor**, tabaquista, diabético, hipertenso o que toma anticonceptivos, con un dolor que **progresa** y **no responde a ningún analgésico**: «tiempo que pasa, minuto que pasa, intestino que muere». Pedí **lactato** (> 2 = hipoperfusión).

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 4 · min 13:47 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 14:29 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 16:32

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 4 · min 13:04 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 15:11 · Clase MC Digestivo · parte 4 · min 15:51

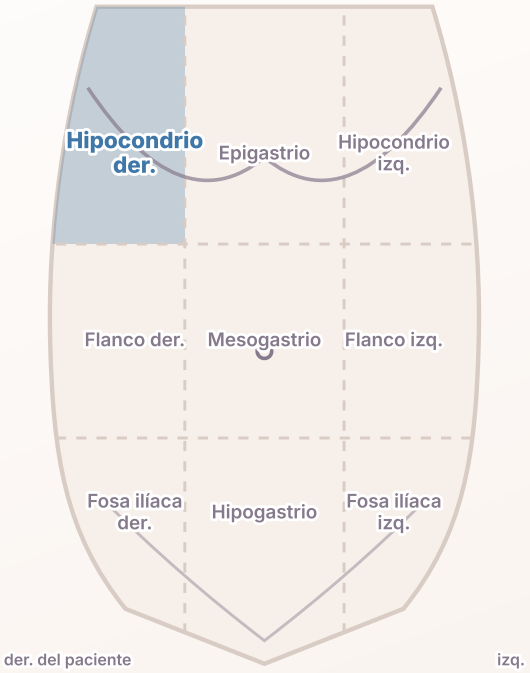
Dónde duele: qué órgano hay debajo

COMPLEMENTARIO

> Cada región tiene sus órganos: la localización orienta la causa.

Hipocondrio derecho | Epigastrio | Hipocondrio izquierdo

Mesogastrio (periumbilical) | Fosa ilíaca derecha | Fosa ilíaca izquierda



Hipocondrio derecho

Hígado, vesícula, vía biliar, riñón derecho. **Pensar:** colecistitis, cólico biliar, colangitis, hepatitis, pielonefritis; neumonía basal (extraabdominal).

Algunos usan 4 cuadrantes y otros 9 regiones: el profe usa los dos.

FUENTE Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 02:14

Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 04:20 | Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 05:00

Cómo lo estudio: ALICIA, examen y complementarios

MUY IMPORTANTE

A L I C I A

Tocá para desplegar

Y siempre lo que acompaña: náuseas y vómitos, tránsito (¿elimina gases y heces?), **fiebre** (¿antes o después del dolor?), síntomas urinarios y ginecológicos.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 4 · min 17:54 Clase MC Digestivo · parte 4 · min 18:38 Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 3

Auscultación: qué te dicen los ruidos hidroaéreos

Lucha	Normal	Local	Silencio
Aumentados	Conservados	Asa centinela	Ausentes

Tocá un escalón para ver el detalle.

PRIMERO

Ecografía

La más barata y rápida: apendicitis, vía biliar, páncreas, vía urinaria.

RX DE PIE

Tórax y abdomen

Aire bajo el diafragma (**Popper**, «media luna»); asas dilatadas en la obstrucción.

SI A LAS 24 H NO HAY DIAGNÓSTICO

Tomografía

De abdomen y pelvis.

LABORATORIO

Hemograma, glucemia (cetoacidosis), urea, **amilasa**, hepatograma, **ionograma**, **troponina** si el ECG es dudoso, **test de embarazo**, orina. El tacto rectal ayuda a localizar un dolor generalizado.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 4 · min 28:10 Clase MC Digestivo · parte 4 · min 28:52 Clase MC Digestivo · parte 4 · min 29:32

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 4 · min 17:54 Clase MC Digestivo · parte 4 · min 20:43 Clase MC Digestivo · parte 4 · min 27:30 Clase MC Digestivo · parte 4 · min 30:12 Clase MC Digestivo · parte 4 · min 32:13

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Los 5 abdómenes agudos quirúrgicos

Para qué sirve: La pregunta de parcial.

- Inflamatorio
- Obstructivo
- Perforativo
- Hemorrágico
- Vascular

Cómo interpretarlo: Para cada uno: causa, dolor y signo clave.

Mnemotecnia: «I-O-P-H-V»: se Inflama, se Obstruye, se Perfora, Hemorragia, Vaso. — Empieza por el más frecuente (inflamatorio) y termina en el más letal (vascular).

Cronología vs tríada de Murphy

Para qué sirve: Lo que el profe pide diferenciar.

- Cronología: epigastrio → periumbilical → FID
- Tríada: dolor → vómitos → fiebre

Cómo interpretarlo: La cronología es dónde duele; la tríada, qué síntomas y en qué orden.

Mnemotecnia: Cronología = mapa · Tríada = reloj. — Una te dice el recorrido; la otra, la secuencia en el tiempo.

Perforativo vs hemorrágico

Para qué sirve: «Lo que no quiero que se olviden son dos.»

- Perforativo: aire → timpanismo (Jobert), tabla
- Hemorrágico: sangre → matidez, abdomen blando

Cómo interpretarlo: Aire suena hueco; sangre suena mate.

Mnemotecnia: Aire sube, sangre baja. — El gas sube y tapa el hígado (Jobert); la sangre cae a las partes declives (matidez).

Cullen y Grey-Turner

Para qué sirve: Evitar el error que más se castiga.

- Cullen: periumbilical
- Grey-Turner: flancos
- Hemorragia retroperitoneal de cualquier causa

Cómo interpretarlo: No son patognomónicos de pancreatitis necrohemorrágica.

Mnemotecnia: Cullen = Centro (ombligo) · Grey-Turner = a los cosTados. — C de centro para Cullen; Turner gira hacia los flancos.

Compresión vs descompresión

Para qué sirve: Entender el examen del abdomen.

- Compresión: peritoneo visceral
- Descompresión (rebote): peritoneo parietal
- Localizado = Blumberg · generalizado = Gueneau de Mussy

Cómo interpretarlo: Cuanto más superficial la hoja irritada, mejor se localiza el dolor.

Mnemotecnia: Apretar = Adentro · Soltar = Superficie. — La compresión explora la hoja visceral; la descompresión, la parietal.

Integración: lo imprescindible

- **5 abdómenes agudos quirúrgicos**: inflamatorio, obstructivo, perforativo, hemorrágico y vascular (el más letal).
- **Cronología de Murphy**: epigastrio → periumbilical → FID. **Tríada de Murphy**: dolor → vómitos → fiebre.
- **Jobert**: ausencia de matidez hepática por neumoperitoneo (perforación). **Popper**: aire subdiafragmático en la Rx.
- **Hemorrágico = matidez** y abdomen blando; **Cullen** (periumbilical) y **Grey-Turner** (flancos) = sangrado retroperitoneal, **no** patognomónicos de pancreatitis.
- **Blumberg** (rebote localizado) vs **Gueneau de Mussy** (generalizado).
- Todo dolor agudo **supraumbilical** → **ECG**.

Desarrollos modelo

1. ¿Cómo se clasifica el abdomen agudo según la etiología? ¿Cuáles son los tipos de abdomen agudo quirúrgico?

Por etiología: médico (gastroenteritis, pielonefritis, cetoacidosis, IAM), **quirúrgico** e inespecífico (por exclusión). **Por duración:** agudo < 7 días, crónico > 7 días.

QUIRÚRGICO	CAUSAS	SIGNO CLAVE
Inflamatorio	Apendicitis, colecistitis, pancreatitis, diverticulitis	Blumberg, asa centinela, fiebre
Obstructivo	Bridas, hernias, tumores, vólvulo, invaginación	Cólico, RHA de lucha, sin gases
Perforativo	Úlcera, apendicitis perforadas	Tabla, Jobert, RHA ausentes
Hemorrágico	Ectópico, aneurisma de aorta, trauma	Hipovolemia, matidez, Cullen/Grey-Turner
Vascular	Isquemia mesentérica	Dolor que no calma; el más letal

2. Sobre abdomen agudo inflamatorio: etiologías, clínica y examen físico.

Etiologías: todo lo que termina en *-itis*: apendicitis (la más frecuente), colecistitis (2.ª), pancreatitis, diverticulitis, adenitis mesentérica.

Apendicitis: obstrucción de la luz por un fecalito → congestiva, flegmonosa, gangrenosa, perforada. **Cronología de Murphy:** epigastrio → periumbilical → FID (visceral → somático). **Tríada de Murphy:** dolor → vómitos → fiebre.

Examen: dolor en **McBurney**, **Blumberg** (rebote localizado); generalizado = Gueneau de Mussy. Íleo paralítico localizado = **asa centinela**. **Colecistitis:** dolor en HD irradiado al hombro derecho, vómitos biliosos, fiebre (± ictericia).

3. Sobre abdomen agudo obstructivo mecánico: etiologías, clínica y examen físico.

Etiologías: bridas (cirugías previas), hernias, tumores, vólvulos, invaginación (niños de 2 meses a 6 años), obstrucción biliar.

Clínica: dolor **cólico** (visceral, mal localizado), **vómitos**, no elimina **gases ni materia fecal**, distensión.

Examen: distensión, ondas peristálticas visibles; **RHA de lucha** por arriba de la obstrucción y disminuidos por debajo; **timpanismo**.

4. Sobre abdomen agudo perforativo: etiologías, clínica y examen físico.

Etiologías: úlcera y apendicitis perforadas (también colecistitis complicada). Produce **peritonitis secundaria** polimicrobiana.

Clínica: dolor **súbito, intenso, permanente y generalizado**; paciente inmóvil; vómitos, deshidratación, taquicardia, hipotensión.

Examen: abdomen **en tabla** (contractura involuntaria), Gueneau de Mussy, **RHA ausentes**, **signo de Jobert** (timpanismo donde debería haber matidez hepática por neumoperitoneo). Rx de pie: aire subdiafragmático (**Popper**).

5. Sobre abdomen agudo hemorrágico: etiologías, clínica y examen físico.

Etiologías: embarazo ectópico (la más frecuente), rotura de aneurisma de aorta, trauma (hígado, bazo, vasos).

Clínica: dolor + **hipovolemia**: taquicardia, hipotensión, frialdad, sudoración, oliguria, alteración de la conciencia.

Examen: abdomen distendido, **matidez** (la sangre reemplaza al aire), doloroso pero **blando**; si sangra al retroperitoneo: **Cullen** (periumbilical) y **Grey-Turner** (flancos).

6. Sobre abdomen agudo vascular: etiologías, clínica y examen físico.

Etiología: oclusión mesentérica (trombosis o embolia). Pacientes mayores, tabaquistas, diabéticos, hipertensos, con anticonceptivos orales.

Clínica: dolor que empieza leve, **progresa**, se generaliza y **no responde a analgésicos** (desproporcionado al examen). Infarto intestinal → translocación bacteriana → **shock séptico**.

Examen: al principio casi normal, RHA conservados que luego **desaparecen**; dolor a la compresión y descompresión. **Lactato > 2.** Hora de oro.

7. ¿A qué corresponden los signos de Cullen y Grey-Turner?

Cullen: equimosis **periumbilical**. **Grey-Turner:** equimosis en los **flancos**.

Indican **hemorragia retroperitoneal**: aparecen en cualquier abdomen agudo hemorrágico (ectópico roto, aneurisma de aorta, trauma) y en la pancreatitis necrohemorrágica. **No son patognomónicos** de pancreatitis.

8. ¿Cuáles son los tipos de dolor abdominal? ¿Cómo se clasifica el abdomen agudo según la duración?

Visceral: peritoneo visceral, fibras C; sordo, mal localizado; duele a la **compresión**. **Somático:** peritoneo parietal, fibras Aδ; bien localizado; duele a la **descompresión** (rebote). **Referido:** lejos del órgano (apendicitis → epigastrio; IAM inferior simula úlcera).

Duración: agudo < 7 días · crónico > 7 días. Dolor agudo supraumbilical → **ECG**.

9. ¿Qué es el abdomen agudo? ¿Cuál es el síntoma característico y cómo se semiografía?

Síndrome cuyo síntoma **cardinal es el dolor abdominal**, con o sin otros signos y síntomas; no incluye la reagudización de un dolor crónico. Se semiografía con **ALICIA** y se interrogan los acompañantes: vómitos, tránsito, fiebre, síntomas urinarios y ginecológicos.

10. Realice un cuadro según las regiones abdominales y las posibles causas de abdomen agudo.

REGIÓN	PENSAR EN
Hipocondrio derecho	Colecistitis, cólico biliar, colangitis, hepatitis, pielonefritis der., neumonía basal
Epigastrio / hipocondrio izq.	Úlcera perforada, gastritis, pancreatitis, bazo, IAM inferior
Fosa ilíaca derecha	Apendicitis, ectópico, anexitis, litiasis ureteral
Fosa ilíaca izquierda	Diverticulitis, anexial izq., litiasis ureteral
Difuso / periumbilical	Obstrucción, isquemia mesentérica, peritonitis, aneurisma de aorta

Preguntas de repaso (choice)

1. Al palpar la fosa ilíaca derecha, el dolor aumenta al **soltar** la mano de golpe. Esto indica compromiso del:
    A. Peritoneo parietal.
    B. Peritoneo visceral únicamente.
    C. Músculo recto anterior.
    D. Plexo mientérico.

2. La **cronología de Murphy** describe:
    A. Dolor en hipocondrio derecho que se irradia al hombro.
    B. Dolor en epigastrio → periumbilical → fosa ilíaca derecha.
    C. Dolor → vómitos → fiebre.
    D. Detención de la inspiración al palpar la vesícula.

3. ¿Por qué el dolor de la apendicitis **empieza en el epigastrio**?
    A. Porque es un dolor somático.
    B. Porque al inicio es un dolor visceral referido.
    C. Porque el apéndice está en el epigastrio.
    D. Porque hay una úlcera asociada.

4. ¿Cuál de estos **no** es uno de los cinco abdómenes agudos quirúrgicos?
    A. Hemorrágico.
    B. Perforativo.
    C. Metabólico.
    D. Vascular.

5. El **signo de Jobert** es:
    A. La ausencia de matidez hepática por neumoperitoneo.
    B. Dolor a la descompresión generalizado.
    C. Equimosis periumbilical.
    D. Matidez en las partes declives.

6. Sobre los signos de **Cullen y Grey-Turner**, es correcto:
    A. Indican hemorragia retroperitoneal de cualquier causa.
    B. Cullen es en los flancos y Grey-Turner periumbilical.
    C. Son patognomónicos de pancreatitis necrohemorrágica.
    D. Indican neumoperitoneo.

7. Mujer joven, hipotensa y taquicárdica, con dolor abdominal; a la percusión hay **matidez** y el abdomen está **blando**. Pensás primero en:
    A. Íleo mecánico.
    B. Gastroenteritis.
    C. Abdomen agudo hemorrágico por embarazo ectópico.
    D. Abdomen agudo perforativo.

8. Dolor cólico, vómitos, no elimina gases y se auscultan **ruidos hidroaéreos de lucha**. ¿Qué ocurre?
    A. Íleo mecánico: el intestino aumenta el peristaltismo para vencer un obstáculo.
    B. Isquemia mesentérica tardía.
    C. Íleo paralítico.
    D. Perforación de víscera hueca.

9. Hombre de 70 años, tabaquista, con dolor abdominal progresivo que **no calma con analgésicos** y un examen casi normal. Lactato 4. ¿Qué sospechás?
    A. Abdomen agudo inespecífico.
    B. Abdomen agudo vascular (isquemia mesentérica).
    C. Apendicitis congestiva.
    D. Cólico biliar.

10. Un paciente hipertenso consulta por dolor epigástrico agudo. ¿Qué estudio no puede faltar?
    A. Tomografía de abdomen.
    B. Colonoscopía.
    C. Electrocardiograma.
    D. Endoscopía digestiva alta.

11. Dolor a la descompresión en **todo** el abdomen:
    A. Signo de Gueneau de Mussy.
    B. Signo de Murphy.
    C. Signo de Cullen.
    D. Signo de Blumberg.

12. El **abdomen en tabla** se debe a:
    A. Defensa muscular voluntaria.
    B. Distensión por gases.
    C. Ascitis a tensión.
    D. Contractura muscular involuntaria por irritación del peritoneo parietal.

13. El dolor visceral suele percibirse en la **línea media** porque:
    A. Porque es un dolor referido a la piel.
    B. Lo conducen nervios espinales de un solo lado.
    C. Las fibras viscerales ingresan a la médula en forma bilateral.
    D. Los órganos abdominales están todos en la línea media.

14. El dolor referido se explica porque:
    A. Aferentes viscerales y cutáneas convergen en la misma neurona del asta dorsal.
    B. Las fibras C conducen más rápido que las Aδ.
    C. El peritoneo parietal se irrita a distancia.
    D. La inflamación se extiende por el peritoneo hasta la piel.

15. En una obstrucción intestinal, los ruidos hidroaéreos:
    A. Están aumentados por arriba del obstáculo y disminuidos por debajo.
    B. Están aumentados solo por debajo.
    C. Son iguales por encima y por debajo.
    D. Están ausentes en todo el abdomen.

16. Un paciente tuvo fiebre **antes** de que empezara el dolor abdominal. Orienta a:
    A. Abdomen agudo hemorrágico.
    B. Gastroenteritis.
    C. Apendicitis.
    D. Cólico biliar simple.

Respuestas

1. **A** — Correcto: el dolor a la descompresión (rebote) es somático, del peritoneo parietal.
2. **B** — Correcto: es el recorrido del dolor en la apendicitis.
3. **B** — Correcto: solo está irritado el peritoneo visceral; cuando toca el parietal, se localiza en FID.
4. **C** — Correcto: la cetoacidosis es una causa médica de dolor abdominal, no uno de los 5 quirúrgicos.
5. **A** — Correcto: el gas de la perforación tapa el hígado y se percute timpanismo.
6. **A** — Correcto: ectópico roto, aneurisma de aorta, trauma, pancreatitis necrohemorrágica.
7. **C** — Correcto: hipovolemia + matidez + abdomen blando; el ectópico es la causa más frecuente.
8. **A** — Correcto.
9. **B** — Correcto: dolor desproporcionado al examen + factores de riesgo + lactato alto.
10. **C** — Correcto: todo dolor agudo por arriba del ombligo lleva ECG para descartar un infarto.
11. **A** — Correcto: generalizado, propio de la peritonitis difusa.
12. **D** — Correcto.
13. **C** — Correcto: la señal llega de ambos lados y se ubica en el centro.
14. **A** — Correcto: el cerebro no distingue el origen y proyecta la sensación a la piel.
15. **A** — Correcto: arriba el intestino lucha; abajo no llega contenido.
16. **B** — Correcto: en el abdomen agudo inflamatorio la fiebre aparece después del dolor.

CAPÍTULO 3

Diarrea, constipación y trastornos anorrectales

Alta vs baja, los cinco mecanismos de la diarrea crónica, criterios de Roma, escala de Bristol y pujo y tenesmo.

NECESITÁS SABER

- Microbiología: toxinas
- Agua y solutos en el intestino

Diarrea, constipación y región anorrectal

Son motivos de consulta con los que «se van a topar mucho». De acá el profe marca como **pregunta de parcial** la **diarrea alta vs baja**, los **criterios de Roma**, la **escala de Bristol** y **pujo y tenesmo**; y la **diarrea malabsortiva**, que «preguntan en el final».

Diarrea aguda
Alta (acuosa) vs baja (disentérica) ★ · Toxinas · Persistente

Diarrea crónica
5 mecanismos · Malabsortiva ★ · Funcional vs orgánica

Constipación
Roma ★ · Bristol ★ · Primaria vs secundaria

Anorrectal
Pujo y tenesmo ★ · Sangrado: gotas vs bañada · Fisura · absceso · fístula

AL TERMINAR VAS A PODER

- Distinguir una diarrea alta de una baja y nombrar sus causas.
- Explicar los 5 mecanismos de la diarrea crónica con un ejemplo cada uno.
- Recitar los criterios de Roma y la escala de Bristol.
- Definir pujo y tenesmo y saber cuándo aparecen.

Qué es y cómo se clasifica por evolución

MUY IMPORTANTE

> ↓ consistencia de las heces + ↑ frecuencia y volumen.

Por evolución

< 2 SEMANAS

Aguda

Casi siempre **intoxicación alimentaria** o infección; también fármacos (clindamicina).

2 A 4 SEMANAS

Persistente

Empieza aguda; posgastroenterítica, niños; **parásitos** o E. coli.

> 4 SEMANAS

Crónica

Orgánica. Específica más frecuente: **celíaca**; inespecífica: **intestino irritable**.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

Disminución de la **consistencia** con aumento de la **frecuencia** y del **volumen**, con o sin náuseas, vómitos, fiebre o dolor abdominal.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 5 · min 00:00 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 00:45

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 5 · min 00:45 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 01:28 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 02:09 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 18:22

Diarrea alta (acuosa) vs baja (disentérica)

IMPRESCINDIBLE

> Alta = intestino delgado, predomina el volumen. Baja = colon, predomina la frecuencia, con moco, pus o sangre.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

Diarrea alta y baja: «es importante que la conozcan».

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 5 · min 02:50

Alta vs baja

	Alta (acuosa)	Baja (disentérica)
DÓNDE	Intestino **delgado**	**Colon**

QUÉ PREDOMINA	El **volumen** (3–4 veces, mucho líquido)	La **frecuencia** (hasta 10 veces, poquito)
ASPECTO	Acuosa, clara, voluminosa	Con **moco, pus o sangre**, más oscura
ACOMPAÑA	Deshidratación	**Pujo y tenesmo**, fiebre, leucocitos en heces
CAUSA	Virus, bacterias, parásitos, toxinas	**Siempre bacteriana**: Shigella, E. coli O157

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 5 · min 02:50 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 03:31 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 04:12 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 08:57

⚠ **SÍNDROME DISENTÉRICO**

Shigella y **E. coli enterohemorrágica O157** producen **verotoxina**: si pasa a la sangre puede dar **síndrome urémico hemolítico** (insuficiencia renal aguda). Todo paciente con diarrea con sangre: muestra de materia fecal (leucocitos, hematíes) y **coprocultivo**.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 5 · min 09:40 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 13:02 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 13:42

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 5 · min 02:50 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 06:14 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 08:57 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 10:21

Quién la produce y cuándo estudiarla

MUY IMPORTANTE

> Lo importante de la etiología es la toxina. La aguda se va sola en 3 a 7 días.

Diarrea aguda
Autolimitada: 3 a 7 días

Sin alarma
No necesita estudios: hidratación oral y dieta

★ **Con sangre, fiebre, dolor intenso, deshidratación o > 1 semana**
Laboratorio + muestra de materia fecal + coprocultivo

Si vomita además, pensá en las toxinas que actúan rápido (S. aureus). Interrogá viajes, antibióticos, qué comió y si alguien más en la familia está igual.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 5 · min 05:33 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 11:42 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 15:42 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 16:22 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 17:02 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 23:04 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 23:44

Los cinco mecanismos (y la malabsortiva ★)

IMPRESCINDIBLE

> Osmótica · secretora · inflamatoria · malabsortiva · motora.

PREGUNTAN EN EL FINAL

«La que yo quiero que ustedes se aprendan... y preguntan en el final, es la **malabsortiva**»: no se absorben las grasas → **esteatorrea**: heces brillantes que flotan en el agua.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 5 · min 21:04 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 21:44

Mecanismo → ejemplo → pista

	Ejemplo	Pista clínica
OSMÓTICA	Déficit de **lactasa**	**Cede** al retirar el alimento (ayuno)
SECRETORA	**VIPoma**, Zollinger-Ellison, laxantes	**Persiste** en ayunas
INFLAMATORIA	Enfermedad inflamatoria intestinal	Sangre y moco
MALABSORTIVA ★	**Celíaca**, giardiasis crónica	**Esteatorrea**: grasosa, brillante, flota
MOTORA	Intestino irritable, hipertiroidismo	Hiper o hipomotilidad

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 5 · min 19:44 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 20:24 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 21:04 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 22:24

¿FUNCIONAL U ORGÁNICA?

Funcional (p. ej., SII)

- Aparece **por la mañana**
- Sin pérdida de peso
- Diagnóstico por exclusión

Orgánica

- Deposiciones **nocturnas**
- **Pérdida de peso**
- Anemia, hipoalbuminemia (malabsorción)

¿Por qué la orgánica adelgaza y da anemia? (libro)

CAUSA
La mucosa no absorbe (celíaca, malabsorción)

→

MECANISMO
Se pierden grasas, proteínas, hierro, folato y vitaminas

→

MANIFESTACIÓN
Esteatorrea, pérdida de peso, anemia, hipoalbuminemia

La esteatorrea da evacuaciones **menos frecuentes pero más abundantes**, hipocoloreadas, con espuma, que **flotan**. Se confirma con **Van de Kamer**: más de **6 g/día** de grasa en heces (dieta con 100 g/día durante 72 h) es anormal (libro p. 379). Se profundiza en **Malabsorción**.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 5 · min 02:09 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 19:44 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 25:04 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 26 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 379

Constipación y criterios de Roma

IMPRESCINDIBLE

> Dos o más de seis criterios, 90 días en 6 meses, sin laxantes y sin criterios de intestino irritable.

PREGUNTA DE PARCIAL

La definición de constipación «está sujeta a los **criterios de Roma**: esto no se tiene que olvidar, estas son preguntas de parcial».

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 5 · min 29:09

Probá los criterios de Roma con un paciente

Esfuerzo para evacuar	No (0)	Sí (1)
Heces duras o en bolitas	No (0)	Sí (1)
Evacuación incompleta	No (0)	Sí (1)
Bloqueo anorrectal	No (0)	Sí (1)
Maniobras manuales	No (0)	Sí (1)
< 3 evacuaciones por semana	No (0)	Sí (1)

0 **No cumple**

Hacen falta **dos o más** criterios.

No cumple: 0–1 | Cumple el criterio clínico: 2–6

Los criterios de esfuerzo, heces duras, evacuación incompleta, bloqueo y maniobras cuentan si aparecen en ≥ 25 % de las deposiciones.

Constipación crónica

Primaria / funcional

El problema está en el colon o el piso pélvico

Intestino irritable

La más frecuente de las funcionales

Tránsito lento

Hirschsprung

Disfunción del piso pélvico
Anismo: no relaja el periné

Secundaria / extracolónica
Colon y recto sanos

Dieta
La causa más frecuente del mundo

Fármacos, hipotiroidismo, neurológicas

Mecánica
Rara: algo obstruye

⚠ **ALARMA**

Constipación + **pérdida de peso** + **anemia** + **más de 50 años** (o sangre): **colonoscopía**, para no pasar por alto un cáncer.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 6 · min 02:07 · Clase MC Digestivo · parte 6 · min 04:14

PISO PÉLVICO

Maniobra del descenso en el tacto rectal: el paciente puja y debe expulsar el dedo. **Test de expulsión del balón**: si no lo expulsa, el piso pélvico no se relaja (constipación primaria).

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 6 · min 02:50 · Clase MC Digestivo · parte 6 · min 04:59

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 5 · min 29:09 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 29:49 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 30:29 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 32:30 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 35:11 · Clase MC Digestivo · parte 5 · min 35:53 · Clase MC Digestivo · parte 6 · min 00:44

Escala de Bristol

IMPRESCINDIBLE

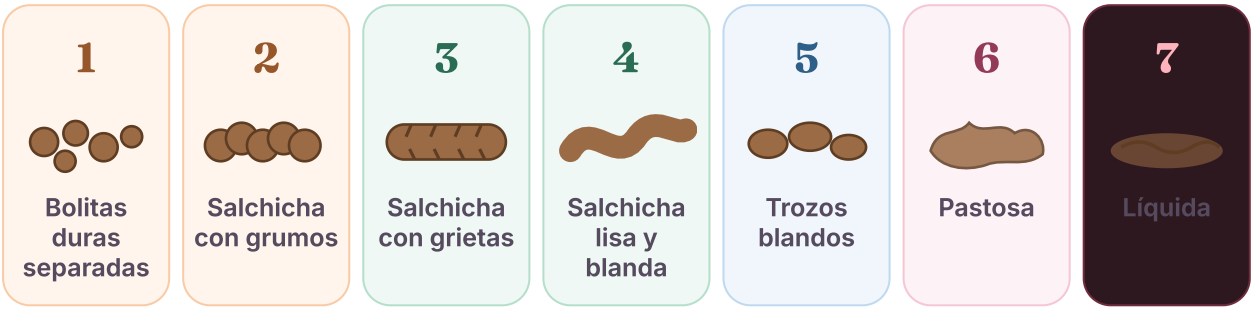
> 1–2 constipación · 3–4 normal · 5–7 diarrea.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

«Una escala **importantísima**... que **preguntan en los parciales**: la escala de Bristol.»

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 6 · min 01:25

Tocá cada tipo



◂ Constipación Diarrea ▸

Tocá un escalón para ver el detalle.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 6 · min 01:25 Clase MC Digestivo · parte 6 · min 02:50

Pujo, tenesmo y lo que se ve en el ano

IMPRESCINDIBLE

> Pujo y tenesmo: pregunta de parcial, típicos de la diarrea disentérica. El resto, rara vez lo toman.

PREGUNTA DE PARCIAL

«Qué es el pujo... y el tenesmo... eso es **pregunta de parcial**, y aparece en las **diarreas disentéricas**.»

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 6 · min 12:11 Clase MC Digestivo · parte 6 · min 12:52

PUJO

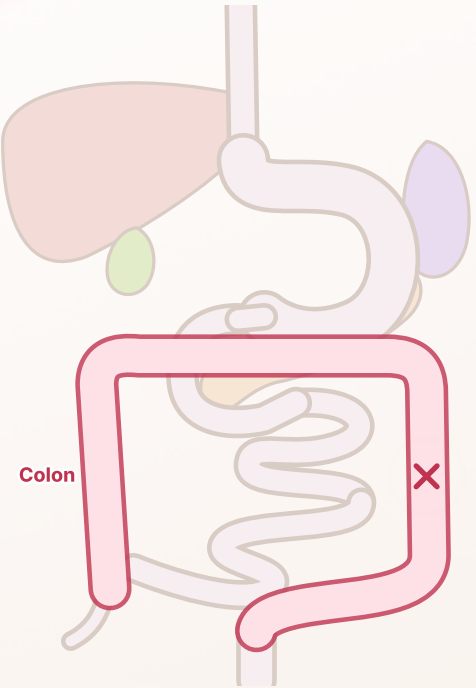
- **Dolor abdominal** con ganas de evacuar
- **No logra evacuar**
- «Pujo y me duele el abdomen»

TENESMO

- **Ya evacuó**
- Sigue sintiendo **necesidad de evacuar**
- Recto «todavía ocupado»

De dónde viene la sangre

Heces bañadas en sangre | Gotas al final



Heces bañadas en sangre

La materia fecal sale **cubierta** de sangre (oscura o fresca): origen **colónico** → **colonoscopia**, más si tiene más de 40–50 años.

Fisura, absceso, fístula y hemorroides

	Qué es	Pista
HEMORROIDES	Dilatación venosa (internas / externas)	Duelen **al** defecar; gotas de sangre al final
FISURA	Desgarro lineal de la mucosa anal	Duele **después** de defecar, «como un vidrio»
ABSCESO	Colección de pus perianal	Dolor pulsátil, tumefacción, fiebre
FÍSTULA	Trayecto anormal canal anal ↔ piel	**No duele** (salvo que se abscede); supura moco o pus; Crohn

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 6 · min 07:05 Clase MC Digestivo · parte 6 · min 09:17 Clase MC Digestivo · parte 6 · min 11:26

SIGNO DEL GUANTE

En el tacto rectal se usa guante blanco: al retirar el dedo se mira el color. **Rojo** = sangre; **negro** = melena; amarillento = pus. El **prurito** es la 2.ª manifestación anorrectal más común.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 6 · min 14:58 Clase MC Digestivo · parte 6 · min 15:42 Clase MC Digestivo · parte 6 · min 11:26

⚠ GANGRENA DE FOURNIER

Infección necrotizante del periné, con dolor, ampollas, pus y piel que se decolora; típica del **diabético** o inmunodeprimido. Emergencia con alta mortalidad.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 6 · min 07:49

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 6 · min 06:22 Clase MC Digestivo · parte 6 · min 08:36 Clase MC Digestivo · parte 6 · min 12:11

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Alta vs baja

Para qué sirve: Pregunta de parcial.

- Alta: delgado, volumen, acuosa
- Baja: colon, frecuencia, moco-pus-sangre, pujo y tenesmo

Cómo interpretarlo: La altura cambia las causas: la baja es bacteriana.

Mnemotecnia: ALTA = mucho Agua · BAJA = muchas veces, con sangre. — Arriba (delgado) se pierde volumen; abajo (colon) se va muchas veces y poquito.

Los 5 mecanismos de la diarrea crónica

Para qué sirve: Responder la pregunta del preguntero.

- Osmótica
- Secretora
- Inflamatoria
- Malabsortiva
- Motora

Cómo interpretarlo: La prueba del ayuno separa osmótica (cede) de secretora (persiste).

Mnemotecnia: «O-S-I-M-M»: Osmótica, Secretora, Inflamatoria, Malabsortiva, Motora. — Dos M al final: Mala absorción y Motora.

Criterios de Roma

Para qué sirve: Pregunta de parcial.

- ≥ 2 de 6
- 90 días en 6 meses
- Sin laxantes · no SII

Cómo interpretarlo: Son seis: esfuerzo, duras, incompleta, bloqueo, manuales, < 3 por semana.

Mnemotecnia: «Esfuerzo Duro, Incompleto, Bloqueado, a Mano y < 3». — Una frase con los seis criterios en orden.

Escala de Bristol

Para qué sirve: Pregunta de parcial.

- 1–2 constipación
- 3–4 normal
- 5–7 diarrea

Cómo interpretarlo: Cuanto más alto el número, más líquida.

Mnemotecnia: 2 · 2 · 3: dos de constipación, dos normales, tres de diarrea. — Los siete tipos se reparten 2 + 2 + 3.

Pujo vs tenesmo

Para qué sirve: Pregunta de parcial.

- Pujo: dolor + ganas, no evacua
- Tenesmo: ya evacuó y siente que falta

Cómo interpretarlo: Ambos = diarrea disentérica (baja).

Mnemotecnia: Pujo = Previo · Tenesmo = Terminé (y sigo con ganas). — El pujo es antes de lograr evacuar; el tenesmo, después.

Integración: lo imprescindible

- **Alta** (delgado): voluminosa, acuosa. **Baja** (colon): frecuente, moco-pus-sangre, pujo y tenesmo; **siempre bacteriana** (Shigella, E. coli O157 → SUH).
- Evolución: aguda < 2 semanas · persistente 2–4 · crónica > 4.
- Crónica: **osmótica** (cede con ayuno), **secretora** (persiste), inflamatoria, **malabsortiva** (esteatorrea), motora.
- **Roma**: ≥ 2 de 6 criterios, 90 días en 6 meses, sin laxantes, sin criterios de SII.
- **Bristol**: 1–2 constipación · 3–4 normal · 5–7 diarrea.
- **Pujo**: dolor + deseo sin evacuar. **Tenesmo**: necesidad de seguir evacuando después de evacuar.

Desarrollos modelo

1. ¿Qué es la diarrea y cómo se clasifica?

Definición: disminución de la consistencia de las heces con aumento de la frecuencia y del volumen.

Por evolución: aguda < 2 semanas · persistente 2–4 semanas · crónica > 4 semanas.

Por altura: alta (delgado): voluminosa, acuosa, predomina el volumen. Baja (colon): frecuente y de poco volumen, con moco, pus o sangre, pujo y tenesmo: **disentérica**, siempre bacteriana (Shigella, E. coli O157).

Crónica por mecanismo: osmótica, secretora, inflamatoria, malabsortiva, motora.

2. Defina diarrea crónica y mencione sus subtipos.

Diarrea de **más de 4 semanas**, en general orgánica. Específica más frecuente: **celíaca**; inespecífica: **intestino irritable**.

MECANISMO	EJEMPLO	PISTA
Osmótica	Déficit de lactasa	Cede con el ayuno
Secretora	VIPoma, Zollinger-Ellison, laxantes	Persiste en ayunas
Inflamatoria	EII	Sangre y moco
Malabsortiva	Celíaca, giardiasis	Esteatorrea
Motora	SII, hipertiroidismo	—

3. Mencione cómo se clasifica la escala de heces de Bristol.

Siete tipos. 1: bolitas duras separadas · 2: salchicha con grumos → **constipación**. 3: salchicha con grietas · 4: salchicha lisa y blanda → **normales**. 5: trozos blandos · 6: pastosa · 7: líquida → **diarrea**.

4. ¿Qué es la constipación? Defina los criterios de Roma y sus requisitos.

Evacuación infrecuente, difícil o incompleta, con heces en general duras. **≥ 2 de:** esfuerzo · heces duras o en bolitas · evacuación incompleta · bloqueo anorrectal · maniobras manuales (en ≥ 25 % de las deposiciones) · **< 3 evacuaciones por semana**.

Requisitos: 3 meses de síntomas en 6 (90 días), heces blandas raras sin laxantes y no cumplir criterios de intestino irritable. **Causa secundaria más frecuente: la dieta.**

5. Defina prurito, pujo y tenesmo. ¿Cómo se realiza la prueba del guante?

Pujo: dolor abdominal con deseo de evacuar sin lograrlo. **Tenesmo:** después de evacuar, sensación de necesidad de seguir evacuando. Ambos típicos de la **diarrea disentérica**.

Prurito anal: picazón perianal; 2.ª manifestación anorrectal más común.

Signo del guante: en el tacto rectal con guante blanco, al retirar el dedo se mira el color: rojo (sangre), negro (melena), amarillento (pus).

6. Mencione las causas de diarrea aguda. ¿Qué es la diarrea persistente?

Aguda (< 2 semanas): intoxicación alimentaria e infecciones (virus como rotavirus; bacterias como E. coli, Salmonella, Shigella, cólera; toxina del S. aureus) y fármacos (clindamicina). Es autolimitada (3–7 días).

Persistente (2–4 semanas): empieza como aguda; posgastroenterítica, frecuente en niños; casi siempre **parásitos** o E. coli.

7. Mencione cinco trastornos de la defecación y diferencie absceso, fisura y fístula.

Hemorroides, fisura anal, absceso y fístula perianal, prolapso rectal, proctalgia fugaz, proctitis, prurito, impactación fecal, incontinencia fecal.

Fisura: desgarro lineal; duele después de defecar, «como un vidrio», gotas de sangre. **Absceso:** colección de pus; dolor pulsátil, tumefacción, fiebre. **Fístula:** trayecto canal anal–piel; no duele salvo que se abscede; supura; Crohn.

Preguntas de repaso (choice)

1. Paciente que va **10 veces por día** al baño, poca cantidad, con **moco y sangre**. Se trata de una diarrea:
   A. Osmótica.
   B. Alta, acuosa.
   C. Persistente.
   D. Baja, disentérica.

2. La diarrea disentérica es producida siempre por:
    A. Parásitos.
    B. Bacterias como Shigella y E. coli enterohemorrágica O157.
    C. Fármacos.
    D. Virus (rotavirus).

3. La complicación que puede producir la **verotoxina** de la E. coli O157 es:
    A. Síndrome de Zollinger-Ellison.
    B. Megacolon tóxico por C. difficile.
    C. Encefalopatía hepática.
    D. Síndrome urémico hemolítico.

4. Vómitos y diarrea pocas horas después de comer una ensalada con **mayonesa**. La toxina responsable es:
    A. Citotoxina del C. difficile.
    B. Neurotoxina del Staphylococcus aureus.
    C. Enterotoxina del cólera.
    D. Verotoxina.

5. Una diarrea crónica que **persiste en ayunas** orienta a mecanismo:
    A. Motor.
    B. Osmótico.
    C. Secretor.
    D. Malabsortivo.

6. Heces voluminosas, **brillantes, que flotan** en el agua. ¿Qué mecanismo de diarrea crónica sugieren?
    A. Osmótico.
    B. Malabsortivo (esteatorrea).
    C. Inflamatorio.
    D. Secretor.

7. ¿Cuál de estos datos sugiere una diarrea crónica **orgánica**?
    A. Bristol tipo 4.
    B. Deposiciones solo por la mañana.
    C. Deposiciones nocturnas y pérdida de peso.
    D. Mejora con el estrés.

8. En la escala de Bristol, los tipos **normales** son:
    A. Solo el 7.
    B. 1 y 2.
    C. 5 y 6.
    D. 3 y 4.

9. Según Roma, para hablar de constipación se necesitan:
    A. Tres o más criterios durante 2 semanas.
    B. Un criterio durante 1 mes.
    C. Menos de 3 evacuaciones semanales, sin otro requisito.
    D. Dos o más criterios, 3 meses dentro de 6, sin laxantes y sin criterios de SII.

10. La causa **más frecuente** de constipación a nivel mundial es:
    A. El hipotiroidismo.
    B. El cáncer de colon.
    C. La dieta.
    D. La enfermedad de Hirschsprung.

11. Sensación de necesidad de seguir evacuando **después** de haber evacuado:
    A. Incontinencia.
    B. Tenesmo.
    C. Pujo.
    D. Prurito.

12. Dolor intenso **después** de defecar, «como si pasara un vidrio», con gotas de sangre roja:
    A. Absceso perianal.
    B. Fístula anal.
    C. Fisura anal.
    D. Cáncer de colon.

13. La **enterotoxina** del cólera produce diarrea porque:
    A. Impide la absorción de grasas.
    B. Aumenta el peristaltismo por acción nerviosa.
    C. Activa la secreción de cloro y agua hacia la luz sin destruir la mucosa.
    D. Destruye la mucosa del colon.

14. Una diarrea crónica que **persiste en ayunas** orienta a un mecanismo:
    A. Por intolerancia a la lactosa.
    B. Por dieta pobre en fibra.
    C. Secretor.
    D. Osmótico.

15. En el **anismo**, al pujar:
    A. El colon no tiene plexo mientérico.
    B. El esfínter interno no existe.
    C. El paciente expulsa el balón sin dificultad.
    D. El puborrectal se contrae en lugar de relajarse.

Respuestas

1. **D** — Correcto: frecuencia > volumen, moco y sangre: colon.
2. **B** — Correcto: «siempre siempre siempre son bacterianas».
3. **D** — Correcto: insuficiencia renal aguda.
4. **B** — Correcto: acelera el peristaltismo y da vómitos.
5. **C** — Correcto: VIPoma, Zollinger, laxantes.
6. **B** — Correcto: no se absorben las grasas.
7. **C** — Correcto.
8. **D** — Correcto.

9. **D** — Correcto.
10. **C** — Correcto: causa secundaria (extracolónica) más frecuente.
11. **B** — Correcto.
12. **C** — Correcto.
13. **C** — Correcto: diarrea acuosa, voluminosa.
14. **C** — Correcto: la secreción activa no depende de lo que se come.
15. **D** — Correcto: es la disfunción del piso pélvico.

CAPÍTULO 4

Ictericia

El circuito de la bilirrubina y dónde se rompe: pre, intra o poshepática. Orina, heces, tinte y laboratorio para saber cuál es.

NECESITÁS SABER

- Metabolismo de la hemoglobina
- Anatomía de la vía biliar

Ictericia

El profe es tajante: «ictericia preguntan muchísimo… **no me saben ictericia para el tercer parcial, los van a bochar**». Todo sale del apunte de motivos de consulta (libro p. 10–15).

El circuito
Indirecta vs directa · Coluria y acolia · Kernicterus

Clasificación ★
Pre · hepática · post · Qué bilirrubina sube · Orina, heces, tinte

Semiología
Edad y sexo · Flavínica → melánica · Courvoisier

Laboratorio
Hemólisis · necrosis · colestasis · GPT vs GOT · Prueba de Koller

AL TERMINAR VAS A PODER

- Explicar por qué solo la directa da coluria y por qué hay acolia.
- Clasificar una ictericia en pre, intra o poshepática con la orina, las heces y el tinte.
- Enunciar la ley de Courvoisier-Terrier y el síndrome coledociano.
- Elegir los marcadores de hemólisis, necrosis y colestasis.

Qué es, valores y pseudoictericia

MUY IMPORTANTE

> Coloración amarilla de piel y mucosas cuando la bilirrubina supera los 2 mg/dl.

AVISO DEL PROFE

«Ictericia preguntan muchísimo… vuelvan a repasar… **no me saben ictericia para el tercer parcial, los van a bochar**.»

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 6 · min 15:42 · Clase MC Digestivo · parte 6 · min 16:23

Bilirrubina total (mg/dl)

0,3–1	1–2	> 2
Normal	Subclínica	Ictericia

◂ Normal — Ictericia visible ▸

Tocá un escalón para ver el detalle.

NO CONFUNDIR

Ictericia

- Bilirrubina > 2 mg/dl
- Tiñe las **escleróticas**
- Piel y mucosas

Pseudoictericia

- Bilirrubina **normal**
- **Respeta la esclerótica**
- Palmas: carotenos (zanahoria, zapallo, cítricos), IRC, fármacos

FUENTE Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 10 Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 12

El circuito: indirecta, directa, coluria y acolia

IMPRESCINDIBLE

> Indirecta = antes del hígado, pegada a la albúmina. Directa = conjugada, hidrosoluble: la única que pasa a la orina.

Indirecta vs directa

	Indirecta (no conjugada)	Directa (conjugada)
DÓNDE ESTÁ	**Antes** del hepatocito	Ya **conjugada** con ácido glucurónico

SOLUBILIDAD	Liposoluble	**Hidrosoluble**
TRANSPORTE	Firmemente unida a la **albúmina**	Libre
ORINA	**No** se filtra: sin coluria	Se filtra: **coluria**
SISTEMA NERVIOSO	En el neonato puede ir a los núcleos de la base: **kernicterus**	—

FUENTE Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 10

Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 11

⚠ **KERNICTERUS**

La bilirrubina **indirecta** se acumula en los **núcleos de la base** del recién nacido cuando la barrera hematoencefálica no está formada o está alterada: daño cerebral irreversible. La ictericia del neonato es **fisiológica** si dura 2–3 días.

FUENTE Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 11

FUENTE Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 10 Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 11

Pre, intra y poshepática

IMPRESCINDIBLE

> Antes del hígado sobra bilirrubina; en el hígado falla el hepatocito; después del hígado no sale la bilis.

El resumen del apunte (tapalo y reconstruilo)

	Prehepática	Hepática	Poshepática
CAUSAS	Hemólisis, eritroblastosis fetal, paludismo, reabsorción de hematomas	Gilbert, Crigler-Najjar, Dubin-Johnson / Rotor; hepatitis, cirrosis, alcohol, fármacos	Coledocolitiasis, cáncer de cabeza de páncreas, ampuloma, Mirizzi
BILIRRUBINA	**Indirecta**	Indirecta **o** directa	**Directa**

ORINA	Parda (sin coluria)	**Coluria**	**Coluria**
HECES	**Hipercólicas**	Normocólicas	Hipocólicas / **acólicas**
TINTE	Flavínica	Rubínica	Verdínica
MARCADORES	LDH ↑, reticulocitos ↑, haptoglobina ↓	GPT, GOT ↑; albúmina ↓; TP prolongado	FA, GGT, 5'-nucleotidasa ↑

FUENTE Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 11

Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 15

Hepática: ¿qué paso falla?

Captación
Síndrome de **Gilbert** (el más común) → indirecta

Conjugación
Crigler-Najjar → indirecta

Excreción
Dubin-Johnson, Rotor, hepatitis → directa

FUENTE Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 11 Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 15

Qué preguntar y qué mirar

MUY IMPORTANTE

La edad orienta

NEONATO	NIÑO	ADOLESCENTE	ADULTO JOVEN	> 45 AÑOS	> 60 AÑOS
Fisiológica 2–3 días; si se prolonga → kernicterus	**Hepatitis A**	**Hepatitis B**	**Colecistitis, alcohol, hepatitis B**	**Litiasis, cirrosis, cáncer de páncreas**	**Cáncer (75 %)** Cirrosis alcohólica, litiasis

A cualquier edad: **fármacos**. Mujer: litiasis (4 F), cirrosis biliar primaria. Hombre: cirrosis alcohólica, neoplasias.

Grado de ictericia (tinte)

Flavínica	Rubínica	Verdínica	Melánica
Amarillo pálido	Amarillo rojizo	Verde aceituna	Negruzca

Tocá un escalón para ver el detalle.

COMIENZO

Brusco vs insidioso

Brusco: hepatitis viral, drogas, litiasis. Lento: cirrosis, **cáncer de cabeza de páncreas**, ampuloma.

ESTADO GENERAL

«Más ictérico que enfermo»

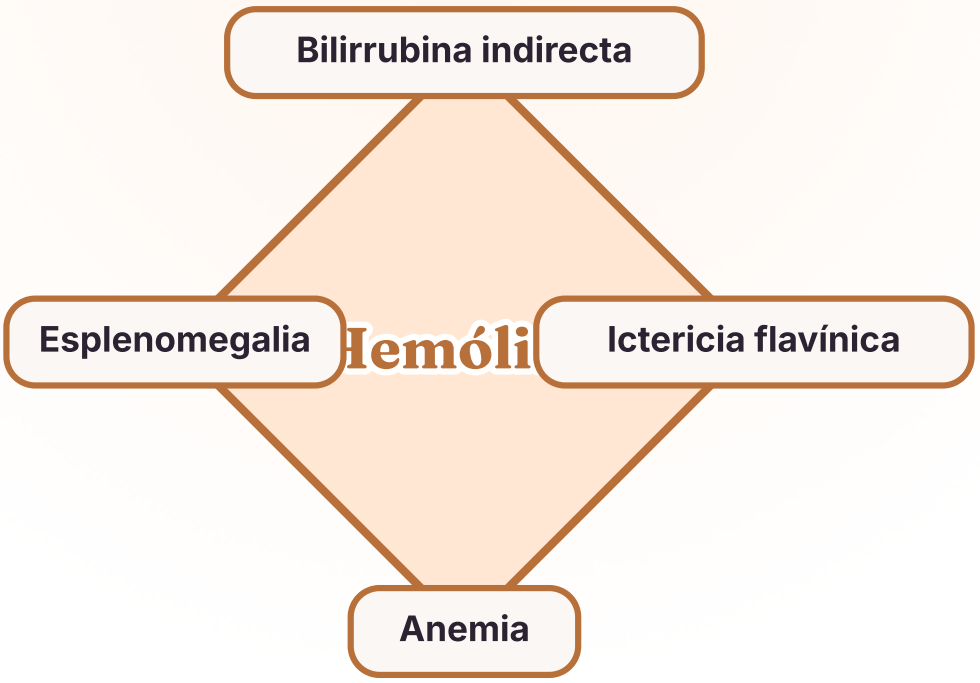
La **obstructiva**. La hepatocelular tiene ictericia leve y más compromiso general.

PIEL

Rascado = colestasis

El **prurito** (sales biliares) deja lesiones de rascado. Pérdida de peso: pensar en cáncer de páncreas.

Síndrome hemolítico



FUENTE Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 13

DOLOR TIPO CÓLICO BILIAR (ALICIA)

Agudo · hipocondrio derecho y epigastrio · irradia a dorso y hombro derecho · cólico · intensidad 3–10/10 · desencadenado por alimentos colecistoquinéticos: **colelitiasis**, la causa más frecuente.

FUENTE Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 11

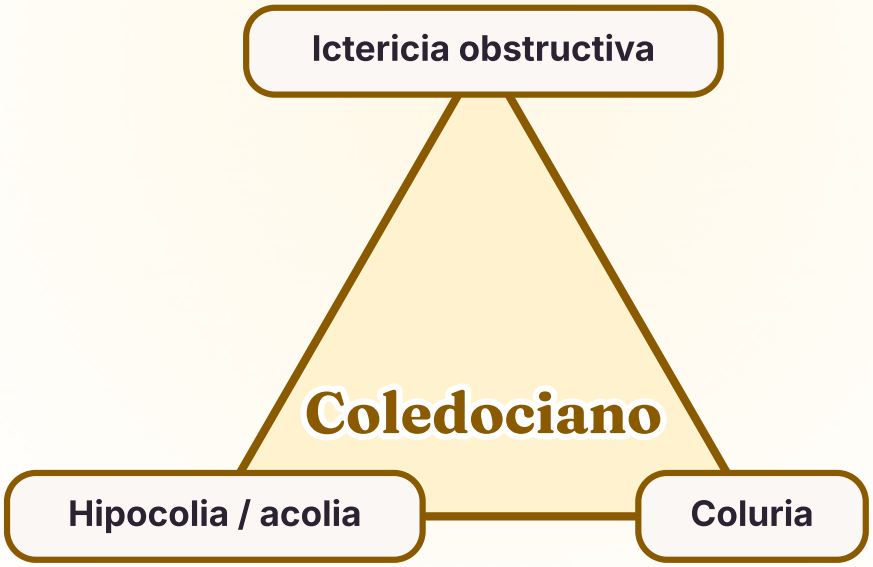
FUENTE Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 11 Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 12 Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 13

Síndrome coledociano y ley de Courvoisier

IMPRESCINDIBLE

> Cálculo = vesícula que no se distiende. Tumor = vesícula grande e indolora.

Síndrome coledociano



Es la traducción clínica de una **obstrucción del colédoco**.

FUENTE Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 13

★ **LEY DE COURVOISIER-TERRIER**

«Toda ictericia **progresiva** de varios meses de evolución con **vesícula palpable no dolorosa** y **pérdida de peso** importante es **cáncer de la cabeza del páncreas** hasta que se demuestre lo contrario.» La obstrucción **litiásica** no distiende la vesícula porque su pared está fibrosada.

FUENTE Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 13

ⓘ **SIGNO DE BARD Y PICK**

Vesícula palpable **no dolorosa** en un paciente ictérico, por obstrucción mecánica de la vía biliar.

FUENTE Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 13

FUENTE Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 13

Laboratorio e imágenes

MUY IMPORTANTE

Tres grupos de marcadores

Qué piden	Por qué

HEMÓLISIS	LDH ↑, bilirrubina indirecta ↑, **reticulocitos ↑**, **haptoglobina ↓**	Se destruyen glóbulos rojos y la médula compensa
NECROSIS HEPATOCELULAR	**GPT (ALT)**, más específica; GOT (AST)	**GPT > GOT**: hepatitis viral · **GOT > GPT**: alcohólica
COLESTASIS	**FA**, **GGT**, 5′-nucleotidasa, bilirrubina directa, colesterol	La bilis no sale
FUNCIÓN	Albúmina ↓, tiempo de protrombina prolongado	El hígado deja de sintetizar

FUENTE Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 13

Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 14

Ictérico con tiempo de protrombina prolongado

Prueba de Koller
Vitamina K 10 mg/día IM durante 3 días

Corrige → colestasis
Faltaba vitamina K (no se absorbe sin bilis)

No corrige → lesión hepatocelular
El hígado no fabrica los factores II, VII, IX y X

Los factores II, VII, IX y X se sintetizan en el hígado y necesitan vitamina K, que es liposoluble y se absorbe con la bilis.

PRIMERO

Ecografía

Accesible, barata y de alto rédito: ¿vía biliar dilatada? → obstructiva.

VÍA BILIAR

Colangiorresonancia · CPRE

La CPRE además permite tratar (sacar el cálculo).

HEPATITIS

Marcadores virales

IgM VHA, HBsAg, IgM VHB, VHC; Epstein-Barr, CMV.

FUENTE Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 13 Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 14

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Coluria y acolia

Para qué sirve: Entender sin memorizar.

- Coluria = directa en la orina
- Acolia = no llega bilis al intestino

Cómo interpretarlo: Coluria + acolia = obstrucción.

Mnemotecnia: La Directa va Derecho a la orina. — Solo la directa (hidrosoluble) se filtra; la indirecta viaja pegada a la albúmina.

Los tres tipos

Para qué sirve: La pregunta que más se toma.

- Pre: indirecta, hipercólicas, flavínica
- Hepática: mixta, coluria, rubínica
- Post: directa, coluria + acolia, verdínica

Cómo interpretarlo: Las heces se aclaran a medida que avanzás por el circuito.

Mnemotecnia: Heces: OSCURAS → normales → BLANCAS. — Pre (más pigmento) · hepática · post (sin bilis).

Grado de ictericia

Para qué sirve: Reconocer el tinte.

- Flavínica: hemólisis
- Rubínica: hepatocelular
- Verdínica: colestasis
- Melánica: obstructiva crónica

Cómo interpretarlo: Del amarillo pálido al negruzco, según cuánto tiempo y cuánta directa.

Mnemotecnia: F-R-V-M: Flavo (amarillo), Rubí (rojo), Verde, Melano (negro). — Los nombres son colores en latín/griego.

Courvoisier-Terrier

Para qué sirve: Ley clásica de examen.

- Ictericia progresiva
- Vesícula palpable no dolorosa
- Pérdida de peso
- = cáncer de cabeza de páncreas

Cómo interpretarlo: La litiasis no distiende la vesícula (pared fibrosada).

Mnemotecnia: Vesícula GRANDE y TRANQUILA = tumor. — Grande (distendida) y sin dolor.

Marcadores

Para qué sirve: Pedir bien el laboratorio.

- Hemólisis: LDH, reticulocitos, haptoglobina ↓
- Necrosis: GPT, GOT
- Colestasis: FA, GGT, 5'N

Cómo interpretarlo: GPT > GOT viral; GOT > GPT alcohólica.

Mnemotecnia: GOT > GPT: «G-O-T = Gin, Otro Trago». — Cuando la GOT gana, pensá en alcohol.

Integración: lo imprescindible

- Ictericia: bilirrubina **> 2 mg/dl**; se ve primero en escleróticas y frenillo, con luz natural.
- **Indirecta**: unida a albúmina, no da coluria; **directa**: hidrosoluble, da **coluria**.
- **Pre** (hemólisis): indirecta, orina parda, heces hipercólicas. **Hepática**: mixta, coluria. **Post**: directa, coluria + **acolia**, prurito.
- Tinte: **flavínico, rubínico, verdínico, melánico**.
- **Síndrome coledociano**: ictericia + coluria + hipocolia/acolia. **Courvoisier**: vesícula palpable indolora = cáncer de cabeza de páncreas.
- Marcadores: hemólisis (LDH, reticulocitos, haptoglobina ↓), necrosis (GPT, GOT), colestasis (FA, GGT, 5'N). Koller.

Desarrollos modelo

1. Clasifique la ictericia y mencione etiologías prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. ¿Qué bilirrubina aumenta en cada una?

	PREHEPÁTICA	HEPÁTICA	POSHEPÁTICA
Mecanismo	Hemólisis	Falla del hepatocito	Obstrucción biliar
Causas	Anemias hemolíticas, eritroblastosis fetal, paludismo	Gilbert, Crigler-Najjar, Dubin-Johnson; hepatitis, cirrosis, fármacos	Coledocolitiasis, cáncer de cabeza de páncreas, ampuloma
Bilirrubina	**Indirecta**	Indirecta o directa	**Directa**
Orina / heces	Parda / hipercólicas	Coluria / normocólicas	Coluria / acólicas

2. Realice una tabla de diferenciación entre bilirrubina indirecta y directa. ¿Qué es el kernicterus?

Indirecta (no conjugada): antes del hepatocito, liposoluble, unida a la albúmina; **no se filtra** → sin coluria. **Directa (conjugada):** con ácido glucurónico, hidrosoluble, se filtra → **coluria**.

Kernicterus: la indirecta se acumula en los **núcleos de la base** del neonato (barrera hematoencefálica inmadura o alterada): daño cerebral irreversible.

3. ¿Qué es la ictericia? Valores normales, hiperbilirrubinemia subclínica y pseudoictericia.

Ictericia: coloración amarilla de piel y mucosas con bilirrubina **> 2 mg/dl**. Normal: total 0,3–1 · directa 0,1–0,4 · indirecta 0,2–0,9 mg/dl.

Subclínica: 1–2 mg/dl, sin color visible. **Pseudoictericia:** color amarillo (palmas) con bilirrubina **normal** que **respeta la esclerótica**: carotenos, IRC, neoplasias, fármacos.

4. Semiológicamente, ¿qué rasgos clínicos orientan en un paciente ictérico?

Tinte: flavínico (hemólisis), rubínico (hepatocelular), verdínico (colestasis), melánico (obstructiva crónica). **Orina:** coluria = directa. **Heces:** acolia = obstrucción. **Prurito** con rascado = colestasis.

Signos acompañantes: esplenomegalia y anemia (hemólisis); ascitis + ictericia = cirrosis; vesícula palpable indolora (**Courvoisier**) = cáncer de cabeza de páncreas; obstructiva: «más ictérico que enfermo».

5. ¿Qué marcadores de laboratorio solicita en un paciente ictérico?

Bilirrubina total y fraccionada. Hemólisis: LDH, reticulocitos ↑, haptoglobina ↓. **Necrosis:** GPT (más específica) y GOT; GPT > GOT viral, GOT > GPT alcohólica. **Colestasis:** FA, GGT, 5′-nucleotidasa. **Función:** albúmina, tiempo de protrombina (prueba de Koller).

Imágenes: ecografía primero (vía biliar dilatada = obstructiva), colangiorresonancia, CPRE.

Preguntas de repaso (choice)

1. ¿Cuál bilirrubina produce **coluria**?
    A. La indirecta, porque es liposoluble.
    B. Ninguna: la coluria es por urobilina.
    C. Ambas por igual.
    D. La directa, porque es hidrosoluble y se filtra.

2. Ictericia con **orina parda sin coluria**, heces **hipercólicas**, anemia y esplenomegalia:
    A. Poshepática.
    B. Pseudoictericia.
    C. Prehepática (hemolítica).
    D. Hepatocelular.

3. Coluria + acolia + prurito orientan a ictericia:
    A. Fisiológica del neonato.
    B. Por Gilbert.
    C. Prehepática.
    D. Poshepática (obstructiva).

4. El síndrome de **Gilbert** altera:
    A. El colédoco.
    B. La conjugación grave del neonato.
    C. La excreción: sube la directa.
    D. La captación: sube la indirecta.

5. Hombre de 68 años, ictericia progresiva de meses, pérdida de peso y **vesícula palpable no dolorosa**. Según Courvoisier-Terrier:
    A. Hepatitis A.
    B. Síndrome de Gilbert.
    C. Cáncer de cabeza de páncreas hasta que se demuestre lo contrario.
    D. Coledocolitiasis.

6. ¿Por qué la obstrucción **litiásica** no distiende la vesícula?
    A. Porque la pared vesicular está fibrosada y no se dilata.
    B. Porque la bilis se reabsorbe.
    C. Porque el cálculo es pequeño.
    D. Porque no hay obstrucción real.

7. La **pseudoictericia** se diferencia porque:
    A. Tiñe las escleróticas.
    B. Da coluria.
    C. Respeta la esclerótica y la bilirrubina es normal.
    D. Es siempre por hemólisis.

8. Tinte **verdínico** (verde aceituna) orienta a:
    A. Lesión hepatocelular.
    B. Pseudoictericia.
    C. Hemólisis.
    D. Colestasis.

9. Transaminasas con **GOT > GPT** sugieren:
    A. Hepatitis viral.
    B. Hemólisis.
    C. Colestasis pura.
    D. Hepatitis alcohólica.

10. Paciente ictérico con tiempo de protrombina prolongado que **corrige** con vitamina K (Koller). Indica:
    A. Colestasis (falta de absorción de vitamina K).
    B. Lesión hepatocelular grave.
    C. Síndrome de Gilbert.
    D. Hemólisis.

11. Son marcadores de **colestasis**:
    A. LDH, reticulocitos, haptoglobina.
    B. Amilasa y lipasa.
    C. GPT y GOT.
    D. Fosfatasa alcalina, GGT y 5′-nucleotidasa.

12. El **kernicterus** se produce por:
    A. Carotenos en la piel.
    B. Bilirrubina directa en el riñón.
    C. Bilirrubina directa en el hígado.
    D. Bilirrubina indirecta en los núcleos de la base del neonato.

Respuestas

1. **D** — Correcto.
2. **C** — Correcto: ↑ indirecta.
3. **D** — Correcto: síndrome coledociano.
4. **D** — Correcto: es la forma hereditaria más común.
5. **C** — Correcto.
6. **A** — Correcto.
7. **C** — Correcto.
8. **D** — Correcto.
9. **D** — Correcto.
10. **A** — Correcto.
11. **D** — Correcto.
12. **D** — Correcto.

CAPÍTULO 5

Examen físico del aparato digestivo

Inspección, auscultación, percusión y palpación del abdomen; ascitis, puntos dolorosos, hígado, bazo y vesícula, con cada maniobra en video.

NECESITÁS SABER

- Anatomía topográfica
- Examen del tórax (1.er parcial)

Examen físico del abdomen

Según el profe, es **uno de los exámenes físicos más preguntados**, junto con el respiratorio. Y marca tres cosas que, si no se saben, «los van a bochar»: **ascitis**, la **palpación** y los **puntos apendiculares**.

Orden y topografía
I · A · P · P · Por qué auscultar antes · 9 regiones / 4 cuadrantes

Inspección
Ombligo en dedo de guante ★ · Circulación colateral · Dinámica: hernias

Percusión
Traube · Ascitis ★ · Cóncava vs convexa

Palpación ★
Blumberg · Gueneau · Bazuqueo ★ · Puntos · hígado · bazo

AL TERMINAR VAS A PODER

- Ejecutar el examen en el orden correcto y explicar por qué se ausculta antes de palpar.
- Reconocer ascitis con la percusión y sus tres maniobras.
- Ubicar los puntos dolorosos y saber qué indica cada uno.
- Nombrar y hacer las maniobras de hígado, bazo y vesícula (con el video).

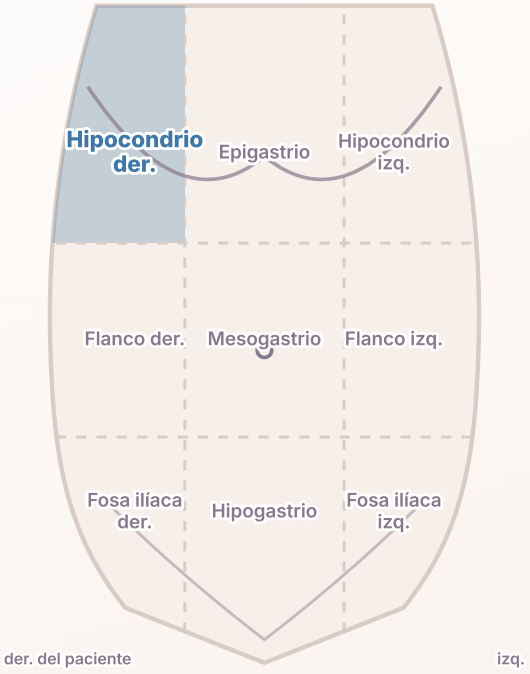
Posición, topografía y orden

IMPRESCINDIBLE

> Decúbito dorsal relajado. Inspección → auscultación → percusión → palpación.

Topografía: tocá cada región

Hipocondrio derecho | Epigastrio | Hipocondrio izquierdo | Mesogastrio | Fosa ilíaca derecha | Fosa ilíaca izquierda



Hipocondrio derecho

Hígado, vesícula, ángulo hepático del colon, riñón derecho.

Líneas horizontales: a la altura de la 10.ª costilla y de las espinas ilíacas; verticales: continuación de las medioclaviculares. Se puede usar también la división en 4 cuadrantes por el ombligo.

FUENTE Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 00:44

Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 01:28 | Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 02:14 | Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 02:56 | Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 05:00 | Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 05:42

Inspección estática y dinámica

IMPRESCINDIBLE

> Forma, ombligo, piel, latidos y ondas; después, que saque y hunda la panza.

COMO EL PADRE NUESTRO

Abdomen distendido con el **ombligo hacia adentro**: obesidad o meteorismo. Con el **ombligo hacia afuera, en dedo de guante: embarazo o ascitis**. «Esto lo tienen que saber como el Padre Nuestro.»

FUENTE Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 07:46

Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 08:30

Formas del abdomen

	Cómo se ve	Pensar en
GLOBOSO	Distendido en forma generalizada	Obesidad, meteorismo, ascitis, embarazo
EN BATRACIO	Acostado, el líquido cae a los flancos	**Ascitis**
EXCAVADO	Retraído, hundido	Desnutrición, caquexia, infecciones crónicas
EN TABLA	Rígido, no se mueve con la respiración	**Peritonitis** (contractura involuntaria)
EN DELANTAL	Cae sobre el pubis	Obesidad mórbida
ABOVEDAMIENTO ASIMÉTRICO	Bulto localizado	Tumor, hernia, visceromegalia

FUENTE Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 09:57

Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 11:22

Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 12:45

PIEL

Circulación colateral

Portocava: desde el ombligo, en **cabeza de medusa** (hipertensión portal). **Cavocava**: ascendente, del pubis hacia el tórax.

PIEL

Estrías

Rojo-vinosas: Cushing. **Nacaradas**: secuela de embarazos o de bajar de peso.

VELLO

Hábito de Chvostek

Hombre con vello pubiano **ginecoide**, ginecomastia y atrofia testicular: hepatopatía crónica (↑ estrógenos).

OMBLIGO

Nódulo de la hermana María José

Nódulo carnoso umbilical: **metástasis** de tumores de estómago, páncreas o intestino.

LATIDOS

Aorta y ondas peristálticas

Latido intenso arriba y a la izquierda del ombligo: aneurisma. Ondas peristálticas **dolorosas**: obstrucción.

CICATRICES

Abdomen asimétrico

Kocher (vesícula), mediana, McBurney y Lanz (apéndice), Pfannenstiel (cesárea). Buscar **eventraciones**.

INSPECCIÓN DINÁMICA Y MANIOBRA DEL ESFUERZO

«Saque la panza... húndala». Con el esfuerzo (levantar la cabeza, brazos y piernas) aparecen **hernias**, **eventraciones** y la **diástasis de los rectos** (se separan sobre la línea alba).

FUENTE Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 22:57

Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 24:23

Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 25:47

FUENTE Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 06:22

Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 13:29

Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 14:55

Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 17:11

Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 20:49

Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 21:32

Auscultación

MUY IMPORTANTE

> Con membrana, antes de palpar. Ruidos hidroaéreos y soplos.

Ruidos hidroaéreos

Lucha	Normal	Silencio
Aumentados	Continuos	Ausentes

Tocá un escalón para ver el detalle.

SOPLO

Aorta

Arriba y a la izquierda del ombligo: **aneurisma de aorta**.

SOPLO

Arterias renales

Joven hipertenso: **HTA renovascular**.

SOPLO / MURMULLO

Mesentéricas · porta

Mesentérico: isquemia. Murmullo venoso umbilical: hipertensión portal avanzada.

FUENTE Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 26:35

Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 27:21 · Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 28:46

Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 29:31 · Clase Examen físico digestivo · parte 1 · min 30:13

Percusión, espacio de Traube y ascitis ★

IMPRESCINDIBLE

> Sin rebote y radiada. Ascitis: matidez cóncava, onda ascítica, témpano, matidez desplazable.

ASCITIS

«Ascitis tienen que sabérsela **como la palma de su mano**... cualquier profesor les va a preguntar ascitis y si no saben ascitis, **los van a bochar**.»

FUENTE Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 03:35

Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 04:17

Abdomen distendido: percutí

Timpanismo generalizado
Gas: meteorismo, obstrucción

★ **Matidez cóncava hacia arriba**
Líquido libre: ascitis o hemoperitoneo

Matidez convexa hacia arriba
Embarazo, globo vesical, quiste de ovario, mioma

Hacen falta habitualmente más de 1 litro para detectar ascitis con la percusión.

LA MÁS SENSIBLE

Matidez desplazable

Decúbito lateral: el límite mate se corre hacia el lado declive.

ASCITIS A TENSIÓN

Onda ascítica

Golpeteo en un flanco, se percibe en el otro; borde de mano en la línea media.

CON HEPATOMEGALIA

Témpano

Al hundir bruscamente, el hígado «rebota» como hielo en el agua.

ESPACIO SEMILUNAR DE TRAUBE

Base del hemitórax izquierdo, normalmente **timpánico** por la cámara gástrica. Límites: corazón arriba, lóbulo izquierdo del hígado adentro, **bazo** afuera, reborde costal abajo. Si está **mate**: esplenomegalia, derrame pleural izquierdo, cardiomegalia, hepatomegalia izquierda o tumor gástrico.

FUENTE Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 01:31

Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 02:12

Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 02:55

FUENTE Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 00:03

Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 00:49

Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 04:58

Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 05:42

Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 06:31

Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 07:14

Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 07:59

Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 09:21

Palpación superficial: tensión, rebote y bazuqueo

IMPRESCINDIBLE

> Mano de escultor → tensión abdominal → compresión/descompresión. «La parte más preguntada.»

ÉNFASIS DEL PROFESOR

La palpación es «la parte **más preguntada**, la parte en la cual **bochan**... No se van a acordar de todos los nombres, pero lo importante es que lo **sepan realizar**».

FUENTE Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 10:56

Secuencia de la palpación superficial

1. **Mano de escultor** — Palma abierta por todo el abdomen: sensibilidad, temperatura, bultos.
2. **Esfuerzo** — Si hay un bulto: ¿está en la pared o adentro?
3. **Tensión abdominal** — Flexiones metacarpofalángicas de abajo hacia arriba, comparando lados.
4. **Compresión / descompresión** — Visceral vs parietal: Blumberg o Gueneau de Mussy.

CUANDO EL ABDOMEN ESTÁ MUY TENSO

Contractura

- **Involuntaria**
- Irritación del peritoneo parietal
- Abdomen en tabla: **peritonitis**

Defensa

- **Voluntaria**
- El paciente «saca la mano»
- Inflamación local

BAZUQUEO GÁSTRICO: PREGUNTA DE PARCIAL

Tensión alta en epigastrio e hipocondrio izquierdo y, al hundir con la punta de los dedos, un **chapoteo** «como cuando le pegás palmadas al agua»: líquido retenido. Signo característico del **síndrome pilórico**.

FUENTE Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 17:14

Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 17:57

MANIOBRAS DE RELAJAMIENTO

Con una mano activa que palpa y otra pasiva que relaja la pared: **Galambos**, Obrastzov. La palpación digital o en pinza busca el signo de Godet en el edema de pared.

FUENTE Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 11:41

Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 12:23

FUENTE Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 13:04

Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 13:44

Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 14:26

Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 15:51

Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 16:32

Puntos dolorosos

IMPRESCINDIBLE

> Apendiculares, pancreáticos y biliares: «me los saben todos». Los gastrointestinales y mesentéricos casi nunca los preguntan.

Apendiculares: McBurney

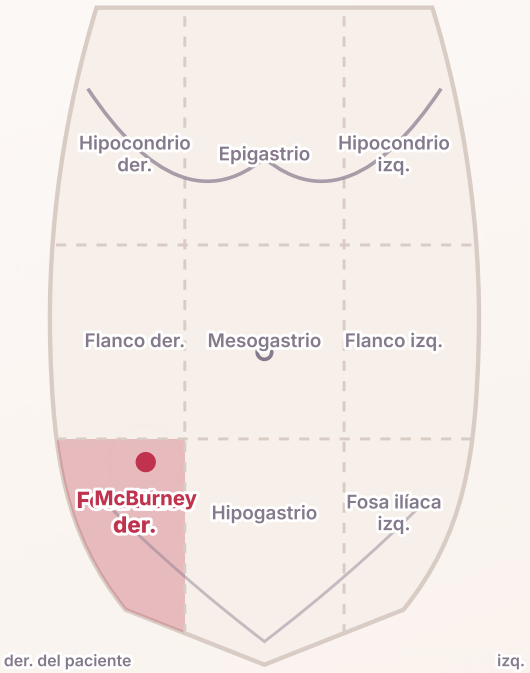
Cístico (Murphy)

Epigástrico

Hemicinturón (pancreático)

Paracentesis

Renales y ureterales



Apendiculares: McBurney

Unión del tercio externo con los dos tercios internos de la línea ombligo–espina ilíaca anterosuperior. También **Morris**, **Lanz**, **Lecene**. «Como la palma de su mano.»

FUENTE Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 18:42

Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 19:24 · Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 20:04 · Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 20:45 · Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 21:27 · Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 22:48

Hígado, bazo y vesícula (con video)

IMPRESCINDIBLE

> Siempre desde la fosa ilíaca derecha hacia arriba, con la mano «al acecho» y pidiendo inspiración profunda.

Maniobras de la práctica (pizarra)

Maniobras	Clave

HÍGADO	Monomanual, cuchara, **Chauffard** (peloteo), **Mathieu** (enganche), **Gilbert**, Güemes	Empezar en la FID; borde normal 1–2 traveses de dedo en inspiración. **Hepatometría ≤ 12 cm**.
BAZO	Simple, bimanual propia, Galambos, cuchara, Middleton, **Naegeli**, **Merlo**, **Schuster**	Empezar en la FID (crece oblicuo). Debe **duplicar** su tamaño para palparse. **Castell** timpánico lo descarta.
VESÍCULA	**Murphy** (dos pulgares en el punto cístico)	Positivo: el dolor **corta la inspiración** (colecistitis). Vesícula palpable indolora en ictérico: **Bard y Pick / Courvoisier**.

FUENTE Fotos de pizarra (clases prácticas) · Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 26:14

CÓMO ES EL HÍGADO QUE PALPÁS

Cirrosis: firme, borde filoso, micronodular. **Hepatitis aguda**: grande, blando, doloroso. **Metástasis**: pétreo, macronodular, doloroso.

FUENTE Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 12

MIRÁ LAS MANIOBRAS

Cada maniobra está en la sección **Maniobras** de este capítulo, con el fragmento exacto del video.

FUENTE Fotos de pizarra (clases prácticas)

Hernias y eventraciones

MUY IMPORTANTE

Hernia

- Sale contenido por un orificio **anatómico que ya existía**
- Inguinal, crural, umbilical

Eventración

- Sale por un orificio **patológico**: una **cicatriz** que no cerró bien
- Después de una cirugía

	Significa
REDUCTIBLE	Se puede volver a meter con el dedo
IRREDUCTIBLE	No se puede reintroducir
COERCIBLE	Una vez reducida, **no vuelve a salir**
INCOERCIBLE	Se reduce pero **vuelve a salir**

FUENTE Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 25:33

FUENTE Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 23:28

Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 24:10 Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 24:51

Clase Examen físico digestivo · parte 2 · min 25:33

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Orden del examen

Para qué sirve: No equivocarse en el práctico.

- Inspección
- Auscultación
- Percusión
- Palpación

Cómo interpretarlo: Se ausculta antes porque palpar cambia los ruidos.

Mnemotecnia: «I-A-P-P»: primero mirás, después escuchás, después golpeás, al final tocás. — Tocar al final para no alterar lo que escuchás.

Ombligo en el abdomen distendido

Para qué sirve: «Como el Padre Nuestro».

- Hundido: obesidad, meteorismo
- Dedo de guante: embarazo, ascitis

Cómo interpretarlo: El líquido o el útero empujan el ombligo hacia afuera.

Mnemotecnia: Ombligo AFUERA = Agua o bebé. — Ascitis o embarazo.

Ascitis

Para qué sirve: Lo que «los va a bochar».

- Matidez cóncava
- Matidez desplazable
- Onda ascítica
- Témpano

Cómo interpretarlo: Cóncava = líquido; convexa = masa central.

Mnemotecnia: Cóncava como una SONRISA: el agua se va a los costados. — El líquido cae a los flancos y el gas queda arriba en el centro.

Traube

Para qué sirve: Interpretar la percusión.

- Normal: timpánico (cámara gástrica)
- Mate: bazo, pleura, corazón, hígado izq., tumor gástrico

Cómo interpretarlo: Cada límite del espacio es una causa de matidez.

Mnemotecnia: Traube mate: «Bazo, Pleura, Corazón, Hígado, Estómago». — Recorrés los vecinos del espacio.

Murphy y Courvoisier

Para qué sirve: Vesícula en el examen.

- Murphy +: dolor que corta la inspiración
- Vesícula palpable indolora + ictericia: Courvoisier

Cómo interpretarlo: Dolorosa = inflamada; indolora y grande = tumor.

Mnemotecnia: Murphy CORTA la respiración. — Si no interrumpe la inspiración, no es Murphy positivo.

Integración: lo imprescindible

- Orden: **inspección, auscultación, percusión, palpación** (palpar modifica los RHA).
- Ombligo en **dedo de guante**: embarazo o ascitis.
- **Ascitis**: matidez cóncava, **matidez desplazable** (la más sensible), onda ascítica, témpano.
- **Traube** mate: esplenomegalia, derrame pleural izquierdo, cardiomegalia, hepatomegalia izquierda, tumor gástrico.
- **Bazuqueo** = síndrome pilórico. **Blumberg** localizado / **Gueneau de Mussy** generalizado.
- Hígado y bazo: empezar en la **FID**, mano al acecho, inspiración profunda. **Murphy**: el dolor corta la inspiración.

Desarrollos modelo

1. ¿Cómo diagnostica ascitis en el examen físico?

Inspección: abdomen globoso, ombligo en **dedo de guante**; acostado, abdomen en **batracio**.

Percusión radiada: matidez con límite **cóncavo hacia arriba** (el líquido cae a los flancos). Si es convexa, pensar en embarazo, globo vesical o tumor.

Maniobras: matidez desplazable (la más sensible), **onda ascítica**, **témpano** (con hepatomegalia). Si el líquido no se desplaza: plastrón.

2. ¿Qué es el bazuqueo (chapoteo) gástrico y qué indica?

Chapoteo que se percibe al hundir el epigastrio con la punta de los dedos (durante la toma de la tensión abdominal), por **líquido retenido en el estómago**. Es el signo característico del **síndrome pilórico** (fase de atonía).

3. ¿En qué orden se examina el abdomen y por qué difiere del tórax?

Inspección, auscultación, percusión y palpación. Se ausculta **antes** de palpar porque la palpación modifica los ruidos hidroaéreos espontáneos. Paciente en decúbito dorsal, relajado, sin almohada.

4. Abdomen distendido: ¿qué te dice el ombligo?

Ombligo **hundido**: obesidad o meteorismo. Ombligo **hacia afuera (en dedo de guante)**: embarazo o ascitis. Una distensión localizada orienta a globo vesical, quiste de ovario o tumor.

5. Describa los puntos dolorosos apendiculares, biliares y pancreáticos.

Apendiculares: McBurney (tercio externo de la línea ombligo–EIAS derecha), Morris, Lanz, Lecene. **Cístico:** reborde costal derecho y borde externo del recto (Murphy).

Pancreático: dolor epigástrico que va al hipocondrio izquierdo y se irradia a la espalda en **hemicinturón**. **Renales posteriores:** costovertebral y costomuscular.

6. ¿Qué es el espacio semilunar de Traube y qué puede borrar su timpanismo?

Zona de la base del hemitórax izquierdo, timpánica por la cámara gástrica. Límites: corazón, lóbulo izquierdo del hígado, bazo y reborde costal. Lo vuelven mate: **esplenomegalia**, derrame pleural izquierdo, cardiomegalia, hepatomegalia del lóbulo izquierdo, tumor gástrico.

7. Diferencie hernia de eventración. ¿Qué es reductible y coercible?

Hernia: salida de contenido por un orificio **anatómico preexistente**. **Eventración:** por un orificio **patológico** (cicatriz quirúrgica). **Reductible:** se reintroduce. **Coercible:** reducida, no vuelve a salir; **incoercible:** vuelve a salir.

Preguntas de repaso (choice)

1. ¿Por qué en el abdomen se ausculta **antes** de palpar?
    A. Porque así se hace en el tórax.
    B. Porque la auscultación duele menos.
    C. Porque la percusión requiere el abdomen relajado.
    D. Porque la palpación modifica los ruidos hidroaéreos espontáneos.

2. Abdomen distendido con **ombligo en dedo de guante**:
    A. Diástasis de los rectos.
    B. Embarazo o ascitis.
    C. Obesidad o meteorismo.
    D. Peritonitis.

3. Circulación colateral que parte del ombligo en **cabeza de medusa**:
    A. Normal en delgados.
    B. Portocava (hipertensión portal).
    C. Cavocava.
    D. Síndrome de Cushing.

4. Matidez abdominal con límite **convexo** hacia arriba sugiere:
    A. Ascitis.
    B. Meteorismo.
    C. Neumoperitoneo.
    D. Globo vesical, embarazo o tumor de ovario.

5. La maniobra de **mayor sensibilidad** para ascitis es:
    A. Murphy.
    B. Matidez desplazable.
    C. Onda ascítica.
    D. Témpano.

6. Líquido abdominal **encapsulado** que no se desplaza:
    A. Hernia.
    B. Hemoperitoneo.
    C. Ascitis libre.
    D. Plastrón.

7. La matidez del espacio semilunar de **Traube** puede deberse a:
    A. Neumoperitoneo.
    B. Esplenomegalia.
    C. Apendicitis.
    D. Meteorismo.

8. El **bazuqueo gástrico** es característico de:
    A. Úlcera perforada.
    B. Síndrome pilórico.
    C. Ascitis.
    D. Colecistitis.

9. El punto de **McBurney** se ubica en:
    A. Unión del tercio externo con los dos tercios internos de la línea ombligo–espina ilíaca anterosuperior derecha.
    B. El ángulo costovertebral.
    C. El reborde costal derecho y el borde del recto.
    D. El epigastrio.

10. La maniobra de Murphy es positiva cuando:
    A. Duele al soltar en FID.
    B. Hay chapoteo en epigastrio.
    C. Se palpa la vesícula indolora.
    D. El dolor en el punto cístico interrumpe la inspiración profunda.

11. ¿Por qué la palpación del bazo empieza en la **fosa ilíaca derecha**?
    A. Por costumbre.
    B. Para relajar la pared.
    C. Porque ahí está el polo superior.
    D. Porque el bazo crece en forma oblicua y una esplenomegalia masiva puede llegar ahí.

12. Salida de contenido abdominal por una **cicatriz quirúrgica**:
    A. Eventración.
    B. Hernia inguinal.
    C. Hernia umbilical.
    D. Diástasis de los rectos.

Respuestas

1. **D** — Correcto.
2. **B** — Correcto.
3. **B** — Correcto.
4. **D** — Correcto.
5. **B** — Correcto.
6. **D** — Correcto.
7. **B** — Correcto (también derrame pleural izquierdo, cardiomegalia, hepatomegalia izquierda, tumor gástrico).

8. **B** — Correcto: líquido retenido en el estómago.
9. **A** — Correcto.
10. **D** — Correcto.
11. **D** — Correcto.
12. **A** — Correcto.

CAPÍTULO 6

Síndrome esofágico

Los cinco síntomas, el cuadro de etiologías, del reflujo al Barrett y cómo se estudia el esófago.

NECESITÁS SABER

- Disfagia (dig-01)
- Histología del esófago

Síndrome esofágico

Abre el bloque de síndromes: para entenderlo hay que tener **motivos de consulta** y **examen físico**. El preguntero pide los **cinco síntomas** y el **cuadro de etiologías** con ejemplos.

5 síntomas
Disfagia · pirosis · Regurgitación (la más frecuente) · Odinofagia · dolor torácico

Etiologías
Inflamatorias · motoras · Tumorales · mecánicas · Cuadro con ejemplos

ERGE y Barrett
Esfínter incompetente · Metaplasia · Adenocarcinoma

Diagnóstico
Esofagograma primero · Manometría · endoscopía · pH-metría

AL TERMINAR VAS A PODER

- Nombrar los 5 síntomas y saber cuál es el más frecuente.
- Armar el cuadro de etiologías con un ejemplo de cada grupo.
- Explicar por qué el reflujo crónico lleva al Barrett y al adenocarcinoma.
- Elegir el estudio correcto: esofagograma, manometría, endoscopía o pH-metría.

Los cinco síntomas

IMPRESCINDIBLE

> Disfagia, pirosis, regurgitación, odinofagia y dolor torácico.

D P R O D

Tocá para desplegar

Acompañantes: eructos, halitosis, rumiación, sialorrea, sabor amargo y la sensación de globo.

LO QUE MÁS VAN A VER

«La regurgitación es lo **más frecuente**... se van a topar con ella»; va **asociada a pirosis en más del 90 %** de los casos. Es espontánea, sin esfuerzo, sobre todo de noche.

FUENTE Clase Síndrome esofágico · min 05:40 · Clase Síndrome esofágico · min 06:23 · Clase Síndrome esofágico · min 07:05

NO CONFUNDIR

Odinofagia

- **Dolor** al tragar
- Patología **orgánica**
- Causa n.º 1: **faringoamigdalitis** → revisar la garganta
- También esofagitis (Cándida, fármacos)

Globo histérico

- Sensación de algo atorado
- Patología **funcional** / psicológica
- Antecedentes de ansiedad, depresión, estrés

AGRAVAN LA PIROSIS

Café, mate, grasas, ejercicio, acostarse

Aumentan el contenido gástrico o la presión abdominal (abdominales después de comer), o se pierde la gravedad.

CALMAN LA PIROSIS

Antiácidos, IBP, alimentos alcalinos

En el ERGE, que desaparezca con antiácidos ayuda al diagnóstico.

FUENTE Clase Síndrome esofágico · min 01:26 | Clase Síndrome esofágico · min 02:09 | Clase Síndrome esofágico · min 02:49 | Clase Síndrome esofágico · min 04:57 | Clase Síndrome esofágico · min 07:49 | Clase Síndrome esofágico · min 09:56 | Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 368

El cuadro de etiologías

IMPRESCINDIBLE

> Inflamatorias, motoras, tumorales y mecánicas/estructurales.

Etiologías del síndrome esofágico

	Ejemplos	Pista
INFLAMATORIAS	**ERGE** (causa n.º 1 de esofagitis), eosinofílica, cáusticos, radiación, infecciones (Cándida, CMV, herpes)	Pirosis, **odinofagia** (síntoma cardinal de la esofagitis)
MOTORAS	**Acalasia** (idiopática o **Chagas**), espasmo difuso, esclerodermia	Disfagia para sólidos **y** líquidos, intermitente
TUMORALES	**Epidermoide** (1/3 medio) · **adenocarcinoma** (1/3 inferior, sobre Barrett)	Disfagia **progresiva**, tardía (2/3 de la luz)
MECÁNICAS	Estenosis péptica, anillo de **Schatzki**, **Plummer-Vinson**, divertículos (**Zenker**, epifrénico, tracción)	Disfagia solo para sólidos
OTRAS	**Várices esofágicas** (hipertensión portal), traumatismos: Mallory-Weiss, perforación, cuerpo extraño	—

FUENTE Clase Síndrome esofágico · min 11:19 | Clase Síndrome esofágico · min 14:48 | Clase Síndrome esofágico · min 20:57 | Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 368 | Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 369

Cáncer de esófago: los dos tipos

	Epidermoide (escamoso)	Adenocarcinoma
FRECUENCIA	El más frecuente (**90 %**)	En aumento: hoy se equipara
DÓNDE	**Tercio medio**	**Tercio inferior** (y cardias)
SE ASOCIA A	**Tabaco y alcohol**	**Barrett** y ERGE
QUIÉN	Hombres (4:1), adultos	Hombres (4:1), adultos

FUENTE Clase Síndrome esofágico · min 12:44 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 368

FUENTE Clase Síndrome esofágico · min 11:19 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 368

ERGE, esofagitis y esófago de Barrett

IMPRESCINDIBLE

> El esfínter inferior falla, el ácido daña la mucosa y el epitelio se transforma para resistir.

BARRETT

Metaplasia del **tercio inferior**: el epitelio **plano estratificado** se cambia por **cilíndrico simple** para soportar la acidez. Es un factor **preneoplásico**: sobre él aparece el **adenocarcinoma**.

FUENTE Clase Síndrome esofágico · min 13:25 · Clase Síndrome esofágico · min 14:05

¿Por qué falla el esfínter? (libro p. 369)

CAUSA
Relajaciones transitorias del esfínter inferior, **hernia hiatal**, trastornos del peristaltismo

→

MECANISMO
El contenido gástrico refluye y no se aclara

→

MANIFESTACIÓN
Pirosis (el síntoma más común), regurgitación, esofagitis

La asociación con **disfagia** es un síntoma de **alarma** por su relación con la estenosis péptica y el adenocarcinoma.

NOTA

La clasificación de **Los Ángeles** del reflujo existe, pero el profe aclara que no la tienen que saber ahora (es de medicina interna).

FUENTE Clase Síndrome esofágico · min 16:55

FUENTE Clase Síndrome esofágico · min 15:30 Clase Síndrome esofágico · min 16:12 Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 369

Acalasia en un minuto

MUY IMPORTANTE

> Aperistalsis + esfínter inferior que no se relaja → dolicomegaesófago.

CAUSA
Falta el plexo de **Auerbach**: idiopática (la más frecuente) o **Chagas**

→

MECANISMO
Aperistalsis + el esfínter inferior **no se relaja** (tono aumentado)

→

MANIFESTACIÓN
La comida se estanca: **dolicomegaesófago**; disfagia esofágica, regurgitación, dolor torácico

PARA ENTENDERLO

En el Chagas, el *Trypanosoma cruzi* se aloja en las células del plexo mientérico (esófago, colon, corazón) y las destruye: la acalasia aparece años después. Profundizado en **dig-01**.

FUENTE Clase Síndrome esofágico · min 19:37 Clase Síndrome esofágico · min 20:17

FUENTE Clase Síndrome esofágico · min 16:55 Clase Síndrome esofágico · min 17:36 Clase Síndrome esofágico · min 18:17 Clase Síndrome esofágico · min 18:57 Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 369

Cómo se estudia el esófago

IMPRESCINDIBLE

> Clínica y examen físico dan la presunción; las imágenes, la certeza.

En orden



1 — Esofagograma

El más útil y **no invasivo**: pico de pájaro, manzana mordida.

2 — Manometría

Gold standard de la acalasia (mide la presión del esfínter).

3 — Endoscopía + biopsia

Certeza del **cáncer**, esofagitis, várices. Invasiva.

4 — pH-metría ambulatoria

La más confiable para el **reflujo**, sobre todo con síntomas atípicos.

FUENTE Clase Síndrome esofágico · min 21:38 · Clase Síndrome esofágico · min 22:21 · Clase Síndrome esofágico · min 23:01 · Clase Síndrome esofágico · min 23:42 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 369

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Los 5 síntomas

Para qué sirve: Pregunta del preguntero.

- Disfagia
- Pirosis
- Regurgitación
- Odinofagia
- Dolor torácico

Cómo interpretarlo: La regurgitación es la más frecuente.

Mnemotecnia: D-P-R-O-D: «De Pronto Regurgito, Oh, Dolor». — Una frase con los cinco en orden.

Epidermoide vs adenocarcinoma

Para qué sirve: Diferenciar los cánceres.

- Epidermoide: 1/3 medio, tabaco y alcohol, 90 %
- Adeno: 1/3 inferior, Barrett

Cómo interpretarlo: El adenocarcinoma sigue al reflujo; el epidermoide, al tabaco y al alcohol.

Mnemotecnia: ADENO = ABAJO. — El adenocarcinoma está en el tercio inferior.

Qué estudio para qué

Para qué sirve: Responder diagnóstico.

- Esofagograma: primero
- Manometría: acalasia
- Endoscopía: biopsia
- pH-metría: reflujo

Cómo interpretarlo: De lo menos invasivo a lo que da certeza.

Mnemotecnia: Foto → presión → mirar y cortar → medir ácido. — Esofagograma, manometría, endoscopía con biopsia, pH-metría.

Integración: lo imprescindible

- **5 síntomas**: disfagia, pirosis, **regurgitación** (la más frecuente), odinofagia, dolor torácico.
- Odinofagia: causa n.º 1 **faringoamigdalitis**; globo histérico = funcional.
- Etiologías: inflamatorias (**ERGE** n.º 1), motoras (**acalasia**), tumorales, mecánicas.
- Epidermoide: **1/3 medio**, tabaco y alcohol. Adenocarcinoma: **1/3 inferior**, sobre **Barrett**.
- Esofagograma primero; **manometría** = gold standard de acalasia; endoscopía con biopsia; pH-metría para reflujo.

Desarrollos modelo

1. Defina síndrome esofágico. ¿Cuáles son los cinco síntomas asociados?

Conjunto de manifestaciones originadas en el esófago, que se expresa por **cinco síntomas** solos o asociados: **disfagia**, **pirosis**, **regurgitación** (la más frecuente, con pirosis en > 90 %), **odinofagia** y **dolor torácico** de origen esofágico.

Otros: eructos, halitosis, rumiación, sialorrea y globo histérico.

2. Realice un cuadro de las etiologías del síndrome esofágico con ejemplos.

GRUPO	EJEMPLOS
Inflamatorias	ERGE (causa n.º 1), eosinofílica, cáusticos, radiación, infecciosas
Motoras	Acalasia (idiopática o Chagas), espasmo difuso, esclerodermia
Tumorales	Epidermoide (1/3 medio, 90 %), adenocarcinoma (1/3 inferior, Barrett)
Mecánicas	Estenosis péptica, Schatzki, Plummer-Vinson, Zenker, compresión extrínseca
Otras	Várices esofágicas, traumatismos (Mallory-Weiss, perforación)

3. ¿Qué es el esófago de Barrett y por qué es importante?

Metaplasia del **tercio inferior** del esófago: el epitelio plano estratificado se reemplaza por **cilíndrico** para soportar el reflujo ácido crónico (ERGE). Es **preneoplásico**: predispone al **adenocarcinoma** del tercio inferior, más frecuente en hombres.

4. ¿Qué estudios solicita ante un síndrome esofágico y qué aporta cada uno?

Esofagograma (primero, no invasivo: pico de pájaro en acalasia, manzana mordida en cáncer); **manometría** (gold standard de acalasia); **endoscopía con biopsia** (certeza de cáncer, esofagitis, várices); **pH-metría ambulatoria** (la más confiable para reflujo).

5. Diferencie odinofagia de globo histérico.

Odinofagia: dolor al tragar, orgánico; causa más frecuente faringoamigdalitis (también esofagitis por Cándida o fármacos). **Globo histérico:** sensación de cuerpo extraño en la garganta, funcional, en pacientes ansiosos o deprimidos.

Preguntas de repaso (choice)

1. El síntoma **más frecuente** del síndrome esofágico, según el profe, es:
    A. Regurgitación.
    B. Odinofagia.
    C. Disfagia.
    D. Dolor torácico.

2. La causa más frecuente de **odinofagia** es:
    A. Cáncer de esófago.
    B. Acalasia.
    C. Esofagitis por reflujo.
    D. Faringoamigdalitis.

3. La causa más frecuente de **esofagitis** es:
    A. Cándida.
    B. Radiación.
    C. Cáusticos.
    D. Enfermedad por reflujo gastroesofágico.

4. El cáncer epidermoide de esófago se ubica típicamente en:
    A. El tercio inferior, sobre Barrett.
    B. El cardias exclusivamente.
    C. El tercio medio.
    D. El esfínter superior.

5. El esófago de Barrett es:
    A. Un divertículo faringoesofágico.
    B. Una displasia del tercio medio por alcohol.
    C. La dilatación del esófago en la acalasia.
    D. La metaplasia del tercio inferior a epitelio cilíndrico por reflujo crónico.

6. Paciente con pirosis de años que comienza con **disfagia**. Esto es:
    A. Esperable y benigno.
    B. Un síntoma de alarma (estenosis péptica o adenocarcinoma).
    C. Globo histérico.
    D. Signo de acalasia.

7. ¿Qué estudio se pide **primero** ante un síndrome esofágico?
    A. Endoscopía.
    B. Esofagograma con bario.
    C. Tomografía.
    D. Manometría.

8. El **gold standard** para diagnosticar acalasia es:
    A. Biopsia.
    B. Esofagograma.
    C. Manometría esofágica.
    D. pH-metría.

9. En Argentina, una causa **secundaria** frecuente de acalasia es:
    A. Reflujo.
    B. Chagas.
    C. Helicobacter pylori.
    D. Alcohol.

10. Esofagograma con imagen en **manzana mordida**. El paso siguiente es:
    A. Control en 6 meses.
    B. pH-metría.
    C. Endoscopía con biopsia.
    D. Manometría.

Respuestas

1. **A** — Correcto: asociada a pirosis en más del 90 %.
2. **D** — Correcto: por eso primero se revisa la garganta.
3. **D** — Correcto.
4. **C** — Correcto (90 %, tabaco y alcohol).
5. **D** — Correcto.
6. **B** — Correcto.
7. **B** — Correcto: el más útil y no invasivo.
8. **C** — Correcto.
9. **B** — Correcto: destruye el plexo mientérico.
10. **C** — Correcto: extensión y diagnóstico de certeza.

CAPÍTULO 7

Síndrome ulceroso y gastritis

Defensa vs agresión de la mucosa, Helicobacter y AINE, úlcera duodenal vs gástrica, complicaciones y gastritis A vs B.

NECESITÁS SABER

- Dispepsia (dig-01)
- Fisiología gástrica

Úlcera péptica y gastritis

«Lo más importante que vamos a ver... **pregunta muchísimo** : síndrome ulceroso y gastritis, pregunta de parcial, **tanto en el oral como en el choice** .»

Úlcera
Definición · Antro y duodeno ★ · Duodenal vs gástrica

Por qué se forma
Barrera mucosa · H. pylori · AINE ★ · Zollinger-Ellison

Diagnóstico y complicaciones
VEDA = gold standard ★ · Tests de H. pylori · Hemorragia · perforación · píloro ★

Gastritis
Erosiva vs no erosiva · Tipo A vs tipo B ★ · Anemia perniciosa

AL TERMINAR VAS A PODER

- Definir úlcera y decir dónde aparece.
- Explicar cómo producen úlcera el Helicobacter y los AINE.
- Saber que el gold standard es la endoscopía y nombrar las tres complicaciones.
- Diferenciar gastritis A de gastritis B.

Qué es una úlcera y dónde aparece

IMPRESCINDIBLE

> Pérdida de sustancia que atraviesa la muscular de la mucosa: queda expuesta al ácido.

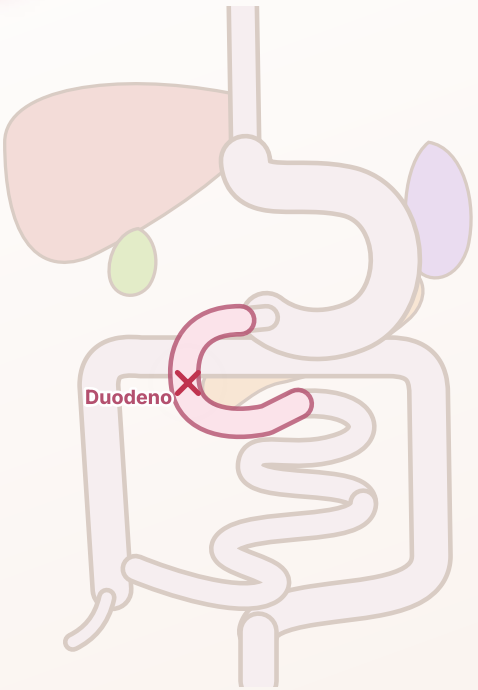
LO MÁS PREGUNTADO

«Lo que vamos a hablar ahora es lo más importante y **pregunta muchísimo**... tanto en el **oral** como en el **choice**: úlcera péptica y gastritis.»

FUENTE Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 1 · min 00:03

Dónde se ubican

Duodeno (1.ª y 2.ª porción) | Antro gástrico | Otras



Duodeno (1.ª y 2.ª porción)

La localización **más frecuente** (unas 5 veces más que el estómago): úlcera **duodenal**.

«Antro gástrico y primera y segunda porción del duodeno: eso sí o sí se tienen que saber.»

ÚLCERA VERDADERA VS EXULCERACIÓN

Crónica = úlcera verdadera

- Atraviesa la muscular de la mucosa
- Antro y duodeno
- Única (o pocas), 2–4 cm
- **Fibrosis**

Aguda = exulceración

- No atraviesa la muscular de la mucosa
- Al azar, múltiples
- Pequeñas
- Sin fibrosis

FUENTE Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 1 · min 00:44

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 1 · min 01:25

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 1 · min 02:05

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 1 · min 02:46

Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 370

Defensa vs agresión: Helicobacter, AINE y Zollinger

IMPRESCINDIBLE

> Las dos causas más frecuentes: Helicobacter pylori y antiinflamatorios.

FACTORES DE RIESGO MÁS FRECUENTES

«Los factores de riesgo más frecuentes en todo paciente con úlcera péptica: **colonización por Helicobacter pylori** y **consumo de AINE y aspirina**.»

FUENTE Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 2 · min 15:41

TUMOR

Zollinger-Ellison

Gastrinoma (páncreas) → mucha gastrina → **hiperclorhidria** (pH < 1) → epigastralgia y **úlceras múltiples**. Tratamiento: sacar el tumor.

EXÓGENOS

Corticoides, estrés, cirugías

Corticoides (fosfolipasa A2), estrés crónico (cortisol), cirugías mayores.

HÁBITOS

Tabaco, café, mate, alcohol

Sustancias irritantes para el epitelio gástrico.

FUENTE Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 1 · min 04:48

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 1 · min 05:28

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 2 · min 00:44

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 2 · min 15:01

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 2 · min 17:08

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 2 · min 22:51

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 2 · min 25:12

Úlcera duodenal vs gástrica

IMPRESCINDIBLE

> Dolor epigástrico urente, sin irradiación. La comida lo calma en la duodenal y lo empeora en la gástrica.

Duodenal vs gástrica

	Duodenal	Gástrica
FRECUENCIA	**Mucho más frecuente**	Menos frecuente
EDAD	Adultos **jóvenes**	**Mayores**
CON LA COMIDA	Suele **calmar**	**Empeora** (estimula el ácido)

MALIGNIDAD	Casi nunca	Puede ser un **cáncer ulcerado**
ENDOSCOPÍA	Diagnóstico	Siempre, con **biopsia**

FUENTE Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 2 · min 28:04
Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 2 · min 30:12
Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 2 · min 30:53
Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 2 · min 31:36

EL DOLOR (ALICIA)

Epigástrico, **urente** o quemante, **sin irradiación**, intermitente (3/10 a 10/10). Calman los antiácidos. Puede acompañarse de pirosis, eructos, náuseas y vómitos. **Pérdida de peso y anorexia** → pensar en úlcera **maligna** (más si es mayor de 50).

FUENTE Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 2 · min 26:39
Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 2 · min 27:21
Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 2 · min 29:30

NOTA

El **examen físico no revela nada** en la úlcera no complicada: lo fundamental es la anamnesis (AINE, estrés, mate, tabaco, alcohol, edad). Sirve cuando se complica (perforación).

FUENTE Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 2 · min 32:18

FUENTE Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 2 · min 26:39
Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 2 · min 32:18

Endoscopía y tests de Helicobacter

IMPRESCINDIBLE

> Gold standard: endoscopía digestiva alta con biopsia.

PREGUNTA DE CHOICE

«Preguntas de parcial, y esto lo preguntan en los choices: el **gold standard** de todo paciente con úlcera gástrica o duodenal es la **endoscopía digestiva alta**.» Ubica la úlcera, cuántas son, el tamaño y toma **biopsia**.

FUENTE Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 2 · min 33:00

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 2 · min 33:43

Cómo se busca el Helicobacter

	Qué es	Para qué / ojo
VEDA + BIOPSIA	Invasiva: cultivo / tinción (Giemsa)	**Gold standard** (especificidad ~100 %)
TEST DE UREASA	Invasiva: urea sobre la lesión; si se desdobla, hay H. pylori	Rápido, durante la endoscopía
SEROLOGÍA (ELISA)	No invasiva: anticuerpos	Poco específica: muchos falsos positivos
PCR	No invasiva	Muy específica pero **cara**
PRUEBA DEL ALIENTO	Urea marcada (C13/C14) por boca; se mide en el aire espirado	**Control de erradicación** después del tratamiento

FUENTE Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 00:45

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 01:26

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 02:10

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 02:53

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 04:27

TRATAMIENTO (TRIPLE ESQUEMA)

Inhibidor de la bomba + dos antibióticos: **OCA** (omeprazol, claritromicina, amoxicilina) u **OMA** (omeprazol, metronidazol, amoxicilina). En Zollinger: dosar **gastrina**.

FUENTE Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 02:53

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 00:00

FUENTE Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 00:00

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 05:11

Las tres complicaciones

IMPRESCINDIBLE

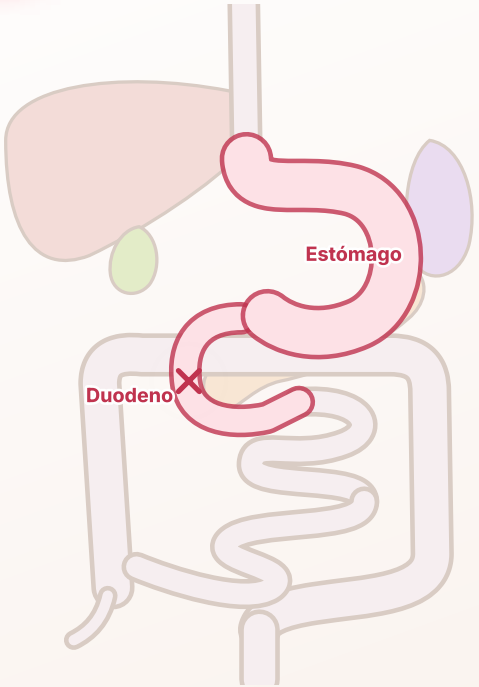
> Hemorragia (la más frecuente), perforación y síndrome pilórico.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

«¿Cuáles son las complicaciones? **Preguntas de parcial.**»

FUENTE Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 05:11

1 · Hemorragia digestiva alta | 2 · Perforación | 3 · Síndrome pilórico



1 · Hemorragia digestiva alta

La más frecuente: hematemesis, melena, hipotensión ortostática, taquicardia y anemia ferropénica.

FUENTE Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 05:11

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 05:55

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 06:43

Gastritis: erosiva, no erosiva, tipo A y tipo B

IMPRESCINDIBLE

> La no erosiva es «la que les van a preguntar»: tipo A (autoinmune) vs tipo B (bacteriana).

Gastritis: inflamación de la mucosa gástrica

- **Erosiva**
  Hemorrágica: la mucosa sangra (AINE)
- ★ **No erosiva**
  «La que les van a preguntar»
  - **Tipo A**
    Autoinmune
  - **Tipo B**
    Bacteriana (H. pylori)
  - **Tipo AB**

Aguda: neutrófilos. Crónica: fibrosis, metaplasia y **atrofia**, que se relaciona con el cáncer.

Tipo A vs tipo B (tapalo)

	Tipo A	Tipo B
CAUSA	**Autoinmune**: anticuerpos contra células parietales	**Bacteriana**: Helicobacter pylori
DÓNDE	**Fondo y cuerpo**	**Antro**
ÁCIDO	**Aclorhidria**	Normal o aumentado
GASTRINA	**Hipergastrinemia**	—

B12	Sin factor intrínseco → **anemia perniciosa**	Normal
SE ASOCIA A	Atrofia gástrica	**Úlcera**
CÁNCER	**Alto** riesgo de adenocarcinoma	Bajo riesgo

FUENTE Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 10:21

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 11:42

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 12:25

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 13:10

HIPERGASTRINEMIA: ¿ZOLLINGER O GASTRITIS A?

Zollinger-Ellison

- Células parietales **conservadas**
- **Hiperclorhidria**
- Úlceras múltiples

Gastritis tipo A

- Células parietales **destruidas**
- **Aclorhidria**
- Anemia perniciosa (macrocítica)

FUENTE Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 08:13

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 08:58

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 09:38

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 15:17

Clase Síndrome ulceroso y gastritis · parte 3 · min 15:58

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Dónde aparece la úlcera

Para qué sirve: «Sí o sí se tienen que saber».

- Duodeno 1.ª–2.ª porción (más frecuente)
- Antro gástrico

Cómo interpretarlo: Por eso se llaman gastroduodenales.

Mnemotecnia: DUO-deno primero, el doble de veces. — La duodenal es la más frecuente.

Las 3 complicaciones

Para qué sirve: Pregunta de parcial.

- Hemorragia (la más frecuente)
- Perforación
- Síndrome pilórico

Cómo interpretarlo: Sangra, se rompe o se cierra.

Mnemotecnia: Sangra, Perfora, Tapa. — Hemorragia, perforación, estenosis pilórica.

Gastritis A vs B

Para qué sirve: La no erosiva que preguntan.

- A: Autoinmune, fondo-cuerpo, Anemia perniciosa, Alto riesgo de cáncer
- B: Bacteriana, antro, úlcera

Cómo interpretarlo: Las letras ayudan.

Mnemotecnia: A = Autoinmune, Aclorhidria, Anemia, Arriba (fondo). B = Bacteria, Bajo (antro). — La A está arriba y la B abajo en el estómago.

Gold standard

Para qué sirve: Pregunta de choice.

- Úlcera: VEDA + biopsia
- H. pylori: VEDA + biopsia
- Control: prueba del aliento

Cómo interpretarlo: La endoscopía resuelve todo.

Mnemotecnia: Ante la duda: «mirá adentro» (VEDA). — La endoscopía es el gold standard.

Integración: lo imprescindible

- Úlcera: pérdida de sustancia que **atraviesa la muscular de la mucosa**; **duodeno** (más frecuente) y **antro**.
- Causas n.º 1: **H. pylori** (ureasa → amonio) y **AINE** (sin prostaglandinas, sin barrera).
- Duodenal: jóvenes, **calma** con la comida. Gástrica: mayores, **empeora**, biopsia.
- Gold standard: **VEDA con biopsia**. Prueba del aliento para control.
- Complicaciones: **hemorragia** (la más frecuente), **perforación**, **síndrome pilórico**.
- Gastritis **A**: autoinmune, aclorhidria, anemia perniciosa, alto riesgo de cáncer. **B**: H. pylori, antro, úlcera.

Desarrollos modelo

1. Defina úlcera péptica. ¿Cómo se clasifica?

Pérdida de sustancia de la pared gastroduodenal que **atraviesa la muscular de la mucosa** y la deja expuesta al ácido clorhídrico.

Por evolución: agudas (exulceraciones, múltiples, sin fibrosis) y crónicas (verdaderas, con fibrosis). **Por localización: duodeno** (1.ª–2.ª porción, la más frecuente) y **antro gástrico**; también esófago, anastomosis, yeyuno.

Duodenal: jóvenes, calma con la comida. **Gástrica:** mayores, empeora con la comida, siempre biopsia (cáncer ulcerado).

2. Mencione las principales etiologías de la úlcera péptica. ¿Qué es el síndrome de Zollinger-Ellison?

Helicobacter pylori (ureasa → urea → amonio tóxico + bicarbonato que alcaliniza y atrae más bacterias) y **AINE/aspirina** (inhiben COX → sin prostaglandinas → vasoconstricción → sin bicarbonato → sin barrera). También corticoides, estrés, cirugías mayores, tabaco, alcohol.

Zollinger-Ellison: gastrinoma (páncreas) → hipergastrinemia → hiperclorhidria → **úlceras múltiples** y epigastralgia. Se trata extirpando el tumor.

3. ¿Cuál es el gold standard para el diagnóstico de úlcera? ¿Cómo se diagnostica el Helicobacter pylori?

Endoscopía digestiva alta con biopsia (ubicación, número, tamaño, malignidad).

H. pylori: invasivas: VEDA con biopsia (gold standard), test de ureasa. No invasivas: serología (poco específica), PCR (cara), prueba del aliento (control de erradicación).

4. ¿Cuáles son las complicaciones de la úlcera péptica?

- **Hemorragia digestiva alta** (la más frecuente): hematemesis, melena, hipotensión ortostática, anemia ferropénica.
- **Perforación**: abdomen agudo perforativo (tabla, Gueneau de Mussy, Jobert, Popper).
- **Síndrome pilórico**: úlcera crónica fibrosada en el píloro → vómitos y pérdida de peso.

5. Defina gastritis, clasifíquela y diferencie gastritis tipo A y tipo B.

Inflamación de la mucosa gástrica, infecciosa o autoinmune. **Aguda/crónica**; **erosiva** (hemorrágica) / **no erosiva**: tipo A, B y AB.

Tipo A: autoinmune (anti células parietales), fondo y cuerpo, aclorhidria, hipergastrinemia, anemia perniciosa, **alto** riesgo de adenocarcinoma. **Tipo B:** bacteriana (H. pylori), antro, asociada a úlcera, bajo riesgo.

Preguntas de repaso (choice)

1. La localización **más frecuente** de la úlcera péptica es:
    A. Fondo gástrico.
    B. Yeyuno.
    C. Esófago.
    D. Primera porción del duodeno.

2. Las dos causas más frecuentes de úlcera péptica son:
    A. Zollinger-Ellison y corticoides.
    B. Alcohol y tabaco.
    C. Estrés y café.
    D. Helicobacter pylori y AINE.

3. Los AINE producen úlcera porque:
    A. Aumentan la secreción de gastrina.
    B. Producen ureasa.
    C. Inhiben la COX → sin prostaglandinas → vasoconstricción y pérdida de la barrera de bicarbonato.
    D. Destruyen las células parietales.

4. La **ureasa** del H. pylori daña la mucosa porque genera:
    A. Gastrina.
    B. Amonio (tóxico) y bicarbonato que alcaliniza y favorece más colonización.
    C. Más ácido clorhídrico.
    D. Prostaglandinas.

5. Joven con dolor epigástrico urente que **calma al comer**. Pensás en úlcera:
    A. Duodenal.
    B. Gástrica.
    C. Esofágica.
    D. Maligna.

6. El **gold standard** para el diagnóstico de úlcera péptica es:
    A. Seriada gastroduodenal.
    B. Prueba del aliento.
    C. Endoscopía digestiva alta con biopsia.
    D. Serología.

7. Para **controlar la erradicación** del H. pylori después del tratamiento se usa:
    A. Gastrina.
    B. Prueba del aliento con urea marcada.
    C. Seriada.
    D. Serología.

8. La complicación **más frecuente** de la úlcera péptica es:
    A. Malignización.
    B. Síndrome pilórico.
    C. Perforación.
    D. Hemorragia digestiva alta.

9. Paciente ulceroso con vómitos de alimentos ingeridos horas antes y pérdida de peso:
    A. Gastritis tipo A.
    B. Mallory-Weiss.
    C. Perforación.
    D. Síndrome pilórico por fibrosis de una úlcera crónica.

10. La gastritis **tipo A** se caracteriza por:
    A. Anticuerpos contra células parietales, aclorhidria y anemia perniciosa.
    B. Bajo riesgo de cáncer.
    C. Hiperclorhidria y úlceras múltiples.
    D. H. pylori en el antro.

11. Hipergastrinemia con **aclorhidria**. ¿Qué diagnóstico corresponde?
    A. Gastritis tipo B.
    B. Gastritis tipo A.
    C. Úlcera duodenal.
    D. Zollinger-Ellison.

12. Úlceras múltiples con pH gástrico menor a 1: pensás en:
    A. Gastrinoma (Zollinger-Ellison).
    B. Cáncer gástrico.
    C. Úlcera por estrés.
    D. Gastritis atrófica.

Respuestas

1. **D** — Correcto: unas 5 veces más que el estómago.
2. **D** — Correcto.
3. **C** — Correcto.
4. **B** — Correcto.
5. **A** — Correcto.
6. **C** — Correcto.
7. **B** — Correcto.
8. **D** — Correcto.
9. **D** — Correcto.
10. **A** — Correcto.
11. **B** — Correcto: sin células parietales no hay ácido.
12. **A** — Correcto.

CAPÍTULO 8

Síndrome pilórico e íleo

El estómago que no se vacía y el intestino que no avanza: causas, clínica, examen y diagnóstico.

NECESITÁS SABER

- Úlcera péptica (dig-07)
- Examen físico (dig-05)

Pilórico e íleo

Del **pilórico**, el profe dice que en el choice casi no aparece, «pero **sí lo van a preguntar en el oral**»: definición, causas, clínica y diagnóstico. El **íleo** «es preguntado en el **parcial, choice y oral**».

Pilórico
Obstrucción del píloro · Úlcera, tumor, congénita · Reversible vs irreversible

Clínica y diagnóstico
Vómito + pérdida de peso ★ · Bazuqueo · oliva · SNG 300/200 · VEDA

Íleo ★
Paralítico vs mecánico · Silencio vs lucha · Todo íleo es secundario

Causas de íleo
Posoperatorio ★ · Asa centinela · Bridas · vólvulo · invaginación

AL TERMINAR VAS A PODER

- Definir el síndrome pilórico y nombrar sus causas.
- Reconocer su clínica (vómito y pérdida de peso) y cómo se diagnostica.
- Diferenciar íleo paralítico de mecánico por el examen.
- Saber que la causa más frecuente de íleo paralítico es el posoperatorio.

Qué es y por qué se produce

MUY IMPORTANTE

> Obstrucción del píloro que impide el vaciamiento gástrico (más de 4 horas).

LO QUE HAY QUE SABER

«En el choice nunca he visto que lo preguntaran, pero **sí lo van a preguntar en el oral**»: la **definición**, las **principales patologías** y, sobre todo, la **clínica y el diagnóstico**.

FUENTE Clase Síndrome pilórico · min 04:59

Causas

	Ejemplos
OBSTRUCCIÓN DE LA LUZ	**Úlcera péptica** (duodenal 95 %), tumores gástricos o pancreáticos, inflamación vecina (colecistitis, pancreatitis, duodenitis), cáusticos
CONGÉNITA	**Estenosis hipertrófica del píloro** del recién nacido (menos de 1 mes): «muy frecuente»
SIN OBSTRUCCIÓN (FUNCIONAL)	Neuropatía **diabética**, fármacos anticolinérgicos, cirugías gástricas, anorexia nerviosa, esclerodermia

FUENTE Clase Síndrome pilórico · min 01:24 · Clase Síndrome pilórico · min 02:09 · Clase Síndrome pilórico · min 02:52 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 375

REVERSIBLE O IRREVERSIBLE

Reversible

- **Inflamación** y edema alrededor de una úlcera activa, espasmo
- Cede sola o con tratamiento médico

Irreversible

- **Fibrosis** cicatrizal que deforma el píloro; atonía gástrica
- 70–90 % de las obstructivas: **cirugía**

FUENTE Clase Síndrome pilórico · min 00:42 · Clase Síndrome pilórico · min 03:32 · Clase Síndrome pilórico · min 04:17 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 375

Clínica, examen y diagnóstico del pilórico

IMPRESCINDIBLE

> Vómito alimenticio tardío + pérdida de peso. Bazuqueo. SNG con más de 300 ml a las 4 h.

Síntomas (frecuencia, libro p. 375)

> 90 %	87 %	65 %	60 %	50 %	40 %
Vómito	Dolor epigástrico	Pérdida de peso	Saciedad precoz	Constipación	Náuseas

Tocá un escalón para ver el detalle.

El lactante con estenosis pilórica (menos de 1 mes)



Al examen, la **oliva pilórica**: el píloro hipertrofiado palpable unos 3–4 cm por debajo del xifoides (70–90 % de los lactantes).

FUENTE Clase Síndrome pilórico · min 08:28 · Clase Síndrome pilórico · min 13:29 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 376

EXAMEN

Bazuqueo + distensión

Abdomen superior distendido y **chapoteo gástrico**; peristaltismo gástrico visible al inicio; deshidratación (20 %), desnutrición.

SONDA NASOGÁSTRICA

> 300 ml a las 4 h

O **> 200 ml en ayunas** (lo normal es menos de 50–100 ml): diagnóstico muy probable.

GOLD STANDARD

Endoscopía alta

Ve la causa. Píloro normal: 15–20 mm; si no pasa el endoscopio (≈ 10–12 mm), hay estenosis. Rx contrastada: estómago dilatado con bario retenido.

FUENTE Clase Síndrome pilórico · min 05:43 · Clase Síndrome pilórico · min 07:47 · Clase Síndrome pilórico · min 10:38 · Clase Síndrome pilórico · min 12:03 · Clase Síndrome pilórico · min 14:12 · Clase Síndrome pilórico · min 15:36 · Clase Síndrome pilórico · min 16:18 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 376

Íleo paralítico vs mecánico

IMPRESCINDIBLE

> Parálisis del tránsito intestinal. Paralítico = silencio. Mecánico = lucha arriba, parálisis abajo.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

«Íleo es preguntado en el **parcial, choice y oral**... todos los doctores pueden preguntar esto.»

FUENTE Clase Íleo · min 02:11

El examen que te piden

	Paralítico	Mecánico
OBSTÁCULO	No	**Sí**

INSPECCIÓN	Distendido (en tabla si hay peritonitis)	**Distendido**, ondas peristálticas
AUSCULTACIÓN	**Silencio** (RHA ausentes)	RHA **de lucha** (arriba de la obstrucción)
PERCUSIÓN	Timpanismo	Timpanismo
DOLOR	Constante si hay peritonitis	**Cólico**: sube, baja y vuelve

FUENTE Clase Íleo · min 01:28 · Clase Íleo · min 13:38 · Clase Íleo · min 14:19

FUENTE Clase Íleo · min 00:01 · Clase Íleo · min 00:43

Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 376

Causas de íleo

IMPRESCINDIBLE

> Paralítico: posoperatorio (la más frecuente). Mecánico: simple o por estrangulación.

PREGUNTA DE PARCIAL

«¿Cuál es la causa más frecuente de íleo paralítico? El **íleo posoperatorio**»: después de una cirugía abdominal el intestino se paraliza **48 a 72 horas**. «Ese no se tiene que olvidar nunca.»

FUENTE Clase Íleo · min 02:54 · Clase Íleo · min 05:05

- **Íleo**
  - **Paralítico**
    - ★ **Posoperatorio**
      La causa más frecuente (48–72 h)
    - **Peritonitis / perforación**
      Íleo generalizado
    - **Inflamatorio**
      Regional: **asa centinela** (apendicitis, pancreatitis)

Vascular, tóxico, hipopotasemia, reflejo
Isquemia, uremia, opiáceos, cólico biliar o renal

Mecánico

Simple
Íleo biliar (cálculo en la válvula ileocecal), fecaloma, bezoar, áscaris, tumor

★
Estrangulación
Hernia atascada, **bridas**, **vólvulo** de sigmoides, **invaginación** (niños): riesgo de isquemia → cirugía

Invaginación intestinal en el niño: heces con sangre en «jalea de grosella».

★ **TODO ÍLEO ES SECUNDARIO**

El íleo es la consecuencia: siempre hay que buscar qué lo produjo (peritonitis, pancreatitis, brida...). Laboratorio completo con **amilasa**, ionograma (hipopotasemia, alcalosis) y radiografía o tomografía.

FUENTE Clase Íleo · min 15:01 Clase Íleo · min 15:41 Clase Íleo · min 16:22

FUENTE Clase Íleo · min 02:54 Clase Íleo · min 03:37 Clase Íleo · min 04:20 Clase Íleo · min 05:51 Clase Íleo · min 06:32 Clase Íleo · min 07:56 Clase Íleo · min 08:38 Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 376

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Síndrome pilórico

Para qué sirve: Para el oral.

- Obstrucción del píloro (> 4 h)
- Vómito alimenticio tardío + pérdida de peso
- Bazuqueo · SNG > 300 ml / > 200 ml ayuno · VEDA

Cómo interpretarlo: Adulto: úlcera duodenal. Lactante: estenosis congénita (oliva).

Mnemotecnia: «3-4-200-300»: más de 4 horas lleno; 200 ml en ayunas, 300 ml a las 4 h. — Los números de la sonda nasogástrica.

Paralítico vs mecánico

Para qué sirve: Lo más preguntado del íleo.

- Paralítico: silencio, sin obstáculo
- Mecánico: lucha arriba, parálisis abajo

Cómo interpretarlo: Escuchar el abdomen te da el tipo.

Mnemotecnia: Paralítico = Paz (silencio) · Mecánico = Motor que lucha. — Silencio vs ruidos de lucha.

Causa n.º 1 de íleo paralítico

Para qué sirve: Pregunta de parcial.

- Posoperatorio (48–72 h)

Cómo interpretarlo: Después de toda cirugía abdominal el intestino se detiene unos días.

Mnemotecnia: Lo operaron → 2 o 3 días «dormido». — 48 a 72 horas de parálisis.

Integración: lo imprescindible

- **Pilórico**: obstrucción del píloro (> 4 h); adulto: úlcera duodenal; lactante: estenosis hipertrófica.
- Clínica: **vómito alimenticio tardío** (síntoma cardinal) + **pérdida de peso**; bazuqueo; oliva pilórica.

- Diagnóstico: SNG **> 300 ml a las 4 h** o **> 200 ml en ayunas**; **VEDA** gold standard.
- **Íleo**: paralítico (silencio, sin obstáculo) vs mecánico (lucha arriba, parálisis abajo).
- Causa n.º 1 de íleo paralítico: **posoperatorio** (48–72 h). Mecánico por estrangulación: cirugía.

Desarrollos modelo

1. ¿Qué es el síndrome pilórico? Mencione su etiología (obstructiva y no obstructiva).

Conjunto de signos y síntomas por **obstrucción del píloro** que impide el vaciamiento gástrico (más de 4 horas).

Obstructivas: úlcera péptica (duodenal 95 %), tumores, inflamación vecina, estenosis hipertrófica congénita del lactante. **No obstructivas:** neuropatía diabética, anticolinérgicos, cirugías gástricas, anorexia nerviosa, esclerodermia.

2. Manifestaciones clínicas del síndrome pilórico y maniobra que se puede realizar.

Vómito (síntoma cardinal, > 90 %): alimenticio, 4–6 h después de comer, a menudo sin náuseas; **pérdida de peso**, saciedad precoz, dolor epigástrico, constipación, deshidratación y alcalosis. Lactante: vómitos, llanto y no sube de peso; **oliva pilórica**.

Maniobra: bazuqueo o chapoteo gástrico. **Diagnóstico:** SNG con > 300 ml a las 4 h o > 200 ml en ayunas; **VEDA** (gold standard).

3. ¿Qué es un íleo? Diferencie íleo paralítico de mecánico.

Íleo: parálisis del tránsito intestinal. **Paralítico (adinámico):** sin obstáculo, todo el intestino se detiene: abdomen distendido, timpánico, **silencio abdominal**. **Mecánico (obstructivo):** obstáculo: arriba peristaltismo de **lucha** (RHA aumentados, dolor cólico), abajo parálisis.

En ambos: no elimina gases ni heces, distensión, vómitos, hipopotasemia y alcalosis. **Todo íleo es secundario.**

4. Etiología del íleo paralítico y del íleo mecánico.

Paralítico: posoperatorio (la más frecuente, 48–72 h), peritonitis (perforativo), inflamatorio regional (**asa centinela**, pancreatitis), vascular, tóxico (uremia, opiáceos), hipopotasemia, reflejo, neurológico.

Mecánico simple: íleo biliar, fecaloma, bezoar, áscaris, neoplasias. **Por estrangulación:** hernia atascada, bridas, vólvulo de sigmoides, invaginación (niños): riesgo de isquemia, cirugía.

Preguntas de repaso (choice)

1. El síntoma **cardinal** del síndrome pilórico es:
    A. La ictericia.
    B. La diarrea.
    C. La hematemesis.
    D. El vómito.

2. El vómito del síndrome pilórico es típicamente:
    A. Fecaloide.
    B. Alimenticio, 4 a 6 horas después de comer.
    C. Hemático.
    D. Bilioso, inmediato.

3. La causa más frecuente de síndrome pilórico en el adulto es:
    A. Acalasia.
    B. Hernia hiatal.
    C. Úlcera péptica (duodenal).
    D. Estenosis congénita.

4. Por sonda nasogástrica, ¿qué volumen hace muy probable un síndrome pilórico **en ayunas**?
    A. Cualquier volumen.
    B. > 1000 ml.
    C. > 50 ml.
    D. > 200 ml.

5. Lactante de 3 semanas con vómitos en chorro, llanto y que no sube de peso. Al palpar el epigastrio encontrás:
    A. Signo de Murphy.
    B. Oliva pilórica.
    C. Cabeza de medusa.
    D. Signo de Jobert.

6. La causa **más frecuente** de íleo paralítico es:
    A. Bridas.
    B. El posoperatorio de cirugía abdominal.
    C. Peritonitis.
    D. Hipopotasemia.

7. Abdomen distendido, timpánico y con **silencio abdominal**:
    A. Síndrome pilórico.
    B. Íleo paralítico.
    C. Íleo mecánico.
    D. Normal.

8. En el íleo **mecánico**, los ruidos hidroaéreos:
    A. Solo se escuchan en el epigastrio.
    B. Están aumentados (de lucha) por arriba de la obstrucción.
    C. Están ausentes en todo el abdomen.
    D. Son normales siempre.

9. El íleo paralítico localizado que acompaña a una pancreatitis o apendicitis se llama:
    A. Megacolon.
    B. Asa centinela.
    C. Vólvulo.
    D. Íleo biliar.

10. El **íleo biliar** es:
    A. Un vólvulo de vesícula.
    B. Un íleo paralítico por cólico biliar.
    C. Una obstrucción mecánica por un cálculo impactado, en general en la válvula ileocecal.
    D. Una ictericia por obstrucción del colédoco.

Respuestas

1. **D** — Correcto (> 90 %).
2. **B** — Correcto.
3. **C** — Correcto.
4. **D** — Correcto (o > 300 ml a las 4 h de comer).
5. **B** — Correcto: píloro hipertrofiado.
6. **B** — Correcto (48–72 h).
7. **B** — Correcto.
8. **B** — Correcto.
9. **B** — Correcto.
10. **C** — Correcto.

CAPÍTULO 9

Malabsorción e intestino irritable

Las tres fases de la malabsorción, la esteatorrea, Van de Kamer y la D-xilosa; el intestino irritable y sus criterios de Roma.

NECESITÁS SABER

- Diarrea crónica (dig-03)
- Digestión y absorción

Malabsorción e intestino irritable

«Si no me dicen **diarrea crónica** en un síndrome de malabsorción, **los van a bochar**.» La **esteatorrea** se pregunta «en cualquier lado del mundo», el **Van de Kamer** «como el Padre Nuestro», y los **criterios de Roma** del intestino irritable son pregunta de parcial.

Fases
Intraluminal (páncreas, bilis) · Mucosa (celíaca) · Absortiva (linfa)

Clínica ★
Diarrea crónica · Esteatorrea · Déficits: anemia, tetania, sangrado

Diagnóstico ★
Van de Kamer · Sudán · D-xilosa · serología celíaca

Intestino irritable
Diagnóstico por exclusión · Roma ★ · Alarma → colonoscopía

AL TERMINAR VAS A PODER

- Ubicar una malabsorción en su fase y nombrar causas.
- Describir la esteatorrea y la tríada de la malabsorción.
- Explicar el Van de Kamer y la D-xilosa.
- Recitar los criterios de Roma del intestino irritable y sus signos de alarma.

Qué es la malabsorción y sus tres fases

IMPRESCINDIBLE

> Alteración de la digestión y/o absorción de macro y micronutrientes.

Causas por fase (libro p. 379)

	Qué falla	Ejemplos
INTRALUMINAL	La **digestión** en el duodeno: jugo pancreático, sales biliares (estómago < 5 %)	Pancreatitis crónica, fibrosis quística, cáncer de páncreas; obstrucción biliar, hepatopatías
MUCOSA	La **absorción** en yeyuno e íleon	**Celíaca** (esprue no tropical), esprue tropical, déficit de disacaridasas (lactosa)
ABSORTIVA	El **transporte linfático** de quilomicrones	Enteropatía perdedora de proteínas (rara)

FUENTE Clase Síndrome de malabsorción · parte 1 · min 03:00

Clase Síndrome de malabsorción · parte 1 · min 05:12

Clase Síndrome de malabsorción · parte 1 · min 10:22

Clase Síndrome de malabsorción · parte 1 · min 26:13

Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 379

ENFERMEDAD CELÍACA

Autoinmune: el **gluten** (gliadina de trigo, avena, cebada, centeno) activa anticuerpos que **destruyen las vellosidades** → menos superficie de absorción. Tiene fases (aguda, silente, latente); con dieta sin gluten, los anticuerpos se «apagan».

FUENTE Clase Síndrome de malabsorción · parte 1 · min 13:52

Clase Síndrome de malabsorción · parte 1 · min 15:18

Clase Síndrome de malabsorción · parte 1 · min 19:32

FUENTE Clase Síndrome de malabsorción · parte 1 · min 00:47

Clase Síndrome de malabsorción · parte 1 · min 02:13

Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 378

Diarrea crónica, esteatorrea y déficits

IMPRESCINDIBLE

> Diarrea crónica (cardinal) con esteatorrea + distensión + flatulencia ± pérdida de peso.

PARA NO BOCHAR

«La manifestación clínica cardinal... es la **diarrea crónica**. Si no me dicen diarrea crónica en un síndrome de malabsorción, **los van a bochar**.» Y la más frecuente es la **esteatorrea**: «pregunta de parcial, choice, final, oral, en cualquier lado del mundo».

FUENTE Clase Síndrome de malabsorción · parte 1 · min 28:19

Clase Síndrome de malabsorción · parte 1 · min 08:10

La tríada de la malabsorción



«...hay que pensar en un síndrome de malabsorción **hasta que se demuestre lo contrario**.» Esteatorrea: heces malolientes, pastosas, amarillentas o arcillosas, grasosas, **espumosas, que flotan**. Creatorrea (proteínas en heces): en cuadros más crónicos, como la pancreatitis crónica.

FUENTE Clase Síndrome de malabsorción · parte 1 · min 33:02

Clase Síndrome de malabsorción · parte 1 · min 08:53

Clase Síndrome de malabsorción · parte 1 · min 29:00

Déficit → manifestación (tapalo)

	Qué aparece

HIDRATOS DE CARBONO	Cansancio, astenia (falta la principal fuente de energía)
PROTEÍNAS	Pérdida de masa muscular, emaciación; **edema** por hipoalbuminemia
HIERRO	Anemia **ferropénica**, hipocrómica microcítica; coiloniquia
B12 / ÁCIDO FÓLICO	Anemia **megaloblástica** macrocítica; B12: síndrome neuroanémico
CALCIO / VITAMINA D	**Tetania** (Trousseau, Chvostek), raquitismo, osteomalacia, osteoporosis
VITAMINA K	**Fenómenos hemorrágicos**
VITAMINA A	Ceguera nocturna, xeroftalmia, queratomalacia
VITAMINAS B Y C	Piel y mucosas: pelagra, beriberi, escorbuto, queilitis, estomatitis

FUENTE Clase Síndrome de malabsorción · parte 2 · min 00:43

Clase Síndrome de malabsorción · parte 2 · min 02:49

Clase Síndrome de malabsorción · parte 2 · min 05:44

Clase Síndrome de malabsorción · parte 2 · min 06:27

Clase Síndrome de malabsorción · parte 2 · min 07:13

FUENTE Clase Síndrome de malabsorción · parte 1 · min 28:19

Clase Síndrome de malabsorción · parte 1 · min 32:21

Clase Síndrome de malabsorción · parte 2 · min 00:00

Van de Kamer, Sudán, D-xilosa y celíaca

IMPRESCINDIBLE

> Primero confirmar la esteatorrea; después ubicar la fase.

COMO EL PADRE NUESTRO

«Test de **Van de Kamer**, pregunta de parcial... también tienen que saberlo como el Padre Nuestro.» **Cuantitativo**: heces de **72 horas** con una dieta de **100 g de grasa por día**; **más de 6 g/día** de grasa en heces = esteatorrea. **Cualitativo**: tinción con **Sudán** al microscopio.

FUENTE Clase Síndrome de malabsorción · parte 1 · min 29:40

Clase Síndrome de malabsorción · parte 1 · min 31:41

Clase Síndrome de malabsorción · parte 1 · min 32:21

Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 379

CUANTITATIVO

Van de Kamer

72 h · 100 g de grasa/día · > 6 g/día en heces = positivo.

CUALITATIVO

Sudán

Gotas de grasa teñidas al microscopio.

CELÍACA

Serología + biopsia

Anticuerpos **antitransglutaminasa** y **antiendomisio**; la **biopsia** de duodeno/yeyuno define el grado.

FUENTE Clase Síndrome de malabsorción · parte 1 · min 29:40

Clase Síndrome de malabsorción · parte 2 · min 08:39

Clase Síndrome de malabsorción · parte 2 · min 10:46

Clase Síndrome de malabsorción · parte 2 · min 15:07

Síndrome de intestino irritable y criterios de Roma

IMPRESCINDIBLE

> Trastorno funcional (motor), crónico, diagnóstico por exclusión.

PREGUNTA DE PARCIAL

«Se utilizan los **criterios de Roma** para definirlo, y esto es **pregunta de parcial**: lo que está en el cuadrito sí o sí lo tienen que estudiar.»

FUENTE Clase Síndrome de intestino irritable · min 01:23

◎ Roma para intestino irritable

Mejora con la defecación	No 0	Sí 1
Cambio en la frecuencia de las deposiciones	No 0	Sí 1
Cambio en la forma (consistencia)	No 0	Sí 1

0 **No cumple**
Hacen falta **dos** de los tres.

No cumple: 0–1 | Cumple Roma: 2–3

El dolor/malestar tiene que estar presente; los tres ítems son los asociados (se necesitan 2).

HÁBITO

70–80 % constipación

20–30 % diarrea; pueden alternar. Moco, evacuación incompleta, distensión.

MECANISMO

Eje cerebro–intestino

Estrés y ansiedad (casi 90 % con trastorno psicológico) alteran la motilidad: no hay causa orgánica.

TRATAMIENTO

Relajación, dieta, ejercicio

Evitar lactosa, grasas y alcohol (gluten si se sospecha celíaca). Fármacos solo si hace falta.

¿FUNCIONAL O HAY ALGO ORGÁNICO?

Intestino irritable

- Dolor crónico + trastorno evacuatorio
- Empieza en la adolescencia
- Estudios normales (99 %)

Signos de alarma → orgánico

- **Pérdida de peso**, fiebre
- Sangre (oculta o visible), grasa en heces
- **Mayor de 50** (o > 40 con antecedentes) → **colonoscopía**: adenocarcinoma de colon

FUENTE Clase Síndrome de intestino irritable · min 00:42 · Clase Síndrome de intestino irritable · min 02:04 · Clase Síndrome de intestino irritable · min 02:44 · Clase Síndrome de intestino irritable · min 04:44 · Clase Síndrome de intestino irritable · min 08:05 · Clase Síndrome de intestino irritable · min 12:49 · Clase Síndrome de intestino irritable · min 13:29 · Clase Síndrome de intestino irritable · min 15:29 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 382

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Tríada de la malabsorción

Para qué sirve: Reconocerla en un caso.

- Esteatorrea
- Distensión
- Flatulencia
- ± pérdida de peso

Cómo interpretarlo: Con diarrea crónica: malabsorción hasta que se demuestre lo contrario.

Mnemotecnia: Grasa, Globo, Gases (+ Gramos de menos). — Esteatorrea, distensión, flatulencia y pérdida de peso.

Van de Kamer

Para qué sirve: «Como el Padre Nuestro».

- 72 h
- 100 g de grasa/día
- > 6 g/día = positivo

Cómo interpretarlo: Es cuantitativo; Sudán es cualitativo.

Mnemotecnia: 3 días · 100 g · más de 6. — Tres números para recordar el test.

D-xilosa

Para qué sirve: Ubicar la fase.

- > 5 g: páncreas (intraluminal)
- < 5 g: mucosa

Cómo interpretarlo: La xilosa no necesita enzimas: si no se absorbe, el problema es la mucosa.

Mnemotecnia: Poca xilosa = Pared (mucosa) enferma. — Menos de 5 g en orina indica que la mucosa no absorbe.

Roma del intestino irritable

Para qué sirve: Pregunta de parcial.

- Dolor ≥ 3 días/mes, últimos 3 meses
- 2 de 3: mejora al defecar, cambia frecuencia, cambia forma

Cómo interpretarlo: Siempre después de descartar lo orgánico.

Mnemotecnia: 3-3 y 2 de 3. — 3 días por mes, 3 meses, 2 de 3 criterios.

Integración: lo imprescindible

- Malabsorción: **diarrea crónica** (cardinal) con **esteatorrea**; tríada esteatorrea + distensión + flatulencia.
- Fases: **intraluminal** (páncreas, sales biliares), **mucosa** (celíaca), absortiva (linfa).
- **Van de Kamer**: 72 h, 100 g de grasa/día, **> 6 g/día** = positivo. Sudán: cualitativo.
- **D-xilosa**: > 5 g en orina = páncreas; < 5 g = mucosa.
- Déficits: Fe/B12/fólico → anemias; Ca/vit. D → tetania; vit. K → sangrado; vit. A → ojos; proteínas → edema.
- **SII**: funcional, por exclusión; **Roma**: dolor ≥ 3 días/mes en 3 meses + 2 de 3. Alarma → colonoscopía.

Desarrollos modelo

1. ¿Qué es el síndrome de malabsorción? Fases y manifestaciones clínicas.

Alteración de la **digestión y/o absorción** de macro y micronutrientes. **Fases:** intraluminal (páncreas, sales biliares), mucosa (yeyuno-íleon: celíaca) y absortiva (linfática).

Cardinal: diarrea crónica, la más frecuente **esteatorrea** (pastosa, grasosa, espumosa, flota). Tríada: esteatorrea + distensión + flatulencia (± pérdida de peso). Déficits: anemia (Fe, B12, fólico), tetania (Ca, vit. D), hemorragias (vit. K), ceguera nocturna (vit. A), edema (proteínas).

2. Prueba de Van de Kamer y detección de grasas en heces con Sudán.

Van de Kamer (cuantitativo): recolectar heces durante **72 h** con una dieta de **100 g de grasa/día**; una excreción **> 6 g/día** es anormal (esteatorrea) y orienta con alta sensibilidad a malabsorción.

Sudán (cualitativo): tinción de la grasa fecal al microscopio. Para ubicar la fase: **D-xilosa** (> 5 g en orina de 5 h = páncreas; < 5 g = mucosa).

3. Defina síndrome de intestino irritable y sus criterios de Roma.

Trastorno **funcional** (motor) del intestino, crónico, **diagnóstico por exclusión**. **Roma:** dolor o malestar abdominal recurrente **≥ 3 días por mes en los últimos 3 meses**, con **2 de 3**: mejora con la defecación, cambio en la frecuencia, cambio en la forma de las heces.

70–80 % constipación, 20–30 % diarrea; moco, distensión. **Alarma** (pérdida de peso, fiebre, sangre, > 50 años) → descartar orgánico (colonoscopía).

Preguntas de repaso (choice)

1. La manifestación **cardinal** del síndrome de malabsorción es:
    A. Diarrea crónica.
    B. Dolor epigástrico.
    C. Constipación.
    D. Vómitos.

2. Heces voluminosas, pastosas, grasosas, espumosas, que **flotan**:
    A. Esteatorrea.
    B. Acolia.
    C. Melena.
    D. Disentería.

3. La enfermedad celíaca altera la fase:
    A. Mucosa.
    B. Intraluminal.
    C. Absortiva (linfática).
    D. Gástrica.

4. Una pancreatitis crónica produce malabsorción en la fase:
    A. Mucosa.
    B. Absortiva.
    C. Ninguna.
    D. Intraluminal.

5. En el test de **Van de Kamer**, es positivo si con una dieta de 100 g de grasa por día se eliminan:
    A. Cualquier cantidad.
    B. Más de 1 g por día.
    C. Más de 50 g por día.
    D. Más de 6 g de grasa por día.

6. Test de D-xilosa con **menos de 5 g** en la orina de 5 horas. El problema está en:
    A. La mucosa del intestino delgado.
    B. El estómago.
    C. La vía biliar.
    D. El páncreas.

7. Un paciente con malabsorción y **tetania** (Trousseau positivo) tiene déficit de:
    A. Hierro.
    B. Vitamina A.
    C. Calcio y vitamina D.
    D. Vitamina K.

8. La malabsorción de **vitamina K** produce:
    A. Ceguera nocturna.
    B. Fenómenos hemorrágicos.
    C. Raquitismo.
    D. Escorbuto.

9. El síndrome de intestino irritable es:
    A. Una enfermedad inflamatoria orgánica.
    B. Un trastorno funcional, diagnóstico por exclusión.
    C. Una infección crónica.
    D. Una forma de celíaca.

10. Según Roma, el dolor del intestino irritable debe asociarse a **dos** de:
    A. Esteatorrea, distensión y flatulencia.
    B. Vómitos, pirosis y disfagia.
    C. Fiebre, pérdida de peso y sangre.
    D. Mejora con la defecación, cambio de frecuencia, cambio de forma de las heces.

11. Paciente de 58 años con dolor abdominal crónico, constipación nueva y **pérdida de peso**. La conducta es:
    A. Test de D-xilosa.
    B. Colonoscopía para descartar cáncer de colon.
    C. Diagnosticar intestino irritable y tratar el estrés.
    D. Solo dieta.

Respuestas

1. **A** — Correcto: «si no me dicen diarrea crónica, los van a bochar».
2. **A** — Correcto.
3. **A** — Correcto: destruye las vellosidades del delgado.
4. **D** — Correcto: falta el jugo pancreático para la digestión.
5. **D** — Correcto.
6. **A** — Correcto: la mucosa no la absorbe.
7. **C** — Correcto.
8. **B** — Correcto.
9. **B** — Correcto.
10. **D** — Correcto.
11. **B** — Correcto.

CAPÍTULO 10

Peritonitis

Plastrón y peritonitis generalizada; primaria (PBE), secundaria y terciaria; cómo se reconoce y se confirma.

NECESITÁS SABER

- Abdomen agudo (dig-02)
- Ascitis (dig-05)

Peritonitis

«La peritonitis es **muy preguntada**: en el parcial, en los orales y en el final.» Lo que pide **sí o sí**: el **plastrón** y las **tres** peritonitis (primaria, secundaria, terciaria).

Extensión
Plastrón (localizada) ★ · Generalizada · Blumberg vs Gueneau

Las tres ★
Primaria: PBE · Secundaria: perforación · Terciaria: iatrogénica

PBE
Cirrosis + ascitis · Traslocación · > 250 PMN

Clínica y estudios
Globoso vs tabla · Jobert · Popper · Paracentesis

AL TERMINAR VAS A PODER

- Definir peritonitis y plastrón.
- Hacer el cuadro de peritonitis primaria, secundaria y terciaria.
- Explicar la traslocación bacteriana y el criterio de 250 neutrófilos.
- Diferenciar en el examen una PBE de una perforación.

Qué es, plastrón y peritonitis generalizada

IMPRESCINDIBLE

> Inflamación de la serosa peritoneal, casi siempre por infección. Localizada = plastrón.

PLASTRÓN: PREGUNTA DE PARCIAL

El **plastrón** es una **peritonitis localizada en contacto con la pared anterior del abdomen**. «Es pregunta de parcial, siempre suelen poner algún caso clínico donde habla sobre el plastrón.»

FUENTE Clase Peritonitis · parte 1 · min 00:44 · Clase Peritonitis · parte 1 · min 02:13

- **Peritonitis**
  - **Por localización**
    - **Generalizada**
    - **Localizada = plastrón** ★
  - **Por etiología**
    - **Aséptica**
      Sin gérmenes: irritación química (bilis, jugo pancreático, sangre)
    - **Séptica** ★
      Primaria · secundaria · terciaria

FUENTE Clase Peritonitis · parte 1 · min 00:02 · Clase Peritonitis · parte 1 · min 02:58 · Clase Peritonitis · parte 1 · min 03:45 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 383

Primaria, secundaria y terciaria

IMPRESCINDIBLE

> «El plastrón y estos tres, sí o sí me tienen que saber.»

ÉNFASIS DEL PROFESOR

«Lo que le van a preguntar a ustedes es **plastrón** y obviamente **estos tres**: sí o sí me tienen que saber la primaria, secundaria y terciaria.»

FUENTE Clase Peritonitis · parte 1 · min 06:05

El cuadro (tapalo y reconstruilo)

	Primaria (PBE)	Secundaria	Terciaria
CAUSA	**Sin perforación**: traslocación bacteriana	Perforación de víscera hueca o infección de un órgano (apendicitis, colecistitis)	**Iatrogénica**: cirugía, trauma abierto
PACIENTE	**Cirrótico** con ascitis (80–90 %); síndrome nefrótico	Abdomen agudo perforativo	Posquirúrgico
GÉRMENES	**Monomicrobiana** (E. coli)	Polimicrobiana	Desde el exterior
FRECUENCIA	—	La más frecuente	—
TRATAMIENTO	**Médico**: cefalosporinas 3.ª–4.ª	Quirúrgico	Quirúrgico

FUENTE Clase Peritonitis · parte 1 · min 04:38 · Clase Peritonitis · parte 1 · min 06:49 · Clase Peritonitis · parte 1 · min 12:48 · Clase Peritonitis · parte 1 · min 15:43 · Clase Peritonitis · parte 1 · min 16:23 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 383

FUENTE Clase Peritonitis · parte 1 · min 06:05 · Clase Peritonitis · parte 1 · min 15:43 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 383

Cómo se ve: PBE vs perforación

IMPRESCINDIBLE

> Secundaria = abdomen agudo perforativo. PBE = ascitis infectada, dolor menor.

Al examen

	PBE (primaria)	Secundaria (perforación)
DOLOR	Menos intenso; puede no haber dolor brusco	Brusco, intenso, no calma

INSPECCIÓN	Abdomen **globoso** (ascitis)	Abdomen **en tabla**, no se mueve con la respiración
AUSCULTACIÓN	RHA arriba de la ascitis; ausentes abajo	RHA **ausentes** (íleo paralítico)
PERCUSIÓN	**Matidez** (líquido)	Timpanismo; **Jobert**
PALPACIÓN	Dolor a la compresión y descompresión	Defensa, **contractura**; Blumberg (plastrón) o Gueneau de Mussy
ACOMPAÑA	Fiebre variable; vómitos raros	Fiebre (80 %), náuseas y vómitos, deshidratación

FUENTE Clase Peritonitis · parte 1 · min 17:52 · Clase Peritonitis · parte 1 · min 19:23 · Clase Peritonitis · parte 1 · min 20:06 · Clase Peritonitis · parte 1 · min 21:32 · Clase Peritonitis · parte 1 · min 22:15 · Clase Peritonitis · parte 1 · min 22:56

FACIES

Pálida, dolorosa, con **ojos hundidos** (deshidratación), taquicárdico e hipotenso. El paciente flexiona las piernas para no estirar el peritoneo.

FUENTE Clase Peritonitis · parte 1 · min 20:48 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 383

FUENTE Clase Peritonitis · parte 1 · min 17:09 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 383

Laboratorio, imágenes y paracentesis

IMPRESCINDIBLE

> Más de 250 neutrófilos por mm³ en el líquido ascítico = diagnóstico de certeza de PBE.

COMO EL PADRE NUESTRO

«Tienen que sabérsela como si fuese el Padre Nuestro a lo que es la paracentesis.» La **paracentesis** es **diagnóstica y terapéutica**. **Más de 250 neutrófilos por mm³** en el líquido ascítico (neutroascitis) = **diagnóstico de certeza de PBE**: «se lo pueden preguntar en el oral o en el choice».

FUENTE Clase Peritonitis · parte 2 · min 03:42 · Clase Peritonitis · parte 2 · min 04:25 · Clase Peritonitis · parte 2 · min 05:09

Qué pedir

LABORATORIO

Infección

Leucocitosis > 15.000 con desviación a la izquierda, ↑ PCR y VSG; acidosis metabólica; función renal; amilasa.

RX TÓRAX Y ABDOMEN

Neumoperitoneo

Popper (aire subdiafragmático) si hay perforación.

ECOGRAFÍA

La más usada

Líquido libre y el órgano que se perforó (apéndice, vesícula, estómago).

PARACENTESIS

> 250 PMN/mm³

Certeza de PBE.

PARA SABER QUE EXISTE

Los **criterios de Alvarado** (apendicitis) suman 10 puntos: hasta 4 se va a la casa, 5–6 observación, 7 o más cirugía. El profe aclara que no hace falta saber el nombre.

FUENTE Clase Peritonitis · parte 2 · min 05:09 · Clase Peritonitis · parte 2 · min 05:51

FUENTE Clase Peritonitis · parte 2 · min 00:00 · Clase Peritonitis · parte 2 · min 00:42 · Clase Peritonitis · parte 2 · min 02:08 · Clase Peritonitis · parte 2 · min 02:55

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Las tres peritonitis

Para qué sirve: Sí o sí.

- Primaria: PBE, cirrosis, mono, médica
- Secundaria: perforación, poli, quirúrgica, la más frecuente
- Terciaria: iatrogénica

Cómo interpretarlo: Cuántos gérmenes y si se opera.

Mnemotecnia: 1-2-3: «Uno solo (mono), Dos o más (poli), Tres = el cirujano». — Primaria monomicrobiana; secundaria polimicrobiana; terciaria iatrogénica.

PBE: el número

Para qué sirve: Oral y choice.

- Paracentesis
- > 250 neutrófilos/mm^3

Cómo interpretarlo: Certeza de PBE.

Mnemotecnia: «250 soldados en el líquido = infección». — Más de 250 PMN por mm^3.

Plastrón

Para qué sirve: Caso clínico de parcial.

- Peritonitis localizada
- En contacto con la pared anterior
- Blumberg

Cómo interpretarlo: El proceso queda encapsulado.

Mnemotecnia: PLASTRÓN = parche pegado a la pared. — Localizado, contra la pared anterior.

Integración: lo imprescindible

- **Peritonitis**: inflamación de la serosa peritoneal; **plastrón** = localizada contra la pared anterior.

- **Primaria (PBE)**: cirrosis con ascitis, traslocación, monomicrobiana (E. coli), tratamiento médico.
- **Secundaria**: perforación de víscera hueca, la más frecuente, polimicrobiana, quirúrgica. **Terciaria**: iatrogénica.
- Examen: PBE = abdomen globoso con matidez; perforación = tabla, Jobert, RHA ausentes.
- **Paracentesis**: > 250 neutrófilos/mm³ = certeza de PBE.

Desarrollos modelo

1. ¿Qué es la peritonitis? Cuadro de diferenciación de peritonitis primaria, secundaria y terciaria.

Inflamación de la serosa peritoneal, casi siempre infecciosa. Puede ser **generalizada** o **localizada (plastrón**: en contacto con la pared anterior del abdomen).

	PRIMARIA (PBE)	SECUNDARIA	TERCIARIA
Causa	Traslocación bacteriana, sin perforación	Perforación de víscera hueca	Iatrogénica / trauma
Contexto	Cirrosis con ascitis, nefrótico	La más frecuente	Posquirúrgica
Gérmenes	Monomicrobiana (E. coli)	Polimicrobiana	Exterior
Tratamiento	Médico (cefalosporinas)	Quirúrgico	Quirúrgico

2. ¿Cómo se diagnostica la peritonitis bacteriana espontánea?

Paciente cirrótico con ascitis, fiebre y dolor abdominal: **paracentesis** (diagnóstica y terapéutica). **Más de 250 neutrófilos por mm³** en el líquido ascítico = diagnóstico de certeza. Se trata con cefalosporinas de 3.ª–4.ª generación, sin cirugía.

3. ¿Qué es el signo de Blumberg y el de Gueneau de Mussy?

Ambos son **dolor a la descompresión** (irritación del peritoneo parietal): **Blumberg** = localizado (plastrón, FID en la apendicitis); **Gueneau de Mussy** = generalizado (peritonitis difusa). No confundir contractura (involuntaria, tabla) con defensa (voluntaria).

Preguntas de repaso (choice)

1. El **plastrón** es:
    A. Una peritonitis localizada en contacto con la pared anterior del abdomen.
    B. Una peritonitis generalizada.
    C. La ascitis infectada.
    D. Un tipo de hernia.

2. La peritonitis **más frecuente** es:
    A. Primaria.
    B. Secundaria (perforación de víscera hueca).
    C. Aséptica.
    D. Terciaria.

3. La peritonitis bacteriana espontánea se produce por:
    A. Una pancreatitis.
    B. Perforación de una víscera hueca.
    C. Traslocación bacteriana desde el intestino hacia la ascitis.
    D. Contaminación quirúrgica.

4. La PBE es típicamente:
    A. Polimicrobiana y quirúrgica.
    B. Viral.
    C. Aséptica.
    D. Monomicrobiana (E. coli) y de tratamiento médico.

5. El diagnóstico de certeza de PBE es un líquido ascítico con:
    A. GASA > 1,1.
    B. > 25 leucocitos por mm^3.
    C. Proteínas > 3 g/dl.
    D. > 250 neutrófilos por mm^3.

6. La causa más frecuente de PBE es:
    A. Cirrosis con ascitis.
    B. Úlcera perforada.
    C. Cirugía abdominal.
    D. Apendicitis.

7. Abdomen en tabla, timpanismo en el área hepática y RHA ausentes. ¿Qué peritonitis?
    A. Plastrón.
    B. Aséptica.
    C. Secundaria por perforación.
    D. PBE.

8. Dolor a la descompresión **generalizado**:
    A. Murphy.
    B. Blumberg.
    C. Gueneau de Mussy.
    D. Jobert.

9. El tratamiento de la peritonitis **secundaria** es:
    A. Quirúrgico.
    B. Paracentesis evacuadora.
    C. Solo antibióticos.
    D. Dieta.

Respuestas

1. **A** — Correcto.
2. **B** — Correcto.
3. **C** — Correcto.
4. **D** — Correcto.
5. **D** — Correcto.
6. **A** — Correcto (80–90 %).
7. **C** — Correcto: Jobert + tabla + íleo paralítico.
8. **C** — Correcto.
9. **A** — Correcto.

CAPÍTULO 11

Síndromes vesiculares

El viaje del cálculo: litiasis, cólico biliar, colecistitis, Mirizzi, coledocolitiasis, colangitis y pancreatitis biliar.

NECESITÁS SABER

- Ictericia (dig-04)
- Anatomía de la vía biliar

Síndromes vesiculares

El profe lo dice claro: «no es pregunta de parcial, es pregunta de **final**, y lo preguntan sus JTP». Pero hay cuatro cosas que sí: por qué la litiasis **no da ictericia**, el **síndrome coledociano** («como el Padre Nuestro»), la **maniobra de Murphy** y **Courvoisier**.

El cálculo
Colelitiasis vs colecistitis · 4 F · De la vesícula a la ampolla

Cólico y colecistitis
Cólico: transitorio · Colecistitis: impactado · Murphy ★

¿Ictericia?
Litiasis: NO ★ · Coledociano ★ · Sin dolor = cáncer

Vía biliar
Coledocolitiasis · Charcot · Pancreatitis biliar

AL TERMINAR VAS A PODER

- Diferenciar colelitiasis, cólico biliar y colecistitis aguda.
- Explicar por qué la litiasis vesicular no da ictericia y cuándo sí.
- Recitar el síndrome coledociano y la tríada de Charcot.
- Saber hacer e interpretar la maniobra de Murphy.

Colelitiasis vs colecistitis y el viaje del cálculo

MUY IMPORTANTE

> «Muchos se confunden»: litiasis = cálculos; colecistitis = inflamación por un cálculo impactado en el cístico.

QUÉ SE TOMA

Síndromes vesiculares «no es pregunta de parcial, es pregunta de **final** y lo preguntan sus JTP». «Lo que sí quiero que sepan para el parcial es **ictericia**.»

FUENTE Clase Síndromes vesiculares · min 00:02

Colelitiasis

- **Cálculos** en la vesícula
- Puede ser asintomática
- Dolor cólico leve, que pasa rápido

Colecistitis aguda

- **Inflamación** de la vesícula
- Por un cálculo **impactado en el cístico** (casi siempre)
- Dolor intenso, fiebre: suele terminar en cirugía

F **F** **F** **F**

Tocá para desplegar

«Las 4 F me las tienen que saber.» Otros factores: dieta rica en colesterol y grasas, hipertrigliceridemia, fármacos, embarazo, genética. Cálculos: 80 % de colesterol.

FUENTE Clase Síndromes vesiculares · min 06:46 Clase Síndromes vesiculares · min 07:32

FUENTE Clase Síndromes vesiculares · min 00:44 Clase Síndromes vesiculares · min 01:34 Clase Síndromes vesiculares · min 03:51 Clase Síndromes vesiculares · min 05:19 Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 385

Cólico biliar, colecistitis aguda y Murphy

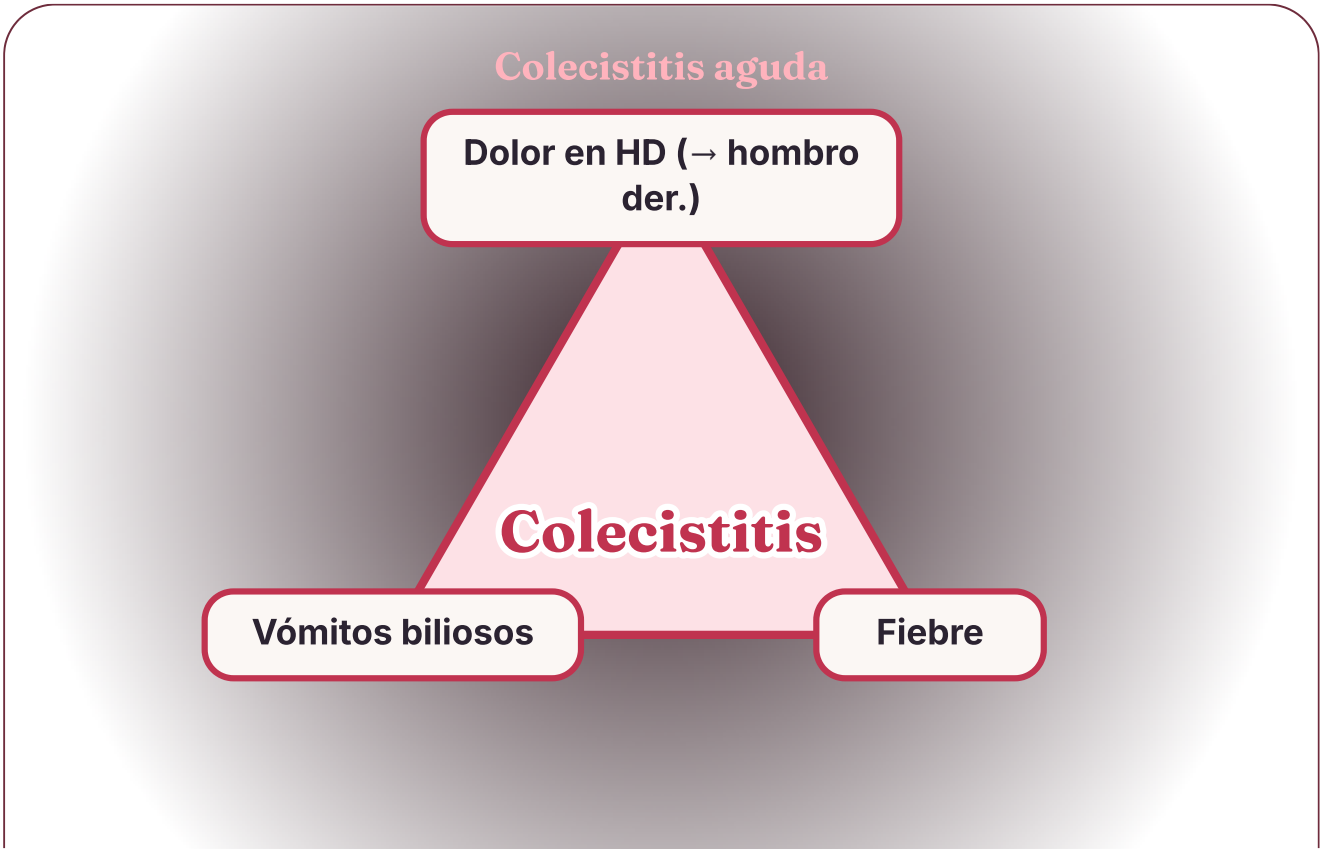
IMPRESCINDIBLE

> El cólico pasa; la colecistitis se queda, con fiebre y Murphy positivo.

Cólico biliar vs colecistitis aguda

	Cólico biliar	Colecistitis aguda
QUÉ PASA	El cálculo se traba un rato en el cístico y sale	El cálculo queda impactado → vesícula inflamada
DOLOR	HD y epigastrio → dorso y hombro derecho, tras grasas; calma con antiespasmódicos	Igual pero más intenso y persistente
FIEBRE	No	Sí
MURPHY	Negativo	Positivo
LABORATORIO	Normal	Leucocitosis con desviación a la izquierda, ↑ FA
ICTERICIA	No	Rara: solo si complica (Mirizzi, repercusión hepática)

FUENTE Clase Síndromes vesiculares · min 08:14 · Clase Síndromes vesiculares · min 08:57 · Clase Síndromes vesiculares · min 16:12 · Clase Síndromes vesiculares · min 16:52 · Clase Síndromes vesiculares · min 19:04

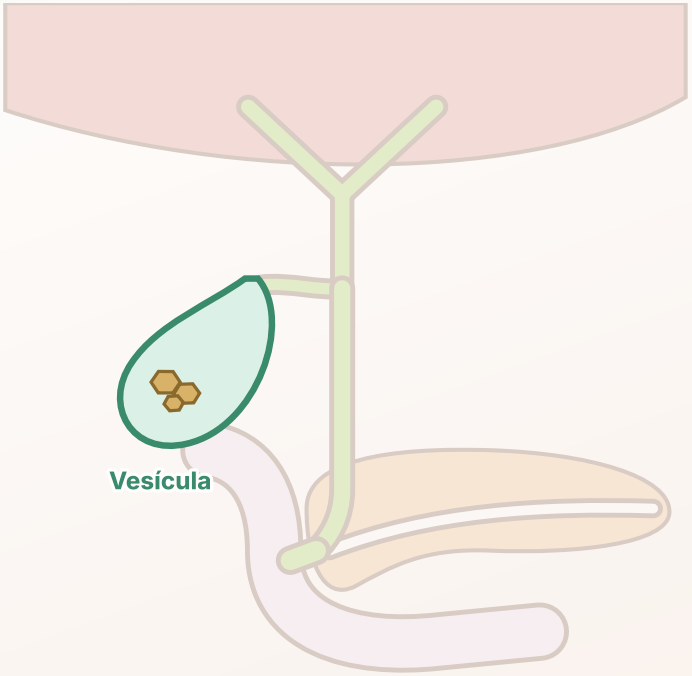


Con **signo de Murphy positivo**: presión en el punto cístico + inspiración profunda → el dolor corta la inspiración. «La maniobra de Murphy la tienen que saber.»

FUENTE Clase Síndromes vesiculares · min 18:24 Clase Síndromes vesiculares · min 19:04

Mirá dónde está el cálculo

Litiasis asintomática | Cólico biliar | Colecistitis aguda



Litiasis asintomática

Cálculos que no se impactan: no duelen.

FUENTE Clase Síndromes vesiculares · min 16:52 Clase Síndromes vesiculares · min 18:24 Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 385

¿Por qué la litiasis vesicular no da ictericia?

IMPRESCINDIBLE

> La vesícula almacena bilis, no la produce: con el cálculo ahí, la bilis sigue bajando por el colédoco.

PREGUNTA DE EXAMEN

«Cuando hay cálculos en la vesícula biliar **no hay ictericia**. Hay ictericia cuando hay **obstrucción del colédoco**... eso es pregunta de examen.»

FUENTE Clase Síndromes vesiculares · min 09:41 | Clase Síndromes vesiculares · min 10:26

Paciente con litiasis: ¿tiene ictericia?

No: cálculo en la vesícula o en el cístico
La bilis baja igual por hepático y colédoco

Sí: algo obstruye la vía principal ★

- **Coledocolitiasis**
  Cálculo en el colédoco
- **Mirizzi**
  Comprime el hepático común
- **Colecistitis con repercusión hepática**

ICTERICIA CON O SIN DOLOR

Ictericia CON dolor

- Patología **calculosa** de la vía biliar
- Coledocolitiasis, Mirizzi

Ictericia SIN dolor

- Pensar en **cáncer de cabeza de páncreas**
- Vesícula palpable indolora: **Bard y Pick**, **ley de Courvoisier-Terrier** (pregunta de parcial)

FUENTE Clase Síndromes vesiculares · min 11:08 | Clase Síndromes vesiculares · min 11:53 | Clase Síndromes vesiculares · min 12:36 | Clase Síndromes vesiculares · min 14:00 | Clase Síndromes vesiculares · min 14:41 | Clase Síndromes vesiculares · min 15:29

Coledocolitiasis, síndrome coledociano y colangitis

IMPRESCINDIBLE

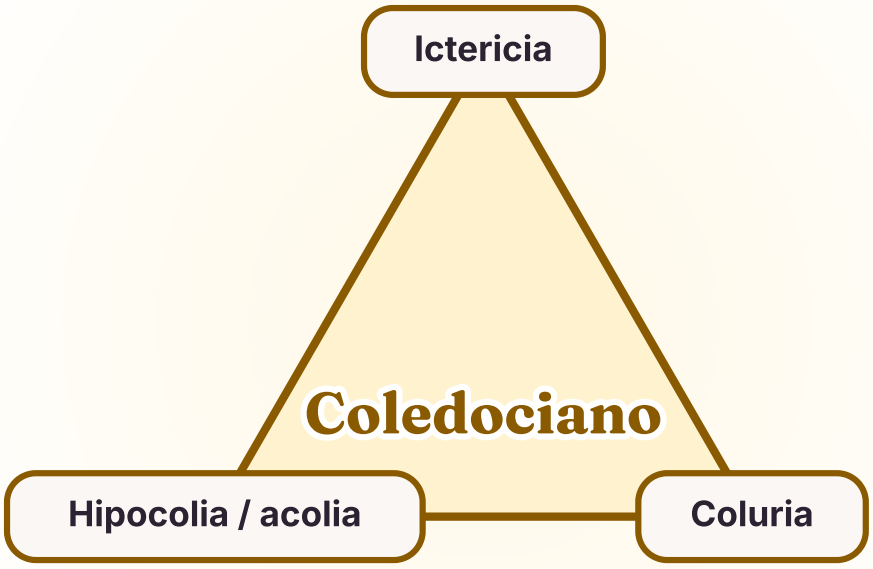
> Síndrome coledociano = ictericia + coluria + hipocolia/acolia. Colangitis = Charcot.

COMO EL PADRE NUESTRO

«¿Qué es síndrome coledociano? **Pregunta de parcial**. Esto sí, sí o sí, **como si fuese el Padre Nuestro**, me lo saben.»

FUENTE Clase Síndromes vesiculares · min 24:18 · Clase Síndromes vesiculares · min 25:03

Síndrome coledociano

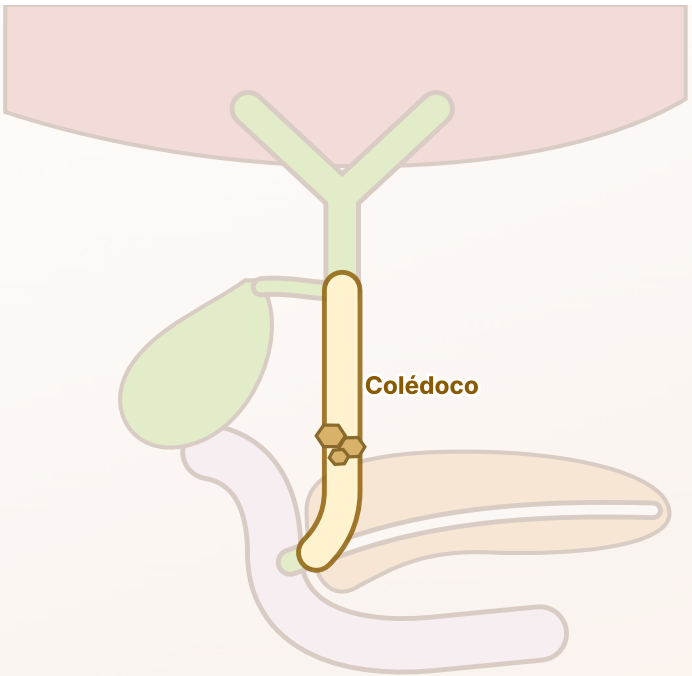


No es una enfermedad del colédoco: es la tríada de **cualquier obstrucción** de la vía biliar principal (cálculo, parásitos, disfunción del Oddi, cáncer de páncreas o de vesícula, adenopatías).

FUENTE Clase Síndromes vesiculares · min 17:35 · Clase Síndromes vesiculares · min 24:18

Causas de obstrucción

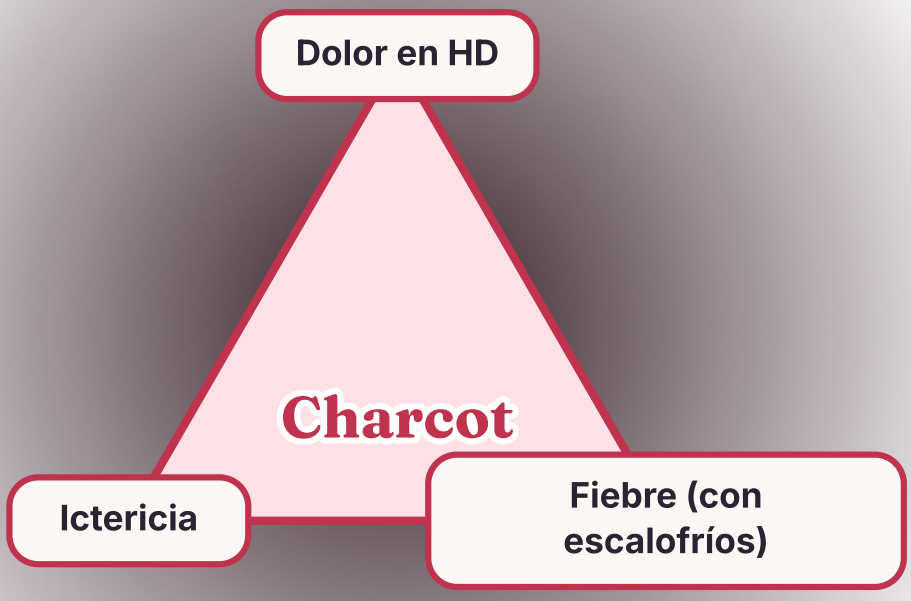
Coledocolitiasis · Cáncer de cabeza de páncreas · Cáncer de la ampolla de Vater



Coledocolitiasis

La **complicación más frecuente** de la litiasis vesicular (≈ 15 %). Colédoco > 10 mm en la ecografía.

Colangitis: tríada de Charcot



Infección de la bilis estancada por bacterias que ascienden desde el duodeno, con aumento de la presión en el colédoco: **emergencia médica**. La péntada de Reynolds (colangitis grave) es de la bibliografía, no la dio en clase.

FUENTE Clase Síndromes vesiculares · min 26:30 Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 387

FUENTE Clase Síndromes vesiculares · min 23:33 Clase Síndromes vesiculares · min 25:45 Clase Síndromes vesiculares · min 26:30 Clase Síndromes vesiculares · min 27:12 Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 387

Ecografía y laboratorio

MUY IMPORTANTE

> La ecografía es el método de elección (certeza ~95 %).

ECOGRAFÍA

Cálculo = sombra acústica

Imagen con **sombra acústica** posterior. Si no hay sombra: **pólipo** o **adenocarcinoma**.

ECOGRAFÍA

Colédoco dilatado

Normal < 7–8 mm; **> 10 mm** sugiere un cálculo impactado en el colédoco.

LABORATORIO

Colestasis + inflamación

Leucocitosis con desviación a la izquierda; **FA, GGT, 5′-nucleotidasa**; enzimas hepáticas y **amilasa** (descartar pancreatitis).

NOTA

La **colangiorresonancia** es el segundo estudio, cuando se sospecha el cálculo en la vía biliar.

FUENTE Clase Síndromes vesiculares · min 21:17

FUENTE Clase Síndromes vesiculares · min 19:46 Clase Síndromes vesiculares · min 20:37 Clase Síndromes vesiculares · min 21:17 Clase Síndromes vesiculares · min 22:00

Otras patologías de la vesícula

COMPLEMENTARIO

SIN CÁLCULOS

Colecistitis alitiásica

Rara, en el paciente crítico; elevada mortalidad.

CRÓNICA

Vesícula en porcelana

Episodios repetidos → vesícula fibrosa y calcificada: **riesgo de cáncer** → colecistectomía.

ECOGRAFÍA SIN SOMBRA

Pólipos

Premalignos: se saca la vesícula.

CÁNCER

Adenocarcinoma de vesícula

Más frecuente en el **fondo**; diagnóstico por ecografía.

FUENTE Clase Síndromes vesiculares · min 22:48 · Clase Síndromes vesiculares · min 27:12 · Clase Síndromes vesiculares · min 27:56 · Clase Síndromes vesiculares · min 28:37

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Síndrome coledociano

Para qué sirve: «Como el Padre Nuestro».

- Ictericia
- Coluria
- Hipocolia / acolia
- ± prurito, fiebre

Cómo interpretarlo: Es la firma de toda obstrucción de la vía biliar principal.

Mnemotecnia: Amarillo afuera, oscuro en la orina, blanco en el inodoro. — Ictericia, coluria, acolia.

Dónde está el cálculo

Para qué sirve: Ordenar los síndromes.

- Vesícula: colelitiasis
- Cístico (rato): cólico
- Cístico (impactado): colecistitis
- Colédoco: coledocolitiasis
- Ampolla: pancreatitis

Cómo interpretarlo: A medida que baja, aparecen ictericia y complicaciones.

Mnemotecnia: Vesícula → Cístico → Colédoco → Ampolla = Litiasis → Colecistitis → Ictericia → Páncreas. — El viaje del cálculo.

Charcot

Para qué sirve: No confundir tríadas.

- Dolor HD
- Fiebre
- Ictericia
- = colangitis

Cómo interpretarlo: Coledociano + fiebre = infección de la bilis.

Mnemotecnia: CHARCOT = Colangitis: Calor (fiebre), Color (ictericia), Cólico (dolor). — Tres C.

Integración: lo imprescindible

- **Colelitiasis** (cálculos) ≠ **colecistitis** (inflamación por cálculo impactado en el cístico).
- Cólico biliar: transitorio, sin fiebre. Colecistitis: dolor persistente, fiebre, vómitos, **Murphy +**.
- La litiasis vesicular **no da ictericia**; la da la obstrucción de la vía principal (coledocolitiasis, Mirizzi).
- **Síndrome coledociano**: ictericia + coluria + hipocolia/acolia.
- **Colangitis** = tríada de **Charcot**: dolor + fiebre + ictericia. Cálculo en la ampolla → **pancreatitis**.
- Ecografía: cálculo con **sombra acústica**; colédoco > 10 mm.

Desarrollos modelo

1. ¿Qué es el síndrome coledociano? ¿Qué es la coledocolitiasis?

Síndrome coledociano: tríada **ictericia + coluria + hipocolia/acolia** (± prurito y fiebre), por obstrucción de la vía biliar principal: cálculos, parásitos, disfunción del Oddi, cáncer de páncreas o de vesícula, adenopatías.

Coledocolitiasis: cálculo impactado en el colédoco; la **complicación más frecuente** de la litiasis vesicular. Complicaciones: **colangitis** y **pancreatitis** biliar.

2. ¿Por qué la litiasis vesicular no produce ictericia?

Porque la vesícula **almacena** bilis, no la produce: aunque tenga cálculos (o uno en el cístico), la bilis sigue bajando por el hepático común y el colédoco. Hay ictericia cuando se **obstruye la vía principal**: coledocolitiasis, Mirizzi o colecistitis con repercusión hepática. Ictericia **sin dolor**: pensar en cáncer de cabeza de páncreas.

3. ¿Qué es un cólico biliar? ¿Qué es la colecistitis aguda? ¿Signo de Murphy?

Cólico biliar: dolor en HD/epigastrio irradiado al dorso y hombro derecho, tras comidas grasas, por un cálculo que se traba transitoriamente en el cístico; sin fiebre.

Colecistitis aguda: inflamación de la vesícula por un cálculo **impactado en el cístico**: dolor persistente, fiebre, vómitos, **Murphy positivo** (± ictericia). **Murphy:** presión en el punto cístico + inspiración profunda → el dolor corta la inspiración.

4. ¿Qué es la colangitis? Tríada de Charcot.

Infección de la bilis estancada en una vía biliar obstruida (bacterias que ascienden desde el duodeno): **tríada de Charcot = dolor en HD + fiebre + ictericia**. Emergencia médica. (Bibliografía: péntada de Reynolds = Charcot + shock + alteración de la conciencia.)

5. Síndrome de Mirizzi, colecistitis crónica y litiasis asintomática.

Mirizzi: cálculo en el cístico + vesícula inflamada que comprimen el hepático común → ictericia. **Crónica:** vesícula fibrosa, en porcelana, riesgo de cáncer → colecistectomía. **Asintomática:** cálculos que no se impactan.

Preguntas de repaso (choice)

1. La colecistitis aguda litiásica se produce por:
    A. Un tumor de páncreas.
    B. Un cálculo en la ampolla de Vater.
    C. Un cálculo impactado en el conducto cístico.
    D. Un cálculo libre en la vesícula.

2. ¿Por qué la litiasis vesicular **no** da ictericia?
    A. Porque la vesícula almacena bilis y la vía principal sigue libre.
    B. Porque los cálculos son de colesterol.
    C. Sí da ictericia siempre.
    D. Porque el hígado no produce bilis.

3. El síndrome coledociano está formado por:
    A. Ascitis + esplenomegalia + várices.
    B. Dolor + fiebre + ictericia.
    C. Ictericia + coluria + hipocolia/acolia.
    D. Dolor + vómitos + fiebre.

4. La complicación **más frecuente** de la litiasis vesicular es:
    A. Cáncer de vesícula.
    B. Íleo biliar.
    C. Coledocolitiasis.
    D. Mirizzi.

5. La tríada de **Charcot** corresponde a:
    A. Colangitis.
    B. Apendicitis.
    C. Colecistitis aguda.
    D. Pancreatitis.

6. El signo de Murphy positivo indica:
    A. Úlcera perforada.
    B. Cólico renal.
    C. Colecistitis aguda.
    D. Apendicitis.

7. Dolor en HD tras una comida grasa que cede en 2 horas con un antiespasmódico, **sin fiebre**:
    A. Cólico biliar.
    B. Pancreatitis.
    C. Colangitis.
    D. Colecistitis aguda.

8. En la ecografía, una imagen en la vesícula **sin sombra acústica** sugiere:
    A. Pólipo o adenocarcinoma.
    B. Cálculo.
    C. Colangitis.
    D. Normalidad.

9. Ictericia **progresiva e indolora** con vesícula palpable no dolorosa:
    A. Cólico biliar.
    B. Cáncer de cabeza de páncreas (Courvoisier).
    C. Coledocolitiasis.
    D. Colecistitis aguda.

Respuestas

1. **C** — Correcto.
2. **A** — Correcto.
3. **C** — Correcto.
4. **C** — Correcto.
5. **A** — Correcto: dolor + fiebre + ictericia.
6. **C** — Correcto.
7. **A** — Correcto.
8. **A** — Correcto.
9. **B** — Correcto.

CAPÍTULO 12

Hemorragias digestivas

Cuánto perdió (clases I a IV), de dónde viene (alta o baja), por qué sangra y cómo se estudia.

NECESITÁS SABER

- Úlcera péptica (dig-07)
- Hematemesis vs hemoptisis (dig-01)

Hemorragias digestivas

«Hemorragia digestiva, cirrosis e hipertensión portal y pancreatitis aguda: **muy preguntados** en el parcial y en el final, en el choice y en el oral.» Lo que marca: el **cuadro de clases por signos vitales** («como el Padre Nuestro»), la **causa más frecuente** de alta y de baja, y la **prueba de ortostatismo**.

Cuánto perdió ★
Clases I a IV · Ortostatismo ★ · Anemia ferropénica

Cómo se ve
Hematemesis · Melena vs hematoquecia · Sangre oculta

De dónde
Treitz · Alta: úlcera ★ · Baja: hemorroides ★

Estudios
SNG · endoscopía · Colonoscopía · Forrest

AL TERMINAR VAS A PODER

- Clasificar una hemorragia en clase I a IV por los signos vitales.
- Hacer la prueba de ortostatismo y saber cuándo es positiva.
- Diferenciar alta de baja y nombrar la causa más frecuente de cada una.
- Saber qué estudio pedir en cada caso.

Cuánto perdió: clases I a IV

IMPRESCINDIBLE

> Primero los signos vitales: si está inestable se estabiliza, después se busca la causa.

COMO EL PADRE NUESTRO

El cuadro de clasificación por signos vitales «tienen que sabérselo como el Padre Nuestro», y sirve para **cualquier hemorragia**, no solo la digestiva.

FUENTE Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 02:05

Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 06:56

Clasificación por parámetros vitales (libro p. 389)

	I · leve	II · moderada	III · grave	IV · masiva
PÉRDIDA	< 750 ml (< 15 %)	750–1500 ml (15–30 %)	1500–2000 ml (30–40 %)	> 2000 ml (> 40 %)
FC	< 100	100–119	120–139	> 140
PA	Normal	Normal o ↓	↓ (TAS < 100)	↓↓
FR	14–20	20–30	30–39	> 40
DIURESIS (ML/H)	> 30	20–30	5–20	Imperceptible
ESTADO MENTAL	Normal	Ansioso	Ansioso y confuso	Confuso

FUENTE Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 389

Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 02:48

Qué significa cada clase

I Leve

II Moderada

III Grave

IV Masiva

Tocá un escalón para ver el detalle.

POR QUÉ CAMBIA CADA SIGNO

El corazón late más rápido para mantener el flujo (**taquicardia**), se respira más rápido para llevar oxígeno (**taquipnea**), el riñón retiene volumen (**oliguria**) y el cerebro mal perfundido se **confunde**. El hematocrito no sirve al principio: baja recién a las 8 h.

FUENTE Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 03:29

Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 04:12 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 389

SIEMPRE ANEMIA

«Todo paciente con hemorragia digestiva hace anemia», y la más frecuente es la **ferropénica**: bajan glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito. Otras manifestaciones de hipovolemia: lipotimia, disnea, angina, shock.

FUENTE Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 05:33

Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 14:22

FUENTE Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 01:23

Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 02:05 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 389

La prueba de ortostatismo

IMPRESCINDIBLE

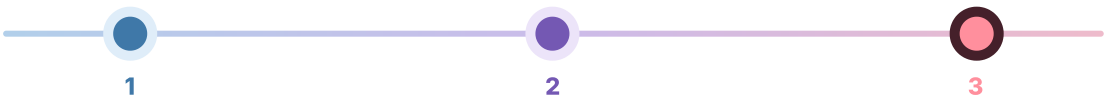
> Acostado y después de pie: si la presión cae, hay hipovolemia.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

«Esto lo preguntan en el parcial: cuál de estas características tiene que tener el paciente para decir que el **ortostatismo es positivo**.»

FUENTE Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 21:03

Paso a paso



1

Acostado 2–5 min

Medir **PA y FC** (y saturación).

2

De pie

Volver a medir a los **3 y 5 minutos**.

3

Positiva si…

PAS cae **> 20 mmHg** · PAD cae **> 10 mmHg** · FC sube **> 30** · o mareo / lipotimia.

⚠ **ERROR FRECUENTE**

Una hipotensión ortostática indica **hipovolemia** (en un paciente que sangra), pero también puede deberse a un trastorno **cardíaco**.

FUENTE Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 24:25

FUENTE Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 21:43

Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 22:23 Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 23:05

Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 25:06

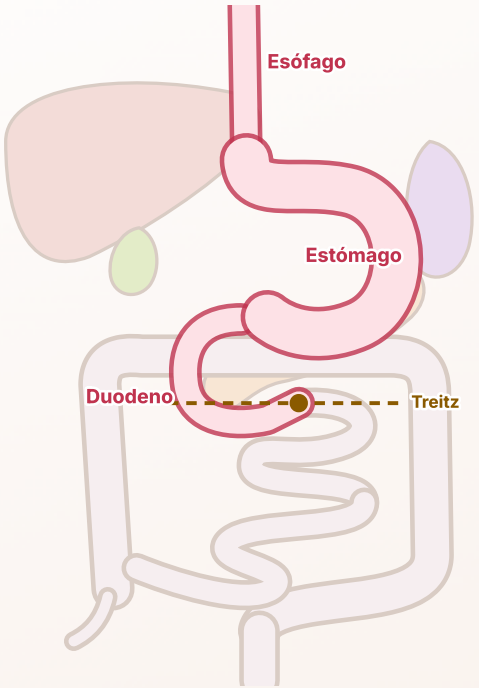
Hematemesis, melena, hematoquecia y sangre oculta

IMPRESCINDIBLE

> La forma orienta de dónde viene.

De dónde viene cada una

Hematemesis | Melena | Hematoquecia | Proctorragia



Hematemesis

Vómito de sangre (roja o borra de café): **siempre alta**. Diferencial con hemoptisis: pregunta de parcial.

ENTERORRAGIA VS PROCTORRAGIA

Enterorragia: las heces salen **bañadas** en sangre. **Proctorragia**: terminás de defecar y caen **gotitas** de sangre. Colon izquierdo: sangre más rutilante; derecho: más oscura; ciego: puede dar melena.

FUENTE Clase Hemorragias digestivas · parte 2 · min 04:27

Clase Hemorragias digestivas · parte 2 · min 08:32

FUENTE Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 06:56

Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 08:16

Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 11:39

Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 13:41

Clase Hemorragias digestivas · parte 2 · min 03:04

Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 389

Alta vs baja: causas

IMPRESCINDIBLE

> Alta: úlcera. Baja: hemorroides y fisuras.

Alta vs baja (tapalo)

	Alta	Baja
LÍMITE	Esfínter esofágico superior → Treitz	**Treitz** → ano
FRECUENCIA / GRAVEDAD	La más frecuente y la más grave	Menos frecuente, menos grave; suele estar estable
PRESENTACIÓN	Hematemesis, melena	Hematoquecia, proctorragia, sangre oculta
CAUSA N.º 1	Úlcera péptica (60 %)	**Hemorroides y fisuras**
OTRAS CAUSAS	Gastritis erosiva, **várices** esofágicas, **Mallory-Weiss**, esofagitis, neoplasias, malformaciones AV	Divertículos, angiodisplasia (colon derecho), cáncer, EII, colitis isquémica, Meckel
SONDA NASOGÁSTRICA	Hemática / borra de café	Limpia

UREA	Elevada (sangre digerida)	Normal
ESTUDIO	Endoscopía alta	**Colonoscopía**

FUENTE Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 15:42

Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 16:22 | Clase Hemorragias digestivas · parte 2 · min 00:00

Clase Hemorragias digestivas · parte 2 · min 01:40 | Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 390

BAJA: LA EDAD ORIENTA

Menor de 45

- Hemorroides, fisuras
- Enfermedad inflamatoria
- Divertículo de Meckel

Mayor de 65

- Angiodisplasia, divertículos
- **Cáncer** de colon
- Antecedentes familiares → colonoscopía

★ **TODA HEMORRAGIA ES SECUNDARIA**

Nadie sangra porque sí: la anamnesis busca la causa (AINE, aspirina, corticoides, H. pylori, alcohol, cirrosis, vómitos previos).

FUENTE Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 17:02

Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 17:43 | Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 19:03

FUENTE Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 15:42

Clase Hemorragias digestivas · parte 2 · min 01:40 | Clase Hemorragias digestivas · parte 2 · min 05:08

Qué se pide

MUY IMPORTANTE

> La conducta principal es la endoscopía (alta o baja).

PRIMERO

Estabilizar + SNG + tacto rectal

Signos vitales, perfusión, ortostatismo. Aspirado nasogástrico (¿hay sangre arriba?) y tacto rectal.

CONDUCTA PRINCIPAL

Endoscopía

Alta si el sangrado es alto; **colonoscopía** (completa, hasta la válvula ileocecal) si es bajo.

SI NO SE ENCUENTRA

Arteriografía / angiografía

Localiza el vaso que sangra; centellograma; laparotomía en último caso.

LABORATORIO

Hemograma, ionograma, coagulación, glucemia, **urea (aumentada)**, creatinina y **grupo y factor**. Si no se conoce el grupo y hay que transfundir de urgencia: **0 negativo**.

FUENTE Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 29:49

Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 30:30 · Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 31:10

Clasificación de Forrest (úlcera sangrante, por endoscopía)

Ia	Ib	IIa	IIb	IIc	III
Sangrado en chorro	Sangrado en napa	Vaso visible	Coágulo adherido	Base con hematina	Base limpia

Tocá un escalón para ver el detalle.

Cuanto más bajo el número, más riesgo de resangrado. El profe aclara que **no lo toman en el parcial** (es de medicina interna), pero conviene conocerla.

FUENTE Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 25:46

Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 26:28 · Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 27:09

Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 28:29 · Clase Hemorragias digestivas · parte 2 · min 09:54

Clase Hemorragias digestivas · parte 2 · min 10:34

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Clases de hemorragia

Para qué sirve: «Como el Padre Nuestro».

- I < 750 · FC < 100
- II 750–1500 · FC 100–119
- III 1500–2000 · FC 120–139
- IV > 2000 · FC > 140

Cómo interpretarlo: Cada clase sube unos 20 latidos.

Mnemotecnia: FC: 100 · 120 · 140 (cada clase, +20). — Los cortes de frecuencia cardíaca separan las clases.

Causa n.º 1

Para qué sirve: Pregunta de parcial.

- Alta: úlcera péptica
- Baja: hemorroides y fisuras

Cómo interpretarlo: Lo más común gana, no lo más grave.

Mnemotecnia: Arriba la Úlcera, abajo el Hemorroide. — Alta = úlcera; baja = hemorroides y fisuras.

Ortostatismo

Para qué sirve: Pregunta de parcial.

- Acostado 2–5 min
- De pie: 3 y 5 min
- PAS ↓ > 20 · PAD ↓ > 10 · FC ↑ > 30

Cómo interpretarlo: Positivo = hipovolemia.

Mnemotecnia: 20 – 10 – 30. — PAS cae 20, PAD cae 10, FC sube 30.

Integración: lo imprescindible

- **Clases I–IV**: < 750 / 750–1500 / 1500–2000 / > 2000 ml; FC < 100 / 100–119 / 120–139 / > 140.
- **Ortostatismo** positivo: PAS ↓ > 20, PAD ↓ > 10, FC ↑ > 30 o síntomas.
- **Alta** (hasta Treitz): la más frecuente y grave; causa n.º 1 **úlcera péptica**.
- **Baja** (Treitz–ano): causa n.º 1 **hemorroides y fisuras**.
- Melena 85 % alta; hematoquecia 85 % baja; toda hemorragia → **anemia ferropénica**.
- Conducta: estabilizar → SNG → **endoscopía** (alta) o **colonoscopía** (baja).

Desarrollos modelo

1. Tabla de parámetros vitales de la hemorragia digestiva según clases I a IV.

	I LEVE	II MODERADA	III GRAVE	IV MASIVA
Pérdida	< 750 ml (< 15 %)	750–1500 (15–30 %)	1500–2000 (30–40 %)	> 2000 (> 40 %)
FC	< 100	100–119	120–139	> 140
PA	Normal	Normal o ↓	↓ (TAS < 100)	↓↓
FR	14–20	20–30	30–39	> 40
Diuresis	> 30	20–30	5–20	Imperceptible
Mental	Normal	Ansioso	Ansioso y confuso	Confuso

2. Defina hemorragia digestiva alta y mencione al menos cinco etiologías.

Sangrado desde el esfínter esofágico superior hasta el **ángulo de Treitz** (esófago, estómago, duodeno). Es la **más frecuente y la más grave**. Se manifiesta con hematemesis y melena.

Etiologías: úlcera péptica (60 %), gastritis erosiva (8 %), várices esofágicas (6 %), Mallory-Weiss (4 %), esofagitis, neoplasias (2 %), malformaciones arteriovenosas.

3. ¿Cómo se realiza la prueba de hipotensión ortostática?

Paciente **acostado 2–5 min**: medir PA y FC. **De pie**: medir a los **3 y 5 min**. **Positiva:** caída de la PAS **> 20 mmHg** o de la PAD **> 10 mmHg**, aumento de la FC **> 30 lpm**, o síntomas (mareo, lipotimia). Indica **hipovolemia** (también puede ser cardíaca).

4. Defina hemorragia digestiva baja y mencione cinco etiologías.

Sangrado desde el **ángulo de Treitz hasta el ano**. Menos frecuente y menos grave; suele estar estable y puede pasar desapercibida (sangre oculta).

Etiologías: hemorroides y fisuras (las más frecuentes), divertículos, angiodisplasia (colon derecho), cáncer colorrectal, enfermedad inflamatoria, colitis isquémica, divertículo de Meckel.

5. Cuadro de diferenciación clínica de HDA y HDB.

	ALTA	BAJA
Presentación	Hematemesis, melena	Hematoquecia, proctorragia
Hemodinamia	Más grave, inestable	Suele ser estable
Urea	Elevada	Normal
SNG	Hemática / borra de café	Limpia
Estudio	Endoscopía alta	Colonoscopía

6. Explique la clasificación de Forrest.

Clasificación endoscópica de la úlcera sangrante: **Ia** sangrado en chorro, **Ib** en napa, **IIa** vaso visible, **IIb** coágulo adherido, **IIc** base con hematina, **III** base limpia. Cuanto menor el número, mayor riesgo de resangrado. (El profe aclara que no se toma en el parcial.)

Preguntas de repaso (choice)

1. La causa **más frecuente** de hemorragia digestiva alta es:
    A. Mallory-Weiss.
    B. Úlcera péptica.
    C. Cáncer gástrico.
    D. Várices esofágicas.

2. La causa **más frecuente** de hemorragia digestiva baja es:

   A. Cáncer de colon.
   B. Angiodisplasia.
   C. Divertículos.
   D. Hemorroides y fisuras.

3. El límite entre hemorragia digestiva alta y baja es:

   A. El esfínter esofágico inferior.
   B. El píloro.
   C. La válvula ileocecal.
   D. El ángulo de Treitz.

4. La **melena** proviene en el 85 % de los casos de:

   A. El colon izquierdo.
   B. El tubo digestivo alto.
   C. El recto.
   D. Las hemorroides.

5. Una hematoquecia puede venir del tubo **alto** cuando:

   A. El sangrado es mayor a 1000 ml o el tránsito es muy rápido.
   B. El tránsito es lento.
   C. Hay hemorroides.
   D. Nunca.

6. FC 130, TAS 90, FR 32, diuresis 10 ml/h, ansioso y confuso. Clase de hemorragia:

   A. I.
   B. II.
   C. III (grave, 30–40 %).
   D. IV.

7. Una pérdida de **más de 2000 ml** (> 40 %) corresponde a:

   A. Clase IV: shock hipovolémico.
   B. Clase II.
   C. No se clasifica.
   D. Clase I.

8. La prueba de ortostatismo es positiva si al ponerse de pie:

   A. La PAS cae más de 20 mmHg (o la PAD más de 10, o la FC sube más de 30).
   B. La FC baja.
   C. La PAS sube 10 mmHg.
   D. La saturación sube.

9. En la hemorragia digestiva **alta**, la urea suele estar:

   A. No se pide.
   B. Baja.
   C. Normal siempre.
   D. Elevada, por la digestión de la sangre.

10. Paciente con anemia ferropénica y sangre oculta en materia fecal positiva. Estudio indicado:
    A. Colonoscopía.
    B. Ecografía.
    C. Rx de abdomen.
    D. Nada.

Respuestas

1. **B** — Correcto: «tiene que decir úlceras».
2. **D** — Correcto.
3. **D** — Correcto.
4. **B** — Correcto.
5. **A** — Correcto.
6. **C** — Correcto.
7. **A** — Correcto.
8. **A** — Correcto.
9. **D** — Correcto.
10. **A** — Correcto.

CAPÍTULO 13

Cirrosis e hipertensión portal

La «preinsuficiencia hepática», sus estigmas y el Child-Pugh; la hipertensión portal, sus colaterales, la ascitis y el GASA.

NECESITÁS SABER

- Ictericia (dig-04)
- Ascitis en el examen (dig-05)

Cirrosis e hipertensión portal

«Tema **importantísimo**, muy preguntado en los orales sobre todo, y en el parcial y en el final... **como la palma de su mano**.» Lo que marca como Padre Nuestro: **Child-Pugh** (BATEA), **GASA**, la **hipertensión portal** y la **ascitis**.

Cirrosis
Crónica, irreversible, fibrosis · Causas: alcohol n.º 1 · Compensada vs descompensada

Child-Pugh ★
BATEA · A 5–6 · B 7–9 · C 10–15 · C = trasplante

Hipertensión portal ★
> 12 mmHg · Pre · intra · posthepática · Colaterales

Ascitis y GASA ★
Fisiopatología · Paracentesis · GASA ≥ 1,1

AL TERMINAR VAS A PODER

- Definir cirrosis y nombrar sus causas y estigmas.
- Calcular e interpretar el Child-Pugh (BATEA).
- Definir hipertensión portal, clasificarla y explicar sus colaterales.
- Explicar la ascitis y usar el GASA.

Qué es: la «preinsuficiencia hepática»

IMPRESCINDIBLE

> Hepatopatía crónica, progresiva e irreversible: fibrosis y nódulos que destruyen la arquitectura del hígado.

CÓMO PENSARLA

«La cirrosis yo la tomo como una **preinsuficiencia hepática**»: se pierden hepatocitos y, con ellos, lo que hace el hígado. Si no fabrica **proteínas** → edema; si no fabrica **factores de coagulación** → hemorragias. Al principio el hígado está grande; después se achica.

FUENTE Clase Cirrosis · parte 1 · min 00:49 · Clase Cirrosis · parte 1 · min 01:31 · Clase Cirrosis · parte 1 · min 02:55 · Clase Cirrosis · parte 1 · min 04:18

Causas

	Qué hay que saber
ALCOHÓLICA	**La más frecuente**: esteatosis → hepatitis alcohólica → cirrosis (Laennec). Más alcohol, más rápido.
NO ALCOHÓLICA (NASH)	Obesidad, diabetes, dislipemia: hígado graso → esteatohepatitis
VIRALES	Hepatitis **B** y **C** (aceleran la cirrosis del bebedor)
AUTOINMUNES	**Biliar primaria**: mujeres, antimitocondriales, prurito, melanosis · hepatitis autoinmune
METABÓLICAS	**Hemocromatosis** (hierro), **Wilson** (cobre), déficit de α1-antitripsina
VASCULARES	Insuficiencia cardíaca, **Budd-Chiari**, pericarditis constrictiva

FUENTE Clase Cirrosis · parte 1 · min 06:24 · Clase Cirrosis · parte 1 · min 07:05 · Clase Cirrosis · parte 1 · min 08:26 · Clase Cirrosis · parte 1 · min 16:31

TRES ETAPAS

Hipertensión portal → **encefalopatía** (al final) → **insuficiencia hepática** (etapa final).

FUENTE Clase Cirrosis · parte 1 · min 05:00 · Clase Cirrosis · parte 1 · min 05:42

FUENTE Clase Cirrosis · parte 1 · min 00:01 Clase Cirrosis · parte 1 · min 00:49

Estigmas, compensada y descompensada

IMPRESCINDIBLE

> Compensada: casi asintomática. Descompensada: todo acentuado + hipertensión portal.

HORMONAL

Hábito de Chvostek

↑ estrógenos / ↓ andrógenos: **ginecomastia**, atrofia testicular, vello pubiano ginecoide.

PIEL

Arañas vasculares

Spiders: dilatación de capilares superficiales (no confundir con estrías).

MANOS

Eritema palmar · Dupuytren

Eritema tenar e hipotenar (no patognomónico). Contractura de la aponeurosis palmar.

UÑAS

Uñas de Terry

Blancas proximales, rojas distales: **hipoalbuminemia**.

SANGRADO

Equimosis, epistaxis

Faltan factores de coagulación + plaquetopenia por hiperesplenismo.

NEURO

Asterixis

Encefalopatía hepática: alteración de la conciencia, temblor aleteante, coma.

Compensada vs descompensada

	Compensada	Descompensada
CLÍNICA	Asintomática o inespecífica; hepatoesplenomegalia, arañas, ginecomastia	Todo acentuado + hipertensión portal + insuficiencia hepática
SIGNOS	Eritema palmar, Dupuytren, parótidas	Ascitis, várices, ictericia, encefalopatía, infecciones, desnutrición

LABORATORIO	Hiperesplenismo, ↑ transaminasas, ↑ γ-globulinas, ↓ albúmina, ↓ protrombina	Lo mismo, más marcado

FUENTE Clase Cirrosis · parte 1 · min 19:18 · Clase Cirrosis · parte 1 · min 20:38 · Clase Cirrosis · parte 1 · min 21:19 · Clase Cirrosis · parte 1 · min 23:20 · Clase Cirrosis · parte 1 · min 24:00

FUENTE Clase Cirrosis · parte 1 · min 12:26 · Clase Cirrosis · parte 1 · min 13:08 · Clase Cirrosis · parte 2 · min 00:01 · Clase Cirrosis · parte 2 · min 00:43 · Clase Cirrosis · parte 2 · min 01:29 · Clase Cirrosis · parte 2 · min 02:11 · Clase Cirrosis · parte 2 · min 03:36

Child-Pugh (BATEA)

IMPRESCINDIBLE

> Pronóstico: A 5–6 compensada · B 7–9 descompensada reversible · C 10–15 irreversible (trasplante).

PARA NO BOCHAR

«Pregunta de parcial, **como el Padre Nuestro**, me tienen que saber la clasificación de Child-Pugh: **el que no se sepa esto, lo bochan directamente**.» Mnemotecnia: **BATEA**.

FUENTE Clase Cirrosis · parte 2 · min 07:04 · Clase Cirrosis · parte 2 · min 07:47

B A T E A

Tocá para desplegar

FUENTE Clase Cirrosis · parte 2 · min 07:47

◎ Calculá el Child-Pugh

Bilirrubina (mg/dl)	< 2 (1)	2–3 (2)	> 3 (3)
Albúmina (g/dl)	> 3,5 (1)	2,8–3,5 (2)	< 2,8 (3)

Tiempo de protrombina (RIN)	< 1,7 (1)	1,7–2,3 (2)	> 2,3 (3)
Encefalopatía	Ausente (1)	Grado I–II (2)	Grado III–IV (3)
Ascitis	Ausente (1)	Leve (2)	Moderada-severa (3)

5 **Child A**
Cirrosis **compensada**.

Child A: 5–6 | Child B: 7–9 | Child C: 10–15

Los cortes A/B/C y su significado los da el profe; los valores de cada parámetro son los estándar de la clasificación.

FUENTE Clase Cirrosis · parte 2 · min 07:04 | Clase Cirrosis · parte 2 · min 08:28

Hipertensión portal: definición, causas y colaterales

IMPRESCINDIBLE

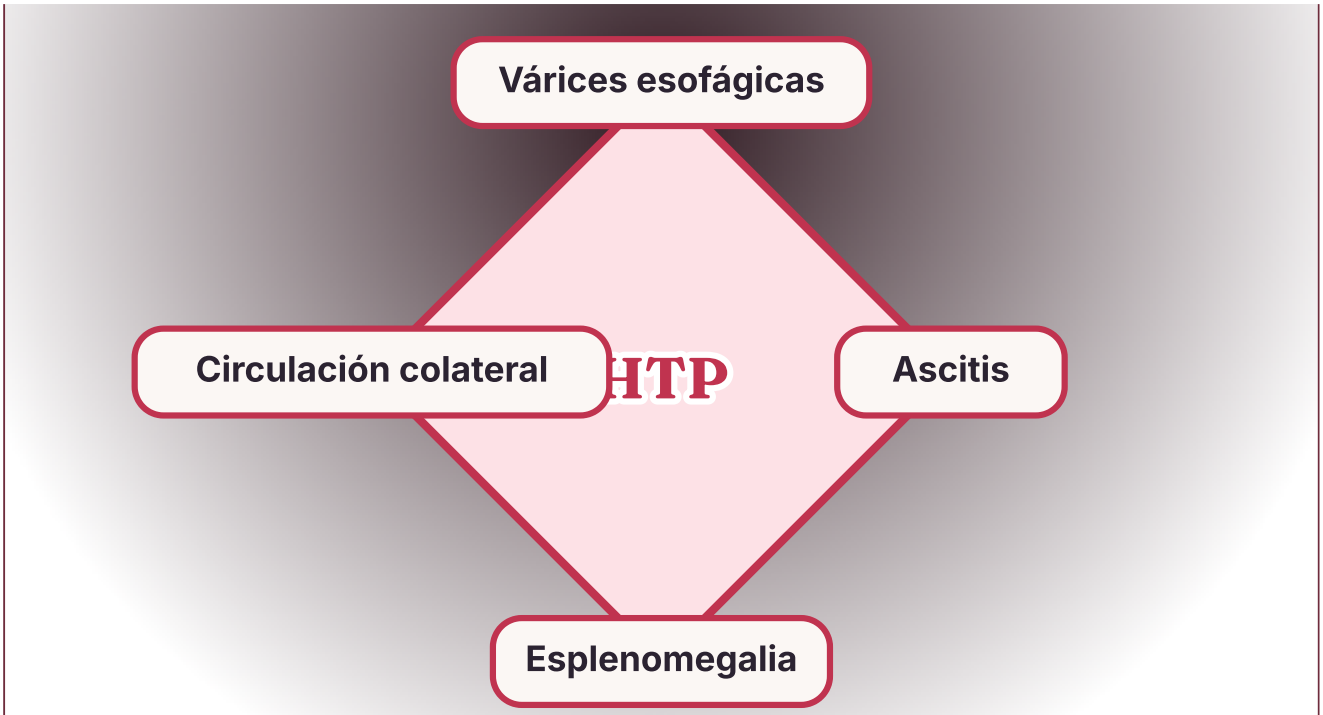
> Presión portal > 12 mmHg. Causa n.º 1: cirrosis. La sangre vuelve y abre colaterales portocava.

PREGUNTA DE PARCIAL

«La hipertensión portal es **pregunta de parcial**»: aumento de la presión del sistema porta **por encima de 12 mmHg** (normal ≈ 8–10). «Lo que más quiero que sepan es la **clínica**: es todo relacionar.»

FUENTE Clase Hipertensión portal · parte 1 · min 00:02 | Clase Hipertensión portal · parte 1 · min 04:10





Las cuatro manifestaciones que el profe lista como pregunta de examen.

FUENTE Clase Peritonitis · parte 1 · min 09:03

Hipertensión portal: ¿dónde está el obstáculo?

Prehepática
Sistema porta: trombosis de la porta o de la esplénica

★ **Hepática**
Cirrosis (la más frecuente, sinusoidal)

Suprahepática
Budd-Chiari, insuficiencia cardíaca derecha, pericarditis constrictiva

Circulaciones colaterales portocava (pregunta de parcial)

	Dónde	Qué produce
GASTROESOFÁGICA (PROFUNDA)	Coronaria estomáquica ↔ ácigos	**Várices esofágicas**: 30 % en la compensada, 60–70 % en la descompensada; causa de muerte frecuente. Se ven por **endoscopía**

PARAUMBILICAL (SUPERFICIAL)	Paraumbilical ↔ epigástricas	**Cabeza de medusa**
RECTAL	Hemorroidal superior ↔ media e inferior	**Hemorroides**
RETROPERITONEAL	Mesentéricas ↔ retroperitoneales	Poco frecuente

FUENTE Clase Hipertensión portal · parte 1 · min 05:39

Clase Hipertensión portal · parte 1 · min 07:43 · Clase Hipertensión portal · parte 1 · min 09:15 · Clase Hipertensión portal · parte 1 · min 09:59 · Clase Hipertensión portal · parte 1 · min 10:43 · Clase Hipertensión portal · parte 1 · min 11:26

Maniobra: ¿la vena sube o baja? (pregunta de la Dra. González)

1 — Comprimir la vena
Con el dedo, se detiene el flujo en ese punto.

2 — Mirar dónde se llena
Se ingurgita del lado del que **viene** la sangre.

3 — Interpretar
Ingurgitada **por debajo** del dedo = **ascendente**; **por arriba** = **descendente**.

La portocava típica parte del ombligo hacia la base del tórax.

FUENTE Clase Hipertensión portal · parte 1 · min 00:44 · Clase Hipertensión portal · parte 1 · min 01:25 · Clase Hipertensión portal · parte 1 · min 02:06 · Clase Hipertensión portal · parte 1 · min 12:56 · Clase Hipertensión portal · parte 1 · min 13:38 · Clase Hipertensión portal · parte 1 · min 15:45

Ascitis, paracentesis y GASA

IMPRESCINDIBLE

> Causa n.º 1: hipertensión portal. Paracentesis: recuento (> 250 PMN = PBE) y GASA (≥ 1,1 = HTP).

ÉNFASIS DEL PROFESOR

«Ascitis **pregunta muchísimo**. Muy preguntado. Cuando fui a rendir el final de clínica médica, a mí me preguntaron ascitis.»

FUENTE Clase Hipertensión portal · parte 1 · min 16:27

GASA (como el Padre Nuestro)

	GASA ≥ 1,1 g/dl	GASA < 1,1 g/dl
SIGNIFICA	Hay hipertensión portal	El sistema porta **no** está afectado
CAUSAS	**Cirrosis**, causa cardíaca, Budd-Chiari, metástasis hepáticas, hepatitis alcohólica, trombosis portal	**Carcinomatosis peritoneal**, tuberculosis, pancreatitis, síndrome nefrótico

FUENTE Clase Hipertensión portal · parte 2 · min 16:40

Clase Hipertensión portal · parte 2 · min 17:23 Clase Hipertensión portal · parte 2 · min 18:06

Clase Hipertensión portal · parte 2 · min 18:49

CHILD-PUGH Y GASA

«Esto me lo estudian como si fuese el **Padre Nuestro**... el **Child-Pugh** con la mnemotecnia BATEA y el **GASA** preguntan muchísimo.»

FUENTE Clase Hipertensión portal · parte 2 · min 18:49

Clase Hipertensión portal · parte 2 · min 19:31

ASPECTO

Transparente

Trasudado: ↓ oncótica o ↑ hidrostática (cirrosis).

ASPECTO

Turbio

Infección (PBE) o quilosa (triglicéridos > 200 mg/dl, linfa).

ASPECTO

Hemático

Neoplasia, tuberculosis, pancreatitis, traumatismo.

EXAMEN Y ESPLENOMEGALIA

Abdomen globoso, ombligo evertido, RHA ausentes donde hay líquido, **matidez desplazable**, onda ascítica, témpano: «lo que sí o sí tienen que saber hacer es la percusión». La causa más frecuente de **esplenomegalia** es la hipertensión portal (con hiperesplenismo).

FUENTE Clase Hipertensión portal · parte 2 · min 08:54

Clase Hipertensión portal · parte 2 · min 10:19 | Clase Hipertensión portal · parte 2 · min 11:46

Clase Hipertensión portal · parte 2 · min 20:55

FUENTE Clase Hipertensión portal · parte 1 · min 16:27 | Clase Hipertensión portal · parte 1 · min 17:09

Clase Hipertensión portal · parte 2 · min 00:40 | Clase Hipertensión portal · parte 2 · min 05:10

Clase Hipertensión portal · parte 2 · min 12:28 | Clase Hipertensión portal · parte 2 · min 15:13

Cómo se estudia

MUY IMPORTANTE

ANAMNESIS

Causa

Alcohol (cuánto, desde cuándo), hepatitis B y C, fármacos hepatotóxicos (paracetamol, metildopa, isoniazida), antecedentes familiares.

LABORATORIO

Hepatograma completo

Transaminasas, colestasis, albúmina, protrombina, hemograma (anemia, pancitopenia), autoanticuerpos.

IMÁGENES

Eco · endoscopía

Diámetro de la vena porta, ascitis; **VEDA** para várices.

CERTEZA

Biopsia hepática

Diagnóstico y etiología.

FUENTE Clase Hipertensión portal · parte 2 · min 20:55 | Clase Hipertensión portal · parte 2 · min 22:20

Clase Hipertensión portal · parte 2 · min 23:48 | Clase Hipertensión portal · parte 2 · min 25:10

Clase Hipertensión portal · parte 2 · min 26:32

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Child-Pugh

Para qué sirve: «Lo bochan directamente».

- BATEA
- A 5–6
- B 7–9
- C 10–15 → trasplante

Cómo interpretarlo: Mide cuánto hígado queda funcionando.

Mnemotecnia: BATEA: «una batea para lavar el hígado». — Bilirrubina, Albúmina, Tiempo de protrombina, Encefalopatía, Ascitis.

GASA

Para qué sirve: «Como el Padre Nuestro».

- Albúmina sérica – ascítica
- ≥ 1,1: HTP
- < 1,1: otra causa

Cómo interpretarlo: Gradiente alto = en el líquido hay poca albúmina comparada con la sangre: salió empujado por la presión portal, no por inflamación del peritoneo.

Mnemotecnia: Uno-uno: «arriba de 1,1, la porta está alta». — ≥ 1,1 g/dl = hipertensión portal.

Hipertensión portal

Para qué sirve: Pregunta de parcial.

- > 12 mmHg
- Várices, ascitis, esplenomegalia, colaterales
- Pre · hepática (cirrosis) · supra

Cómo interpretarlo: Toda la clínica es «la sangre que vuelve para atrás».

Mnemotecnia: «VACE»: Várices, Ascitis, Circulación colateral, Esplenomegalia. — Las cuatro manifestaciones.

Integración: lo imprescindible

- **Cirrosis**: hepatopatía crónica, progresiva, irreversible (fibrosis + nódulos); alcohol n.º 1.
- **Child-Pugh (BATEA)**: A 5–6 compensada · B 7–9 reversible · C 10–15 irreversible (trasplante).
- **HTP**: > 12 mmHg; pre (trombosis portal), hepática (**cirrosis**), supra (Budd-Chiari, IC derecha).
- Manifestaciones: **várices esofágicas**, **ascitis**, **esplenomegalia**, **circulación colateral** (cabeza de medusa, hemorroides).
- **Ascitis**: ↓ albúmina + ↑ presión portal + linfa → SRAA → retiene Na y agua. Paracentesis: > 250 PMN = PBE; **GASA ≥ 1,1** = HTP.

Desarrollos modelo

1. Parámetros de la clasificación de Child-Pugh y su interpretación.

BATEA: Bilirrubina, Albúmina, Tiempo de protrombina, Encefalopatía, Ascitis; cada uno suma 1, 2 o 3 puntos.

	1	2	3
Bilirrubina	< 2	2–3	> 3
Albúmina	> 3,5	2,8–3,5	< 2,8
RIN	< 1,7	1,7–2,3	> 2,3
Encefalopatía	No	I–II	III–IV
Ascitis	No	Leve	Moderada-severa

A (5–6): compensada. **B (7–9):** descompensada, reversible. **C (10–15):** irreversible → trasplante.

2. Mencione la clasificación de GASA.

GASA = albúmina sérica – albúmina del líquido ascítico (por paracentesis). **≥ 1,1 g/dl:** hipertensión portal (cirrosis, cardíaca, Budd-Chiari, metástasis hepáticas). **< 1,1 g/dl:** sin hipertensión portal (carcinomatosis peritoneal, tuberculosis, pancreatitis, nefrótico). Además: **> 250 neutrófilos/mm³** = PBE.

3. ¿Qué es la hipertensión portal? Clasificación, etiologías y hallazgos semiológicos.

Aumento de la presión del sistema porta **> 12 mmHg**. **Prehepática** (trombosis portal o esplénica), **hepática** (**cirrosis**, la más frecuente), **suprahepática** (Budd-Chiari, IC derecha, pericarditis constrictiva).

Hallazgos: várices esofágicas, **ascitis**, **esplenomegalia** (hiperesplenismo) y **circulación colateral** (cabeza de medusa, hemorroides).

4. Definición de cirrosis, etiologías y manifestaciones de la cirrosis compensada y descompensada.

Hepatopatía **crónica, progresiva e irreversible**, con fibrosis y nódulos que alteran la arquitectura hepática («preinsuficiencia hepática»).

Causas: alcohol (n.º 1), NASH, virus B y C, autoinmunes (biliar primaria, hepatitis autoinmune), hemocromatosis, Wilson, déficit de α1-antitripsina, vasculares (Budd-Chiari, IC).

Compensada: asintomática o inespecífica (arañas, eritema palmar, ginecomastia, hepatoesplenomegalia). **Descompensada:** todo acentuado + hipertensión portal (ascitis, várices), ictericia, encefalopatía, infecciones.

5. ¿Cuáles son las circulaciones colaterales de la hipertensión portal y cómo se determina la dirección del flujo?

Portocava: gastroesofágica (várices esofágicas, profunda, se ven por endoscopía), paraumbilical (cabeza de medusa, superficial), rectal (hemorroides) y retroperitoneal.

Dirección: comprimir la vena con el dedo y ver de qué lado se ingurgita: por debajo del dedo = ascendente; por arriba = descendente.

Preguntas de repaso (choice)

1. La causa más frecuente de cirrosis es:
    A. La hemocromatosis.
    B. La enfermedad de Wilson.
    C. El alcohol.
    D. La hepatitis A.

2. La mnemotecnia BATEA del Child-Pugh incluye:
    A. Bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, encefalopatía, ascitis.
    B. BUN, albúmina, temperatura, edema, anemia.
    C. Bazo, ascitis, tórax, encefalopatía, aliento.
    D. Bilirrubina, amilasa, transaminasas, edad, ascitis.

3. Un Child-Pugh de **11 puntos** corresponde a:
    A. Clase C: irreversible, considerar trasplante.
    B. Clase B, reversible.
    C. No clasificable.
    D. Clase A, compensada.

4. Se habla de hipertensión portal cuando la presión portal supera:
    A. 40 mmHg.
    B. 120 mmHg.
    C. 12 mmHg.
    D. 5 mmHg.

5. El síndrome de Budd-Chiari produce hipertensión portal:
    A. Suprahepática (obstrucción de las venas suprahepáticas).
    B. Hepática sinusoidal.
    C. Prehepática.
    D. No produce.

6. La colateral portocava **profunda** más importante, causa frecuente de muerte, es:
    A. Las várices esofágicas.
    B. La cabeza de medusa.
    C. Las hemorroides.
    D. Las retroperitoneales.

7. Comprimís una vena colateral del abdomen y se ingurgita **por debajo** del dedo. El flujo es:
    A. Ascendente.
    B. Arterial.
    C. Descendente.
    D. No se puede saber.

8. GASA de 1,8 g/dl indica:
    A. Hipertensión portal (p. ej., cirrosis).
    B. Peritonitis tuberculosa.
    C. Infección del líquido.
    D. Carcinomatosis peritoneal.

9. En la ascitis del cirrótico, el riñón retiene sodio y agua porque:
    A. Aumenta la albúmina.
    B. Por exceso de proteínas.
    C. Baja la volemia efectiva y se activan el SRAA y el simpático.
    D. Hay insuficiencia renal siempre.

10. La ginecomastia y la atrofia testicular del cirrótico se deben a:
    A. Hiperesplenismo.
    B. Colestasis.
    C. Aumento de estrógenos y disminución de andrógenos.
    D. Hipoalbuminemia.

11. La causa más frecuente de esplenomegalia es:
    A. El trauma.
    B. La hipertensión portal.
    C. La anemia ferropénica.
    D. La leucemia.

Respuestas

1. **C** — Correcto.
2. **A** — Correcto.
3. **A** — Correcto (10–15).
4. **C** — Correcto.
5. **A** — Correcto.
6. **A** — Correcto.
7. **A** — Correcto: la sangre viene de abajo.
8. **A** — Correcto (≥ 1,1).
9. **C** — Correcto.
10. **C** — Correcto (hábito de Chvostek).
11. **B** — Correcto (las infecciosas son la segunda).

CAPÍTULO 14

Insuficiencia hepática

Lo que el hígado deja de hacer: O'Grady, encefalopatía hepática (el amoníaco), manifestaciones sistémicas y aguda vs crónica.

NECESITÁS SABER

- Cirrosis (dig-13)
- Funciones del hígado

Insuficiencia hepática

El profe marca tres cosas: la clasificación de **O'Grady** («esta no me la pueden no saber»), la **encefalopatía hepática** («si no la saben, **los van a bochar**») y el **diferencial aguda vs crónica** («pregunta de examen puede ser»).

Qué deja de hacer
Albúmina → edema · Coagulación → sangrado · Urea → amoníaco

Aguda ★
O'Grady · Bernuau · Paracetamol

Encefalopatía ★
Amoníaco → glutamina · Edema cerebral · Asterixis

Aguda vs crónica
Súbita vs gradual · Necrosis vs cirrosis · Extrapiramidal

AL TERMINAR VAS A PODER

- Deducir la clínica a partir de las funciones que se pierden.
- Clasificar la insuficiencia aguda según O'Grady.
- Explicar la encefalopatía hepática y reconocer su tríada.
- Diferenciar insuficiencia aguda de crónica.

Qué es y qué deja de hacer el hígado

IMPRESCINDIBLE

> Se perdió más del 80–90 % de la función hepática. Síndrome grave, mortalidad 40–80 %: el tratamiento definitivo es el trasplante.

CÓMO ESTUDIARLA

«Si esto hace un hígado normal, ¿qué hace un hígado insuficiente? **Todo lo contrario**.» No fabrica proteínas ni factores de coagulación, no transforma el amoníaco en urea, no desintoxica la sangre.

FUENTE Clase Insuficiencia hepática · min 04:11 · Clase Insuficiencia hepática · min 04:52 · Clase Insuficiencia hepática · min 05:32

FUENTE Clase Insuficiencia hepática · min 00:42 · Clase Insuficiencia hepática · min 06:14 · Clase Insuficiencia hepática · min 06:55 · Clase Insuficiencia hepática · min 07:35

Insuficiencia hepática aguda: O'Grady y Bernuau

IMPRESCINDIBLE

> Lo que define el tipo es cuándo aparece la encefalopatía.

SÍ O SÍ

«El que ustedes tienen que saber sí o sí es el según **O'Grady**... **esta no me la pueden no saber**.» Clasifica según cuándo aparece la **encefalopatía**.

FUENTE Clase Insuficiencia hepática · min 08:15

O'Grady (como lo da el profe)

< 8 DÍAS	8 A 28 DÍAS	4 A 24 SEMANAS
Hiperaguda	**Aguda**	**Subaguda**
Encefalopatía muy brusca.		

BERNUAU: DESDE LA ICTERICIA HASTA LA ENCEFALOPATÍA

Fulminante

- Encefalopatía **dentro de las 2 semanas** de iniciada la ictericia

Subfulminante

- Encefalopatía entre las **2 y 12 semanas**

FÁRMACOS

Paracetamol

Máximo 4 g/día; más de **6 g/día** varios días puede dar una **falla hepática fulminante**.

OTRAS

Virus, Wilson, embarazo

Hepatitis virales, Wilson, hemocromatosis neonatal, tirosinemia; esteatosis gravídica, HELLP.

PRONÓSTICO

Siempre malo

«Todo paciente con insuficiencia hepática ya tiene un pronóstico malo»: alta mortalidad.

FUENTE Clase Insuficiencia hepática · min 08:15 · Clase Insuficiencia hepática · min 08:55 · Clase Insuficiencia hepática · min 09:35 · Clase Insuficiencia hepática · min 10:15 · Clase Insuficiencia hepática · min 12:15 · Clase Insuficiencia hepática · min 12:56 · Clase Insuficiencia hepática · min 14:16

Encefalopatía hepática

IMPRESCINDIBLE

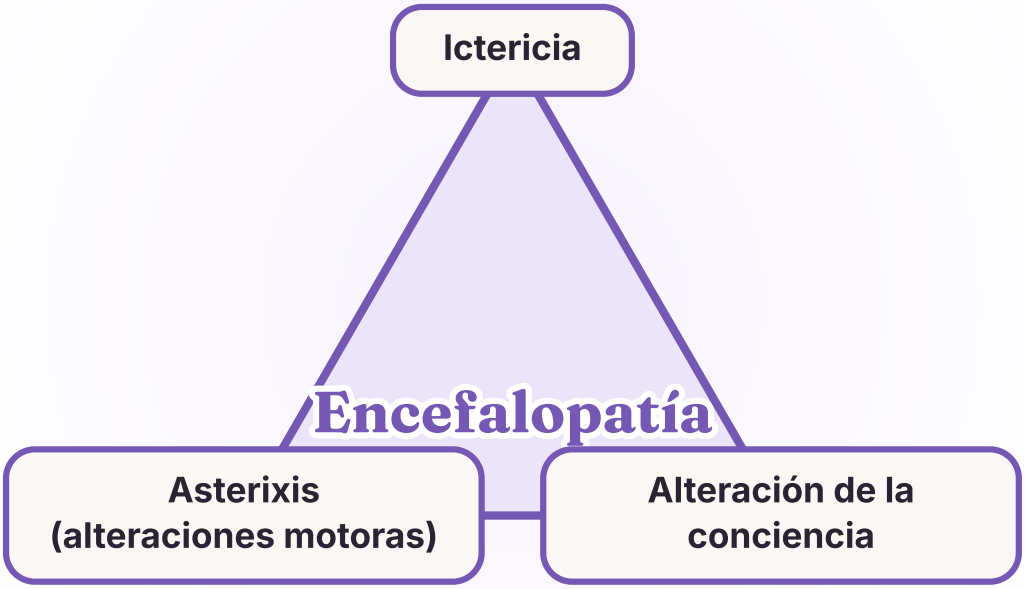
> El amoníaco que el hígado no convierte en urea llega al cerebro: edema cerebral, alteración de la conciencia y asterixis.

PARA NO BOCHAR

«La encefalopatía hepática: pregunta de **parcial, choice, oral y final**. Si no saben encefalopatía hepática **los van a bochar**: tienen que sabérsela sí o sí.»

FUENTE Clase Insuficiencia hepática · min 19:02

Encefalopatía hepática



«Piensen en una encefalopatía hepática **hasta que se demuestre lo contrario**.» La asterixis es un temblor aleteante (flapping) de las manos.

FUENTE Clase Insuficiencia hepática · min 25:17 Clase Insuficiencia hepática · min 26:37

Grados (tabla de West Haven, estándar)

0	I	II	III	IV
Subclínica	Leve	Letargo	Estupor	Coma

Tocá un escalón para ver el detalle.

El profe enumera los estadios (subclínico a IV) y aclara que no hace falta memorizar la tabla: lo que se pide es entender el mecanismo y reconocer la tríada.

FUENTE Clase Insuficiencia hepática · min 19:02 Clase Insuficiencia hepática · min 19:43

Clase Insuficiencia hepática · min 20:23 | Clase Insuficiencia hepática · min 24:37 | Clase Insuficiencia hepática · min 27:18 | Clase Insuficiencia hepática · min 40:23 | Clase Insuficiencia hepática · min 41:03

Manifestaciones hepáticas y sistémicas

MUY IMPORTANTE

HEPÁTICAS

Ictericia rápida

Predominio **directo**; transaminasas altas al inicio que caen al final; ↓ seudocolinesterasa, ↓ albúmina, ↓ factores.

COAGULACIÓN

Hemorragias

Coagulopatía, CID; sangrado digestivo alto frecuente.

INMUNIDAD

Infecciones

Sin proteínas ni opsonización: paciente **inmunocomprometido**.

METABÓLICAS

Hipoglucemia y electrolitos

Hipoglucemia, hipopotasemia (diuréticos), hiponatremia; **acidosis metabólica** con alcalosis respiratoria.

RENAL

Insuficiencia prerrenal

Casi la mitad: por hipoperfusión.

HORMONAL

↑ estrógenos

Ginecomastia, atrofia testicular (hábito de Chvostek); aliento hepático.

DIAGNÓSTICO

El interrogatorio suele ser **indirecto** (el paciente llega confuso). Laboratorio: glucemia, bilirrubina (directa), **tiempo de protrombina prolongado**, pH (la acidosis es de muy mal pronóstico), transaminasas, amoniemia.

FUENTE Clase Insuficiencia hepática · min 36:13 | Clase Insuficiencia hepática · min 37:37 | Clase Insuficiencia hepática · min 48:35

FUENTE Clase Insuficiencia hepática · min 16:19 | Clase Insuficiencia hepática · min 17:41 | Clase Insuficiencia hepática · min 27:58 | Clase Insuficiencia hepática · min 29:19 | Clase Insuficiencia hepática · min 31:23 | Clase Insuficiencia hepática · min 33:23

Clase Insuficiencia hepática · min 35:31

Aguda vs crónica

IMPRESCINDIBLE

> La crónica es el estadio final de la cirrosis: predomina la encefalopatía crónica, con síndrome extrapiramidal.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

«Es un **diagnóstico diferencial**, **pregunta de examen puede ser**: la crónica se diferencia porque hay un **síndrome extrapiramidal**.»

FUENTE Clase Insuficiencia hepática · min 47:55

Aguda vs crónica (tapalo)

	Aguda	Crónica
INSTALACIÓN	Súbita, progresiva	**Gradual**
HÍGADO	Necrosis masiva	**Cirrosis** (estadio final)
CEREBRO	Edema cerebral (causa de muerte)	Encefalopatía crónica: neuropsiquiátrica
SIGNO DISTINTIVO	Ictericia + conciencia + asterixis	**Síndrome extrapiramidal** (parkinsonismo)
FALLA MULTIORGÁNICA	Masiva	Menor
DESENCADENANTE	Virus, paracetamol, tóxicos	**Precipitantes**: hemorragia digestiva, infecciones, diuréticos, hipopotasemia

FUENTE Clase Insuficiencia hepática · min 38:19 Clase Insuficiencia hepática · min 39:01 Clase Insuficiencia hepática · min 44:32 Clase Insuficiencia hepática · min 49:16 Clase Insuficiencia hepática · min 49:58

POR QUÉ EL EXTRAPIRAMIDAL

El amoníaco (y el manganeso) se acumulan en los **núcleos de la base** (sustancia negra, putamen, caudado): baja la **dopamina** y aparece un cuadro tipo Parkinson. Además: cambios de personalidad, deterioro intelectual, asterixis.

FUENTE Clase Insuficiencia hepática · min 42:30 Clase Insuficiencia hepática · min 43:11 Clase Insuficiencia hepática · min 44:32 Clase Insuficiencia hepática · min 45:12

FUENTE Clase Insuficiencia hepática · min 38:19 Clase Insuficiencia hepática · min 47:55

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

O'Grady

Para qué sirve: «No me la pueden no saber».

- Hiperaguda < 8 días
- Aguda 8–28 días
- Subaguda 4–24 semanas

Cómo interpretarlo: Se mide hasta que aparece la encefalopatía.

Mnemotecnia: «8 – 28 – 24»: una semana, un mes, medio año. — Los cortes de O'Grady.

Encefalopatía hepática

Para qué sirve: «Los van a bochar».

- Amoníaco → glutamina → edema cerebral
- Ictericia + conciencia + asterixis

Cómo interpretarlo: El culpable es el amoníaco.

Mnemotecnia: Amarillo, dormido y aleteando. — Ictericia, alteración de la conciencia, asterixis.

Aguda vs crónica

Para qué sirve: Diferencial de examen.

- Aguda: súbita, necrosis, edema cerebral
- Crónica: gradual, cirrosis, extrapiramidal

Cómo interpretarlo: La crónica descompensa por precipitantes.

Mnemotecnia: Crónica = Cirrosis + Caminar como Parkinson. — Síndrome extrapiramidal en la crónica.

Integración: lo imprescindible

- Insuficiencia hepática: pérdida > 80–90 % de la función; mortalidad 40–80 %; trasplante.
- **O'Grady**: hiperaguda < 8 días · aguda 8–28 días · subaguda 4–24 semanas (hasta la encefalopatía).
- **Encefalopatía**: amoníaco → glutamina → **edema cerebral** (causa de muerte en la fulminante). Tríada: ictericia + conciencia + **asterixis**.
- Sistémicas: hemorragias, infecciones, hipoglucemia, acidosis metabólica, insuficiencia renal prerrenal.
- **Crónica**: estadio final de la cirrosis, gradual, **extrapiramidal**, precipitantes.

Desarrollos modelo

1. Defina insuficiencia hepática aguda y clasifíquela.

Pérdida súbita de más del 80–90 % de la función hepática, sin hepatopatía previa, con **encefalopatía**; mortalidad 40–80 %, trasplante.

O'Grady (desde el inicio de los síntomas hasta la encefalopatía): **hiperaguda** < 8 días · **aguda** 8–28 días · **subaguda** 4–24 semanas. **Bernuau** (desde la ictericia): **fulminante** < 2 semanas · **subfulminante** 2–12 semanas.

2. ¿Qué es la encefalopatía hepática, por qué se produce y cómo se clasifica?

Síndrome neuropsiquiátrico por el **amoníaco** que el hígado insuficiente no convierte en urea: atraviesa la barrera hematoencefálica, en el cerebro se forma **glutamina** (osmótica) → **edema cerebral** e hipertensión endocraneana (principal causa de muerte en la fulminante).

Tríada: ictericia + alteración de la conciencia + **asterixis**. **Grados:** 0 subclínica · I alteraciones leves y del sueño · II letargo, asterixis · III estupor · IV coma.

3. ¿Qué es la insuficiencia hepática crónica? Diferénciela de la aguda.

Estadio final de la **cirrosis**: instalación gradual, predominio de la **encefalopatía crónica** (neuropsiquiátrica) con **síndrome extrapiramidal**; suele descompensarse por precipitantes (hemorragia digestiva, infecciones, diuréticos). La **aguda** es súbita, con necrosis masiva, edema cerebral y falla multiorgánica.

Preguntas de repaso (choice)

1. Según O'Grady, una insuficiencia hepática con encefalopatía a los **5 días** del inicio es:
    A. Crónica.
    B. Subaguda.
    C. Hiperaguda.
    D. Aguda.

2. La sustancia responsable de la encefalopatía hepática es:
    A. El colesterol.
    B. La urea.
    C. El amoníaco.
    D. La bilirrubina indirecta.

3. El signo motor más característico de la encefalopatía hepática es:
    A. El signo de Babinski.
    B. El temblor de reposo.
    C. La rigidez de nuca.
    D. La asterixis (temblor aleteante).

4. La causa de muerte más frecuente en la falla hepática fulminante es:
    A. La hipoglucemia.
    B. La ascitis.
    C. La ictericia.
    D. El edema cerebral con hipertensión endocraneana.

5. El paciente con insuficiencia hepática sangra porque:
    A. Tiene demasiadas plaquetas.
    B. Hay exceso de albúmina.
    C. El hígado no fabrica factores de coagulación.
    D. Por el amoníaco.

6. ¿Qué fármaco advierte el profe que puede producir una falla hepática fulminante por automedicación?
    A. Paracetamol (más de 6 g/día).
    B. Omeprazol.
    C. Amoxicilina.
    D. Metformina.

7. Lo que distingue a la insuficiencia hepática **crónica** de la aguda es:
    A. La ictericia.
    B. La necrosis masiva.
    C. El síndrome extrapiramidal.
    D. El edema cerebral.

8. El trastorno ácido-base típico de la insuficiencia hepática es:
    A. Acidosis respiratoria.
    B. Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria compensadora.
    C. Alcalosis metabólica pura.
    D. Ninguno.

Respuestas

1. **C** — Correcto (< 8 días).
2. **C** — Correcto.
3. **D** — Correcto.
4. **D** — Correcto.
5. **C** — Correcto.
6. **A** — Correcto.
7. **C** — Correcto.
8. **B** — Correcto.

CAPÍTULO 15

Pancreatitis aguda

La bilis que vuelve y activa las enzimas: causas (cálculos y alcohol), dolor en hemicinturón, Cullen y Grey-Turner, hemoconcentración, Ranson y Balthazar.

NECESITÁS SABER

- Abdomen agudo (dig-02)
- Vía biliar (dig-11)

Pancreatitis aguda

«Pancreatitis aguda la preguntan en el **choice**, en el **oral** y en el **final**: tienen que sabérsela **como la palma de la mano**.» Y lo que más marca: las **causas más frecuentes**, **Cullen y Grey-Turner**, la **hemoconcentración** y los criterios de **Ranson** y **Balthazar** («si no me saben esto, **lo van a bochar**»).

Por qué ★
Cálculos (mujer) + alcohol (hombre) = 80 % · Reflujo de bilis · Autodigestión

Clínica ★
Dolor en hemicinturón · Vómitos · Cullen / Grey-Turner

Sistémica
Hemoconcentración · Derrame pleural izquierdo · IRA prerrenal

Diagnóstico
Amilasa × 3 · Lipasa: más específica · TAC

Gravedad ★
Ranson 5 + 6 · Balthazar (TAC)

AL TERMINAR VAS A PODER

- Explicar la pancreatitis como autodigestión por reflujo de bilis (cálculo en la ampolla o alcohol en el Oddi).
- Reconocer el dolor en hemicinturón y los signos del abdomen (Cullen, Grey-Turner, Chauffard, asa centinela).
- Deducir las manifestaciones sistémicas (hemoconcentración, derrame pleural izquierdo, IRA prerrenal).
- Pedir los estudios correctos y calcular Ranson y Balthazar.

Causas y mecanismo: la bilis que vuelve

IMPRESCINDIBLE

> Las enzimas se activan dentro del páncreas porque les llega bilis. Cálculos (mujer) y alcohol (hombre): el 80 %.

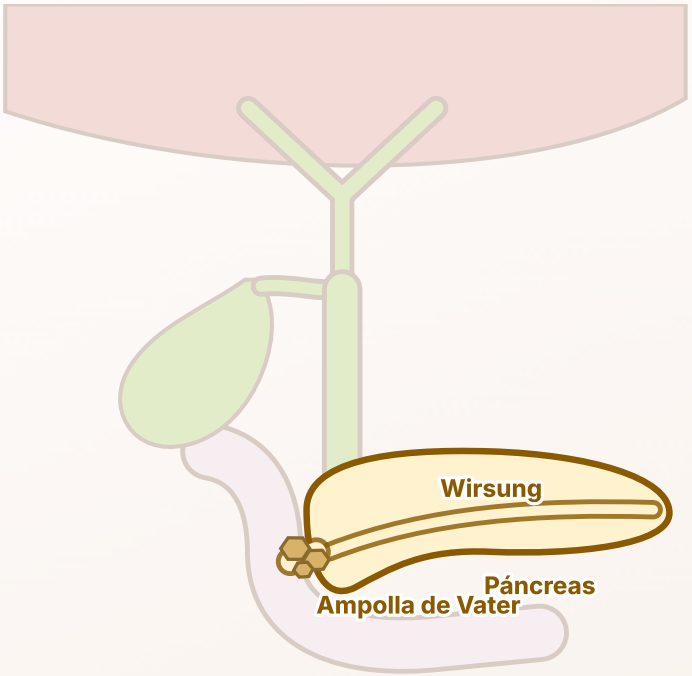
PREGUNTA DE PARCIAL

«**Pregunta de examen y lo van a preguntar en el parcial**: cuáles son las causas más frecuentes.» Los **cálculos de la vía biliar** (la más frecuente, sobre todo en la **mujer**) y el **alcoholismo crónico** (la segunda, sobre todo en el **hombre**): «**el 80 %** de las pancreatitis agudas».

FUENTE · Clase Pancreatitis aguda · parte 1 · min 01:30 · Clase Pancreatitis aguda · parte 1 · min 02:14

Tocá cada causa y mirá dónde actúa

Cálculo en la ampolla de Vater | Alcohol: contrae el esfínter de Oddi | Ampuloma (tumor de la ampolla)



Cálculo en la ampolla de Vater

Causa **n.º 1**. La bilis refluye al Wirsung y activa las enzimas; además da un **síndrome coledociano** (la bilis tampoco sale).

Las enzimas «no se activan porque quieren»: las activa la **bilis**. Directas: traumatismo de abdomen.

Edematosa vs necrohemorrágica (tapalo)

	Edematosa	Necrohemorrágica
FRECUENCIA	90–95 %	La minoría
QUÉ HAY	Edema del intersticio (exudado inflamatorio)	Necrosis y hemorragia intrapancreática
EVOLUCIÓN	Leve	«Muy fea, muy grave»: falla multiorgánica
CULLEN / GREY-TURNER	No	Sí (hemorragia retroperitoneal)

FUENTE Clase Pancreatitis aguda · parte 1 · min 02:14 · Clase Pancreatitis aguda · parte 1 · min 02:59 · Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 05:47

¿Y LA CRÓNICA?

«La crónica no se la toman.» Se diferencia porque en vez de edema o necrohemorragia tiene **calcificaciones**.

FUENTE Clase Pancreatitis aguda · parte 1 · min 00:02

FUENTE Clase Pancreatitis aguda · parte 1 · min 00:46 · Clase Pancreatitis aguda · parte 1 · min 03:41 · Clase Pancreatitis aguda · parte 1 · min 05:48 · Clase Pancreatitis aguda · parte 1 · min 07:16 · Clase Pancreatitis aguda · parte 1 · min 08:43

Clínica: el dolor y lo que se ve en el abdomen

IMPRESCINDIBLE

> Dolor epigástrico brusco, intensísimo, en hemicinturón hacia el dorso, que no calma con analgésicos comunes.

COMIENZO

Brusco

Agudo, de **muy brusca aparición**; «no lo deja estar».

IRRADIACIÓN

En hemicinturón

Del epigastrio al **hipocondrio izquierdo** y al dorso (**D7/D8 a D12**); **transfixiante**, «como si lo apuñalaran».

INTENSIDAD

≥ 7–8 / 10

No calma con analgésicos comunes; la **morfina** algo. Alivia la **plegaria mahometana**.

AGRAVANTES

Comida y alcohol

Comidas copiosas y ricas en grasa (colecistoquinéticas), el **alcohol**.

El abdomen del paciente con pancreatitis

Dolor en hemicinturón

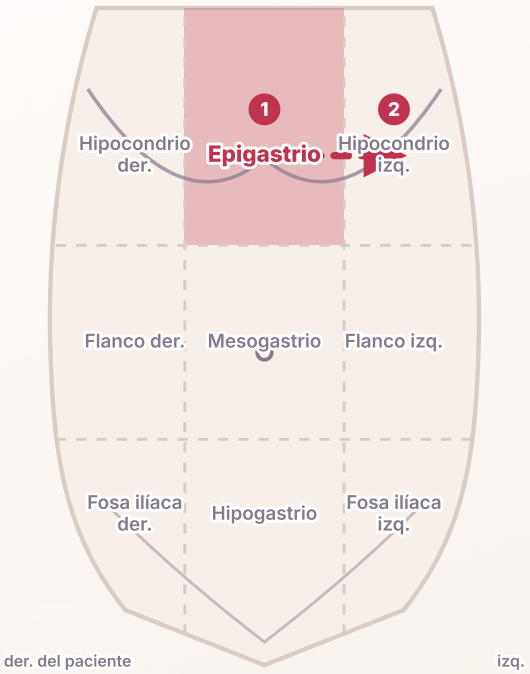
Zona coledocopancreática de Chauffard

Punto pancreático de Desjardins

Signo de Cullen

Signo de Grey-Turner

Asa centinela



Dolor en hemicinturón

Epigastrio → hipocondrio izquierdo → dorso, «de forma de cinturón».
Transfixiante.

Zonas y puntos: el profe pide Chauffard y Desjardins. Los límites anatómicos de cada uno son los clásicos de semiología.

PREGUNTA DE PARCIAL: CULLEN Y GREY-TURNER

«Lo que estoy por marcar es **pregunta de parcial**»: **Cullen** (hemorragia periumbilical) y **Grey-Turner** (en los flancos) son hemorragias **retroperitoneales** que aparecen en la **necrohemorrágica**, **no** en la edematosa. Y **no son patognomónicos**: también los da un embarazo ectópico complicado.

FUENTE Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 05:02

Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 05:47

ABDOMEN AGUDO INFLAMATORIO, PERO...

Lo que dice el profe

- «Lean **abdomen agudo inflamatorio**»
- **3.ª causa**: 1.º apendicitis, 2.º colecistitis
- Irritación peritoneal: **Blumberg** o **Gueneau de Mussy**

Lo que agrega el libro

- Defensa **muy discreta** para la intensidad del dolor
- **Sin contractura** (a diferencia de la úlcera perforada)
- «**Abdomen agudo blando**», RHA disminuidos

SÍNTOMA N.º 2: EL VÓMITO

Náuseas y **vómitos** (alimenticios o biliosos): el síntoma más frecuente **después del dolor**.

FUENTE Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 04:16

FUENTE Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 00:43 Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 01:27 Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 02:10 Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 02:52 Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 03:34 Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 06:32 Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 12:51 Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 15:41 Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p409

De la inflamación local a la falla multiorgánica

MUY IMPORTANTE

> Pierde líquido pero queda hemoconcentrado: ↑ hematocrito, IRA prerrenal, shock. Más derrame pleural izquierdo.

PARA EL PARCIAL Y EL ORAL

«Estos pacientes tienen **hipovolemia** por la deshidratación pero con un cuadro de **hemoconcentración**: eso **pueden preguntar en el parcial, en el oral**.» Hay más glóbulos rojos que suero: ↑ **hematocrito**.

FUENTE Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 10:05

Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 10:46

PULMÓN

Derrame pleural izquierdo

La **cola** del páncreas irrita el diafragma izquierdo y la pleura. Al examen: **matidez** en la base izquierda.

RIÑÓN

IRA prerrenal

Por la deshidratación: **oliguria** o anuria.

CIRCULACIÓN

Hipotensión y shock

↓ retorno venoso → ↓ gasto cardíaco → **shock hipovolémico**; taquicardia.

METABOLISMO

Hiperglucemia

Daño de los **islotes de Langerhans**: falta insulina.

METABOLISMO

Hipocalcemia

El calcio se consume en la **saponificación** de la grasa necrosada alrededor del páncreas.

SANGRE

Trombosis y CID

Por la **hemoconcentración**: «más elementos formes que líquido».

FIEBRE

Si el paciente tiene **fiebre**, hay que pensar en una **infección**. La ictericia aparece por el cálculo (obstrucción de la ampolla).

FUENTE Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 14:15

Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 09:23

FUENTE Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 07:57 | Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 08:41 | Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 09:23 | Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 11:26 | Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 12:08 | Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 14:58

Laboratorio e imágenes

MUY IMPORTANTE

> Siempre dos cosas: laboratorio y estudio por imagen. Se pide amilasa; la lipasa es más específica pero cara. TAC.

AMILASA VS LIPASA

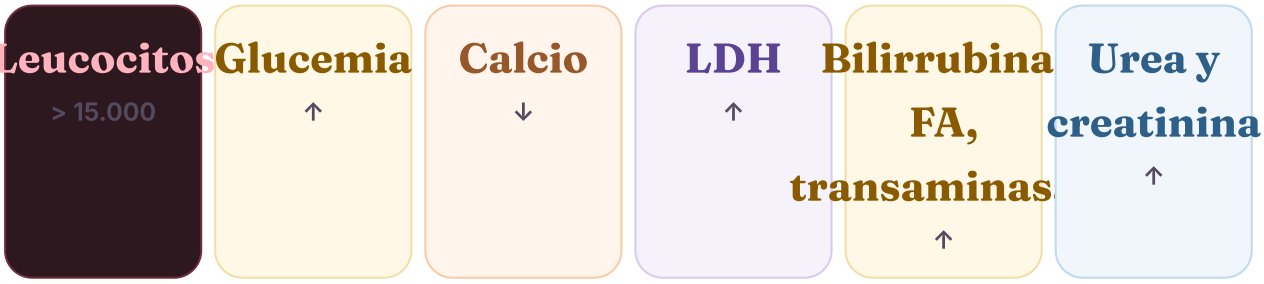
Amilasa

- **La que se pide** («aquí y en cualquier parte de la Argentina»)
- Diagnóstico: **× 2–3** (libro: **≥ 3 veces** el valor normal)
- Sube en 1 h y baja desde el 3.er día, cuando aparece la **amilasuria**
- No es exclusiva: úlcera perforada, colecistitis, ectópico, obstrucción

Lipasa

- **10 veces más específica**
- Queda elevada más tiempo
- **Muy cara**
- Solo cuando el cuadro es confuso y no se confirma

El resto del laboratorio (todo vuelve en Ranson)



Tocá un escalón para ver el detalle.

Imágenes

RX DE ABDOMEN

Asa centinela

Un asa distendida, aislada (íleo regional). Poco fidedigna.

RX DE TÓRAX

Derrame pleural izquierdo

TAC ★

La más usada

Grado de inflamación y necrosis: **criterios de Balthazar**.

FUENTE Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 16:22 · Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 17:03 · Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 17:45 · Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 18:26 · Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 19:08 · Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 19:49 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p409

Gravedad: Ranson y Balthazar

IMPRESCINDIBLE

> Ranson: 5 criterios al ingreso + 6 a las 48 h. ≥ 4 = severa. Balthazar: lo que muestra la TAC.

SI NO LOS SABEN, LOS BOCHAN

«Esto es **pregunta de parcial. No me pueden no saber los criterios de Balthazar, no me pueden no saber los criterios de Ranson.** Si no me saben esto, **lo van a bochar**.» Y aclara que en el parcial preguntan **solo Ranson** (hoy se usan otros, pero no los pide).

FUENTE Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 20:30 · Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 24:36

◎ Calculá el Ranson (pancreatitis no biliar)

Ingreso · Edad > 55 años	No (0)	Sí (1)
Ingreso · Leucocitos > 16.000/mm³	No (0)	Sí (1)
Ingreso · Glucemia > 200 mg/dl	No (0)	Sí (1)
Ingreso · GOT > 250 UI/l	No (0)	Sí (1)
Ingreso · LDH > 350 UI/l	No (0)	Sí (1)

48 h · Hematocrito cae > 10 %	No 0	Sí 1
48 h · Uremia sube > 5 mg/dl	No 0	Sí 1
48 h · PaO_2 < 60 mmHg	No 0	Sí 1
48 h · Déficit de base > 4–5 mEq/l	No 0	Sí 1
48 h · Calcemia < 8 mg/dl	No 0	Sí 1
48 h · Retención de líquido > 6 l	No 0	Sí 1

0 **Leve**

Hasta **3 criterios**: mortalidad ≈ **3 %**.

Leve: 0–3 | Severa: 4–6 | Severa, muy alta mortalidad: 7–11

Valores de la tabla de Ranson del libro (p. 410), la misma que muestra el profe. Truco: casi todo lo que se pide en el laboratorio está en Ranson.

Al ingreso: no biliar vs biliar (tapalo)

	No biliar (alcohol)	Biliar (cálculos)
EDAD	> **55** años	> **70** años
LEUCOCITOS	> **16.000**/mm³	> **18.000**/mm³
GLUCEMIA	> **200** mg/dl	> **220** mg/dl
GOT	> 250 UI/l	> 250 UI/l
LDH	> **350** UI/l	> **400** UI/l
A LAS 48 H	**Idénticos** en las dos	**Idénticos** en las dos

«Lo único que varía es el ingreso»: a las 48 h los seis criterios son los mismos.

FUENTE Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 21:53 | Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 23:14

Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p410

¿HEMOCONCENTRACIÓN O HEMATOCRITO QUE CAE?

No se contradicen. **Al ingreso** el paciente está deshidratado y **hemoconcentrado** (Hto alto). El criterio de Ranson mira **a las 48 h**: que el hematocrito **caiga más de 10 %** (tras la hidratación, o porque sangra) es de mal pronóstico.

FUENTE Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 22:34

Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p410

E G L A G

Tocá para desplegar

Los **5 del ingreso** (no biliar). Los **6 de las 48 h**: «**Ca**lcio, **Hto**, **O_2**, **ba**se, **u**rea, **líq**uido».

Balthazar: grados en la TAC (escala estándar)

A · 0	B · 1	C · 2	D · 3	E · 4
Páncreas normal	Páncreas agrandado	Inflamación peripancreática	Una colección líquida	Dos o más colecciones, o gas

◂ Leve — Grave ▸

Tocá un escalón para ver el detalle.

El profe pide saber Balthazar y para qué sirve (grado de inflamación y necrosis, y mortalidad); el libro solo lo nombra. Los grados son los de la escala original.

◎ Índice de severidad tomográfico (Balthazar + necrosis)

Grado de Balthazar	A (0)	B (1)	C (2)	D (3)	E (4)
Necrosis del páncreas	No (0)	< 30 % (2)	30–50 % (4)	> 50 % (6)	

0 **Leve**

Leve: 0–3 | Moderada: 4–6 | Grave: 7–10

Puntaje estándar (0–10). Suma el grado de inflamación y el porcentaje de necrosis.

FUENTE Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 20:30 | Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 21:11 | Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 21:53 | Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 22:34 | Clase Pancreatitis aguda · parte 2 · min 23:14 | Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p410

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Causas y mecanismo

Para qué sirve: «Pregunta de parcial».

- Cálculo en la ampolla (mujer)
- Alcohol → Oddi (hombre)
- = 80 %
- Bilis que refluye → autodigestión

Cómo interpretarlo: Las enzimas las activa la bilis.

Mnemotecnia: Piedra o copa: la bilis vuelve. — El cálculo tapa la ampolla, el alcohol cierra el Oddi; en los dos casos la bilis refluye al páncreas.

Cullen y Grey-Turner

Para qué sirve: «Pregunta de parcial».

- Cullen: periumbilical
- Grey-Turner: flancos
- Necrohemorrágica
- No patognomónicos

Cómo interpretarlo: Son sangre retroperitoneal que llega a la piel.

Mnemotecnia: **Cullen = **C**entro (ombligo). Grey-**T**urner = cos**T**ados.** — Periumbilical y flancos.

Ranson

Para qué sirve: «Si no lo saben, los van a bochar».

- 5 al ingreso: edad, GB, glucemia, GOT, LDH
- 6 a las 48 h: Hto, urea, PaO_2, base, Ca, líquido
- ≥ 4 = severa

Cómo interpretarlo: 3 → 3 %, 4–6 → 15 %, > 6 → 40 % de mortalidad.

Mnemotecnia: 55 – 16.000 – 200 – 250 – 350 — Los cortes del ingreso en la no biliar (edad, leucocitos, glucemia, GOT, LDH).

Hemoconcentración

Para qué sirve: «Pueden preguntar en el parcial, en el oral».

- Pierde líquido → hipovolemia
- ↑ Hto (más glóbulos que suero)
- → IRA prerrenal, shock, trombosis

Cómo interpretarlo: Deshidratado pero con la sangre «espesa».

Mnemotecnia: Seco por fuera, espeso por dentro. — Hipovolemia con hematocrito alto.

Integración: lo imprescindible

- Autodigestión por **reflujo de bilis**: cálculo en la **ampolla de Vater** (mujer) o **alcohol** que contrae el Oddi (hombre): el **80 %**.

- **Edematosa** 90–95 %; **necrohemorrágica**: grave, con **Cullen** (periumbilical) y **Grey-Turner** (flancos), no patognomónicos.
- Dolor **epigástrico brusco en hemicinturón**, transfixiante, ≥ 7–8/10; plegaria mahometana. Vómitos: síntoma n.º 2.
- 3.ª causa de abdomen agudo inflamatorio (tras apendicitis y colecistitis). **Chauffard** y **Desjardins**; asa centinela.
- **Hemoconcentración** (↑ Hto), IRA prerrenal, shock, **derrame pleural izquierdo**, hiperglucemia, hipocalcemia.
- Se pide **amilasa** (× 3); la lipasa es más específica pero cara. **TAC** → **Balthazar**.
- **Ranson**: 5 al ingreso + 6 a las 48 h; **≥ 4 = severa** (15 %); > 6 ≈ 40 % de mortalidad.

Desarrollos modelo

1. Defina pancreatitis aguda. ¿Cuáles son sus causas más frecuentes y cómo la producen?

Inflamación aguda del páncreas por **activación de sus enzimas dentro de la glándula** (autodigestión), con daño de órganos vecinos y a distancia.

Causas más frecuentes (80 %): litiasis biliar (n.º 1, sobre todo en la mujer) y **alcoholismo crónico** (n.º 2, sobre todo en el hombre). Directas: traumatismo de abdomen.

Mecanismo: las enzimas las activa la **bilis**. Un **cálculo en la ampolla de Vater** (o un ampuloma) o el **alcohol que contrae el esfínter de Oddi** impiden la salida de la bilis, que **refluye** hacia el Wirsung. Formas: **edematosa** (90–95 %) y **necrohemorrágica** (grave).

2. Describa las manifestaciones clínicas y el examen físico de la pancreatitis aguda.

Dolor: brusco, epigástrico, en **hemicinturón** hacia el hipocondrio izquierdo y el dorso (D7/8–D12), **transfixiante**, intensísimo (≥ 7–8/10); no calma con analgésicos comunes; alivia la **plegaria mahometana**; lo agravan las comidas copiosas o grasas y el alcohol. **Náuseas y vómitos** (el 2.º síntoma).

Examen: abdomen agudo inflamatorio (Blumberg o Gueneau de Mussy; libro: defensa discreta, «abdomen agudo blando»); **Cullen** y **Grey-Turner** en la necrohemorrágica (no patognomónicos); **asa centinela** (íleo regional); dolor en la zona de **Chauffard** y el punto de **Desjardins**.

Sistémicas: deshidratación con **hemoconcentración**, IRA prerrenal, hipotensión y shock, **derrame pleural izquierdo**, hiperglucemia, hipocalcemia, CID, alteración de la conciencia.

3. Criterios de Ranson y de Balthazar: ¿qué evalúa cada uno?

Ranson (pronóstico, laboratorio). **Al ingreso** (no biliar): edad > 55, leucocitos > 16.000, glucemia > 200, GOT > 250, LDH > 350 (en la biliar: > 70, > 18.000, > 220, > 250, > 400). **A las 48 h** (iguales en las dos): caída del Hto > 10 %, aumento de la uremia > 5 mg/dl, PaO_2 < 60, déficit de base > 4–5, calcemia < 8, retención de líquido > 6 l.

Interpretación: 1–3 criterios leve; **≥ 4 severa**. Mortalidad: 3 criterios ≈ 3 %, 4–6 ≈ 15 %, > 6 ≈ 40 %.

Balthazar (TAC): grado de inflamación y de necrosis del páncreas, y con ello la mortalidad. Grados A (normal) a E (dos o más colecciones o gas); sumado a la necrosis da el índice de severidad (0–10).

4. ¿Qué estudios complementarios pide ante una sospecha de pancreatitis aguda?

Laboratorio: amilasa sérica (la que se pide; × 2–3, libro ≥ 3 veces) y amilasuria; **lipasa** (10 veces más específica, pero cara: si el cuadro es confuso); leucocitos > 15.000, calcio ↓, LDH ↑, bilirrubina, FA y transaminasas, urea y creatinina, glucemia ↑.

Imágenes: Rx de abdomen (**asa centinela**), Rx de tórax (derrame pleural izquierdo) y **TAC** (la más usada: Balthazar).

Preguntas de repaso (choice)

1. Las dos causas más frecuentes de pancreatitis aguda son:
    A. Hipertrigliceridemia e hipercalcemia.
    B. Traumatismo y fármacos.
    C. Virus y parásitos.
    D. Litiasis biliar y alcoholismo crónico.

2. Según la clase, lo que activa las enzimas dentro del páncreas es:
    A. El reflujo de bilis hacia el conducto pancreático.
    B. Las bacterias del duodeno.
    C. La insulina.
    D. El ácido del estómago.

3. El alcohol produce pancreatitis porque:
    A. Dilata el colédoco.
    B. Destruye los islotes de Langerhans.
    C. Contrae el esfínter de Oddi y la bilis refluye hacia el páncreas.
    D. Forma cálculos en la vesícula.

4. El dolor típico de la pancreatitis aguda es:
    A. Cólico en el hipocondrio derecho que va al hombro.
    B. Epigástrico, brusco, en hemicinturón hacia el dorso y transfixiante.
    C. Periumbilical que migra a la fosa ilíaca derecha.
    D. Lumbar que va a los genitales.

5. Sobre los signos de Cullen y Grey-Turner es **correcto**:
    A. Son patognomónicos de pancreatitis.
    B. Aparecen en la necrohemorrágica y no son patognomónicos.
    C. Aparecen en la forma edematosa.
    D. Cullen es en los flancos y Grey-Turner, periumbilical.

6. Al ingreso, el paciente con pancreatitis aguda grave suele tener:
    A. Hipervolemia con hemodilución.
    B. Hipovolemia con hemoconcentración (↑ hematocrito).
    C. Hipercalcemia.
    D. Hipoglucemia.

7. El derrame pleural de la pancreatitis aguda es típicamente:
    A. Derecho.
    B. Izquierdo.
    C. Nunca hay derrame.
    D. Bilateral simétrico siempre.

8. Sobre amilasa y lipasa:
    A. Ninguna sirve para el diagnóstico.
    B. La lipasa es más específica, pero se pide la amilasa por costo.
    C. La amilasa sube solo en la pancreatitis.
    D. La amilasa es más específica que la lipasa.

9. ¿Cuál de estos es un criterio de Ranson **a las 48 horas**?
    A. LDH > 350 UI/l.
    B. Glucemia > 200 mg/dl.
    C. Calcemia < 8 mg/dl.
    D. Edad > 55 años.

10. Un paciente con **5 criterios de Ranson** tiene una pancreatitis:
    A. Leve, mortalidad 3 %.
    B. Severa, con mortalidad cercana al 15 %.
    C. Mortalidad del 40 %.
    D. No se puede clasificar.

11. El estudio por imagen más usado, que permite aplicar los criterios de Balthazar, es:
    A. El ECG.
    B. La Rx de tórax.
    C. La Rx de abdomen.
    D. La TAC de abdomen.

Respuestas

1. **D** — Correcto: juntas, el 80 %.
2. **A** — Correcto: por un cálculo en la ampolla o por el Oddi contraído.
3. **C** — Correcto.
4. **B** — Correcto.

5. **B** — Correcto: también los da un embarazo ectópico complicado.
6. **B** — Correcto: «pueden preguntar en el parcial, en el oral».
7. **B** — Correcto: la cola del páncreas irrita el diafragma izquierdo.
8. **B** — Correcto.
9. **C** — Correcto.
10. **B** — Correcto (4–6 criterios).
11. **D** — Correcto.